

LES DETERMINANTS DE LA SANTE

L'objectif de cette présentation est de vous permettre d'avoir une représentation claire des facteurs qui influencent la santé.

A partir des années 70, les réflexions critiques autour du système de soins comme principal facteur explicatif de l'état de santé se sont développées pour donner naissance à une nouvelle approche (Cantoreggi & Simos, 2010) qui postule que **d'autres facteurs, externes au domaine sanitaire, contribuent à déterminer la santé de la population.**

Ainsi est née l'approche par les **déterminants de la santé.**

Les déterminants de la santé sont définis par l'OMS comme les « **facteurs personnels, sociaux, économiques et environnementaux qui déterminent l'état de santé des individus ou des populations** ».

Cette approche conceptuelle par les déterminants a été déclinée en **plusieurs modèles** qui ont évolués grâce aux apports de la recherche. En voici deux exemples.

Commençons avec le **modèle de Dahlgren et Whitehead (1991)** qui est sans doute le plus connu et le plus utilisé.

Il se compose de strates superposées que nous allons découvrir petit à petit.

Au centre, les **individus**, caractérisés par leur âge, leur genre et des facteurs constitutifs (génétiques par exemple), dont l'effet sur la santé est indéniable, mais qui sont généralement inchangeables.

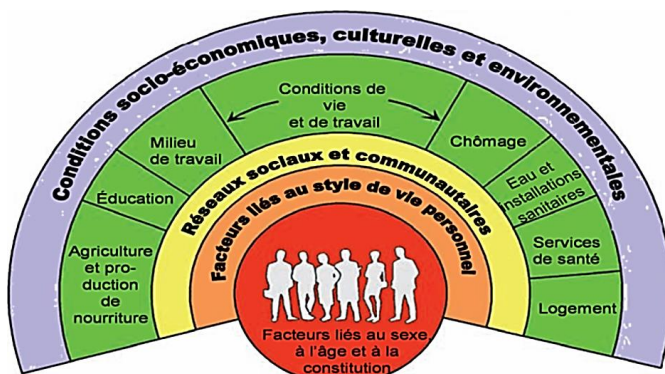
Immédiatement au-dessus, on trouve les **comportements individuels** et notamment les facteurs de risque (tabac, alcool et autres) dont on sait qu'ils affectent plus fréquemment les personnes les plus fragiles.

La strate suivante montre les **influences de la société, de la communauté et des réseaux sociaux** dans lesquels s'inscrivent les individus.

Dans la strate supérieure, on trouve les facteurs liés aux **conditions de vie et de travail, l'accès aux ressources, aux infrastructures et services essentiels, notamment ceux du système scolaire.**

Enfin, au-dessus de tous les autres niveaux, on trouve les **conditions socioéconomiques, culturelles et environnementales** présentes dans l'ensemble de la société.

"Policies and Strategies to promote social equity in health"



Modifié, d'après Dahlgren & Whitehead, 1991 (traduction)

L'intérêt de ce modèle en couches superposées est qu'il permet d'**appréhender simplement la question des déterminants de santé.** Par exemple, la situation économique d'un pays et le marché du travail ont un impact sur les possibilités de se loger, d'accéder à un travail, à des soins, etc., puis sur les strates inférieures.

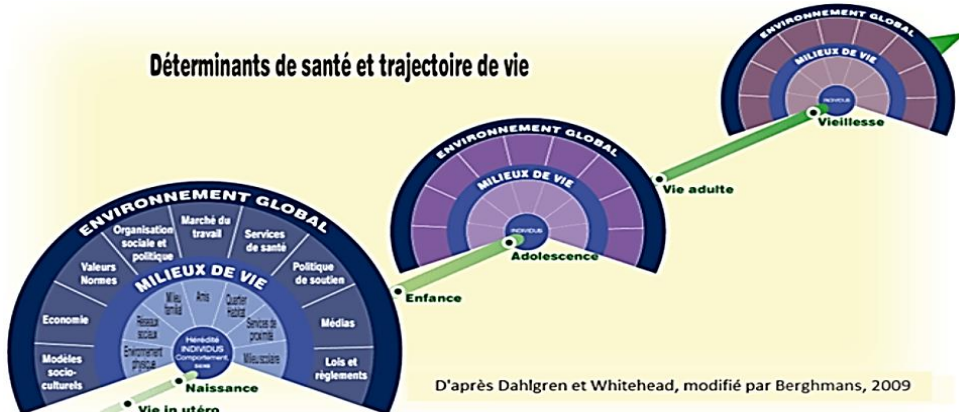
Les auteurs considèrent la **strate des conditions de vie et de travail** comme la principale source d'**inégalité** de santé mais toutes les strates, à l'exception des facteurs liés à l'âge, au sexe et à la constitution, sont susceptibles d'être touchées par l'action publique, le titre de leur article étant d'ailleurs assez explicite.

Dahlgren et Whitehead soulignent également la **dimension cumulative des dangers pour la santé.**

En effet, les populations fortement exposées à un facteur de risque ont tendance à **cumuler d'autres facteurs de risque** et peuvent ainsi rentrer dans un cercle vicieux quant à leur mauvais état de santé.

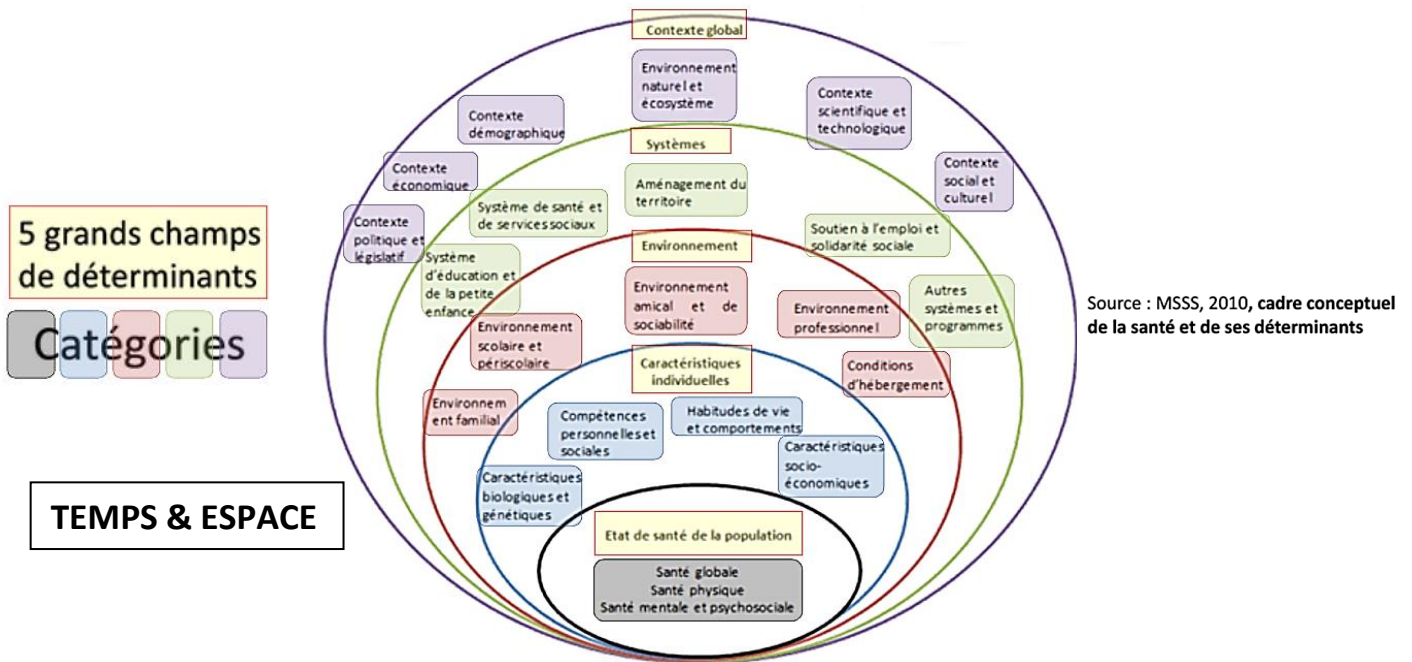
Ils montrent également comment une **forte exposition à des facteurs de risques pendant l'enfance** se traduit par une aggravation du risque de développer certaines maladies à l'âge adulte, ce qui amènera Berghmans, à ajouter au modèle la notion de **trajectoire de vie.**

Déterminants de santé et trajectoire de vie



D'après Dahlgren et Whitehead, modifié par Berghmans, 2009

La carte de la santé, et ses déterminants, qui est proposée dans le guide méthodologique de mise en œuvre du parcours éducatif de santé s’inspire du cadre conceptuel de la santé et de ses déterminants du Ministère de la Santé et des Services Sociaux du Québec.



Elle prend en compte les 20 années de recherches en la matière qui la sépare du modèle de *Dahlgren & Whitehead*.

Cette modélisation comprend **5 grands champs de déterminants** : le contexte global, les systèmes, l’environnement, les caractéristiques individuelles et le champ central qu’est l’état de santé de la population.

Ces champs sont ensuite déclinés en **catégories**. Le contexte global, les systèmes de programmes et de services, l’environnement et les caractéristiques individuelles s’influencent mutuellement. Les champs sont donc perméables, en interaction et les liens ne sont pas unidirectionnels.

L’analyse des déterminants, qu’ils soient individuels, liés à l’environnement, aux systèmes en place ou au contexte global, doit se situer dans le **temps** puisque les choses changent et dans l’**espace** puisque l’importance d’un déterminant varie d’un lieu à un autre.

Les 2 modèles que nous venons de vous présenter sont avant tout des modèles pour penser les inégalités en matière de santé au niveau de la société. On y repère aisément la place stratégique de l’**Ecole**, dans la couche centrale du **modèle de Dahlgren et Whitehead** et à l’interface des systèmes et des individus dans la **carte de la santé**.



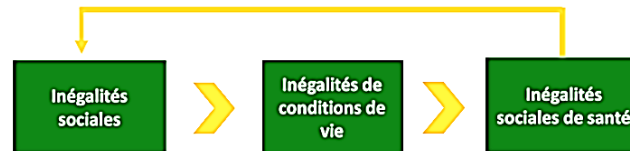
La santé comme un « construit » dynamique (Cantoreggi & Simos, 2010)

Dans ces 2 modèles, la logique d’emboîtement des niveaux, traduit bien l’idée de la santé comme un **«construit» dynamique** qui, du **particulier au général, façonne l’état physique et psychique des individus**. Vous pourrez aisément vous appuyer sur leur présentation didactique pour étayer et argumenter vos projets d’éducation à la santé.

Liens entre inégalité sociale et santé

Ce module nous permettra d'entrevoir quelques clés de compréhension des inégalités sociales de santé en population générale puis chez les enfants.

Les inégalités sociales présentes dans une société se traduisent en **inégalités de conditions de vie** et génèrent des **inégalités sociales de santé**, qui à leur tour, amplifient les **inégalités sociales**.



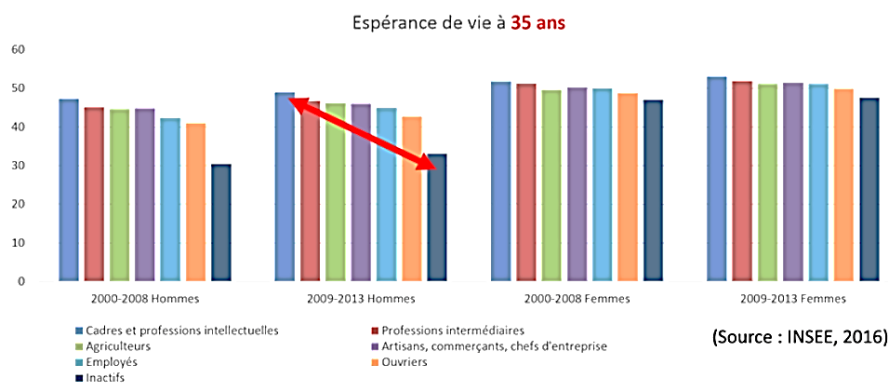
Production des inégalités sociales de santé : un modèle conceptuel synthétique (Hyppolite, 2012)

En France, malgré un bon état de santé moyen de la population avec une espérance de vie qui augmente, il existe d'**importantes inégalités** entre catégories socioprofessionnelles.

L'**indicateur d'espérance de vie à 35 ans** permet de mettre en évidence, d'une manière globale, les inégalités importantes de **risque de décès** existant entre les catégories sociales. Si toutes les catégories sociales ont connu une **amélioration** de leur espérance de vie à 35 ans, ce sont toujours les **cadres** qui ont l'espérance de vie la plus longue, atteignant **49 ans chez les hommes** et **53 ans chez les femmes**.

La France est le pays où les **inégalités sociales** de mortalité et de santé sont **les plus élevées en Europe occidentale** et celles-ci n'ont pas eu tendance à régresser ces dernières années, contrastant avec l'amélioration du niveau moyen de l'état de santé (Thierry Lang, 2014).

■ Pas de tendance à la baisse des inégalités sociales de santé (Lang, 2014)



Quelle que soit leur catégorie sociale, les **femmes vivent plus longtemps que les hommes** et les écarts entre les catégories socioprofessionnelles sont moins importants que chez les hommes.

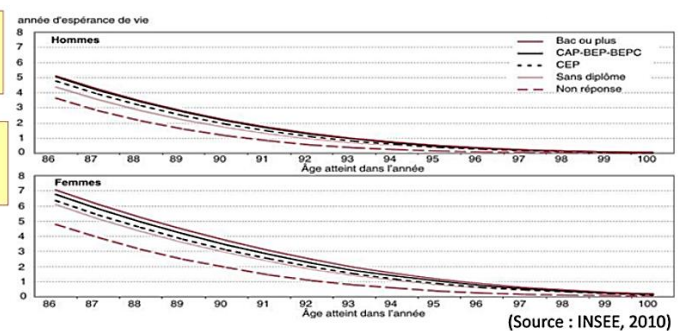
L'écart d'espérance de vie à l'âge de 35 ans entre les femmes **cadres supérieures** et les **ouvrières** est faible soit 3,2 ans.

Mais attention, pour une ouvrière, sur ses 49 ans d'espérance de vie, seulement 25 se dérouleront sans incapacité, alors qu'une femme cadre supérieure, peut, elle, s'attendre à vivre 34 ans **sans incapacité** sur ses 53 ans d'espérance de vie.

L'**espérance de vie sans incapacité** est d'autant plus réduite pour les catégories sociales défavorisées.

Espérance de vie des hommes et des femmes à l'âge de 35 ans selon la catégorie sociale				
Unité : années	Femmes 2000-2008	Femmes 2009-2013	Hommes 2000-2008	Hommes 2009-2013
Cadres sup.	51,7	53	47,2	49
Prof. interm.	51,2	51,9	45,1	46,7
Agric.	49,6	51,1	44,6	46,2
Artis., commerc. et chefs d'entrep.	50,3	51,4	44,8	46
Employés	49,9	51,1	42,3	44,9
Ouvriers	48,7	49,8	40,9	42,6
Inactifs	47	47,6	30,4	33,1
Ensemble	49,4	50,5	42,8	44,5
Ecart entre cadres sup. et ouvriers	3	3,2	6,3	6,4

(Source : INSEE, 2016)



2 autres indicateurs, directement en lien avec les **questions d'éducation**, se révèlent être pertinents pour illustrer la relation entre inégalités sociales et santé.

Le 1^{er} est le **niveau d'études** : plus le niveau de diplôme est élevé moins les risques annuels de mortalité sont importants.

Le 2^{ème} est le **niveau d'intégration sociale**. Une étude (cohorte GAZEL) réalisée entre 1993 et 1999 a conclu que le risque de mortalité par cancer ou le risque de mortalité par suicide et accidents est d'autant plus élevé que le niveau d'intégration sociale est faible.

Les inégalités sociales de santé présentes à l'âge adulte s'observent également dès le plus jeune âge et ont un impact conséquent sur la santé des **enfants** comme l'indique un rapport publié par la DREES en 2014.

En effet, l'enfance constitue une période particulière en termes de santé dans la mesure où **un grand nombre d'habitudes y sont acquises**, mais aussi en raison des risques à long terme. Les inégalités sociales de santé sont **déjà présentes à la naissance** et se creusent durant l'enfance. Les indicateurs de santé rendent compte de fortes disparités selon le milieu social.

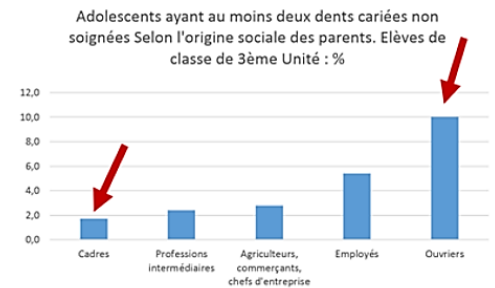
L'obésité, la santé buccodentaire et la santé mentale en sont trois marqueurs représentatifs. L'obésité, la santé buccodentaire et la santé mentale en sont trois marqueurs représentatifs.

Les inégalités sociales se retrouvent dans la bouche des enfants.

Comme pour l'état de santé en général, l'origine sociale joue un rôle très net en matière de **santé bucco-dentaire**.

En effet, les données montrent qu'en classe de 3^{ème}, 10 % des enfants d'ouvriers ont des **dents cariées** (soignées ou non), soit **6 fois plus que ceux de cadres**.

La santé bucco-dentaire est un **excellent marqueur des inégalités sociales** (DREES, 2014), à l'instar de l'obésité et du surpoids.

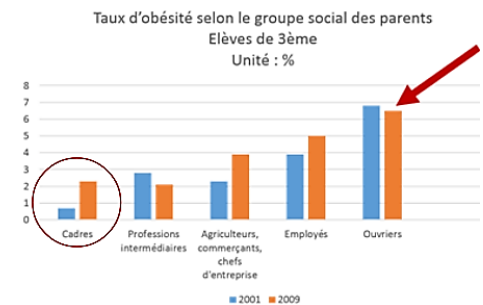


L'obésité, au-delà de la perspective biomédicale est un **marqueur social**.

Elle **touche inégalement les catégories sociales, les sexes et les zones géographiques**.

Sa prévalence est moins élevée chez les enfants dont le père est cadre par rapport aux enfants d'ouvriers.

Selon une étude menée auprès des élèves en classe de 3^{ème}, **2,3 %** d'enfants de cadres souffrent d'obésité, contre **6,5 %** d'enfants d'ouvriers.



En matière de **santé mentale**, on constate aussi la présence d'inégalités liées à la **position dans la hiérarchie sociale**.

Plusieurs études mettent en évidence le lien entre position sociale et le risque de problèmes de santé mentale.

L'étude de suivi GAZEL montre qu'un faible statut socio-économique rend prévisible une dépression à long terme.

Des études de cohorte sur la relation entre **insécurité alimentaire** et santé mentale et diverses autres études associent des événements négatifs à de **graves problèmes de santé mentale dans l'enfance**.

Des **formes banales de stress** dans la vie des enfants y compris les cas de **séparation des parents, l'isolement social par rapport aux pairs**, etc. et particulièrement leur **accumulation**, peuvent avoir une influence sur le comportement des enfants.

Et quelquefois, les conséquences sont **durables**.

A ce titre, Il semble important de rappeler que le nombre de décès par suicide est de plus de 10 000 par an en France, soit environ 3 fois plus que les décès par accident de la circulation.

Une des missions de **l'école** est de contribuer à réduire les inégalités.

Cependant, le système scolaire peut parfois entretenir et générer des inégalités comme nous l'apprend le rapport du Conseil national d'évaluation du système scolaire (Cnesco, 2016). Il convient donc de **maintenir un niveau de vigilance élevé sur ce sujet**.

En effet, les inégalités sociales de santé dans l'enfance sont intolérables, parce qu'elles ont des conséquences non seulement immédiates, mais aussi, sur la **durée et la qualité de vie des personnes devenues adultes**.

Mais attention, les inégalités sociales de santé ne sont **pas** synonymes de **pauvreté**. Elles se distribuent selon le **gradient social** et ne constituent pas une fatalité. C'est pourquoi :

« L'équité en général impose une juste solution à l'égard des inégalités, pas seulement pour les plus pauvres, mais pour tout le monde et à tous les niveaux » (Mooney, 2000).

LES COMPETENCES PSYCHOSOCIALES

Partie 1 : Les Compétences Psychosociales (CPS)

- De quoi parle-t-on ?
- Pourquoi un tel intérêt ?
- Focus sur les compétences émotionnelles et relationnelles en prévention des addictions

«Capacité d'une personne à répondre avec efficacité aux exigences et aux épreuves de la vie quotidienne» (OMS, 1993)

«Les compétences psychosociales sont à considérer comme des outils d'adaptation cognitive, émotionnelle, comportementale permettant à un individu de faire face aux situations de la vie en respectant les autres et en collaborant avec eux» (Jacques Fortin)

Une classification qui évolue

Classification d'origine (OMS, 1993) : **10 CPS (5 binômes)**

1. savoir résoudre des problèmes / savoir prendre des décisions;
2. avoir une pensée créative / avoir une pensée critique;
3. savoir communiquer efficacement / être habile dans les relations interpersonnelles;
4. avoir conscience de soi / avoir de l'empathie;
5. savoir réguler ses émotions / savoir gérer son stress.

Depuis les années 2000 (OMS) :

Une aptitude psychosociale générale (OMS 1997) :

« (...) C'est la capacité d'une personne à **maintenir un état de bien-être subjectif** qui lui permet d'adopter un **comportement approprié et positif** à l'occasion d'**interactions** avec les autres, sa culture et son environnement.»

⇒ Qui regroupe **3 grands types de CPS** (OMS, 2001, 2003)

- ✚ **Compétences émotionnelles**
- ✚ **Compétences cognitives**
- ✚ **Compétences sociales**

⇒ En réalité plutôt **3 dimensions des CPS** (Exemple de l'empathie : sociale car importante à la relation pour comprendre l'autre, mais aussi émotionnelle, et cognitive car il faut se projeter dans l'autre pour le comprendre)

Les principales CPS dans les programmes validés et selon les modèles théoriques actuels (Lamboy, 2017)

Compétences émotionnelles	Compétences cognitives	Compétences sociales
Connaître les émotions	S'auto-évaluer positivement	Communiquer de façon positives
Identifier les émotions	Savoir résoudre des problèmes	Développer des relations positives
Exprimer ses émotions		S'affirmer et résister à la pression sociale
Réguler ses émotions		Savoir résoudre des conflits

Compétences sociales	Compétences émotionnelles	Compétences cognitives
Communication verbale et non verbale : écoute active, expression des émotions, capacité à donner et recevoir des feedback, empathie...	Compétences de régulation émotionnelle : gestion de la colère et de l'anxiété, capacité à faire face à la perte, à l'abus et aux traumatismes	Compétences de prise de décision et de résolution de problème
Capacités relationnelles : gestion des conflits, résolution de problèmes relationnels, capacité d'affirmation, résistance à la pression d'autrui.	Compétences de gestion du stress qui impliquent la gestion du temps, la pensée positive et la maîtrise des techniques de relaxation	La pensée critique et l'auto-évaluation qui impliquent de pouvoir analyser l'influence des médias et des pairs, d'avoir conscience des valeurs, attitudes, normes, croyances et facteurs qui nous affectent, de pouvoir identifier les (sources d') informations pertinentes
Compétences de coopération et de collaboration en groupe	Compétences d'auto-évaluation et d'auto-régulation qui favorisent la confiance et l'estime de soi	
Compétences de plaidoyer qui s'appuient sur des compétences de persuasion et d'influence.		

Différents termes

Santé publique (prévention/promotion de la santé)

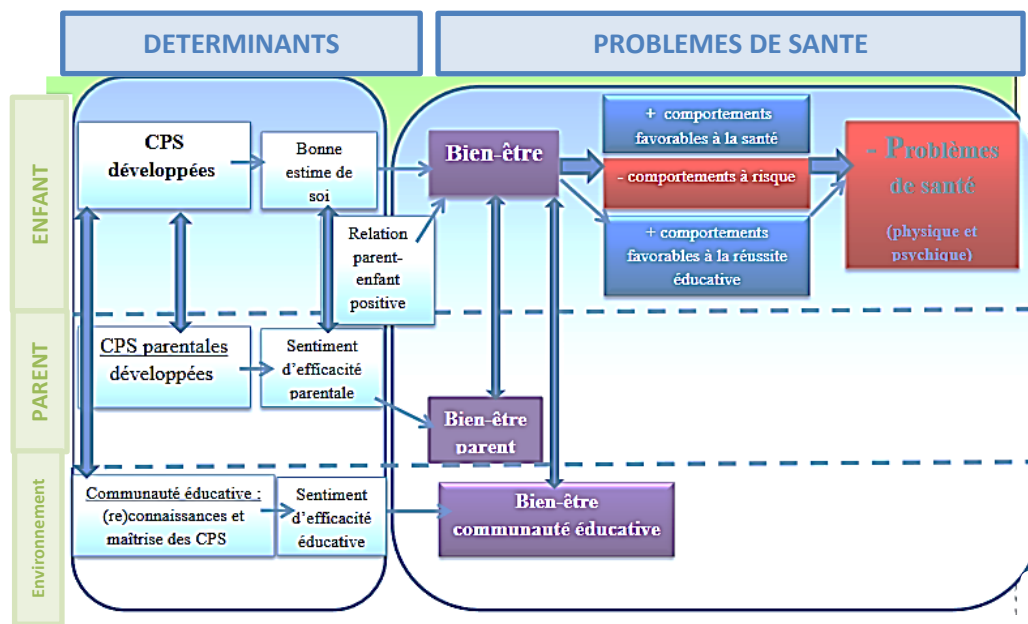
- Anglais : *life skills, psychosocial competences* (OMS)
- Français : *compétences psychosociales*
- Récemment : *social and emotional program* (SEP)

Education (et psychoéducation)

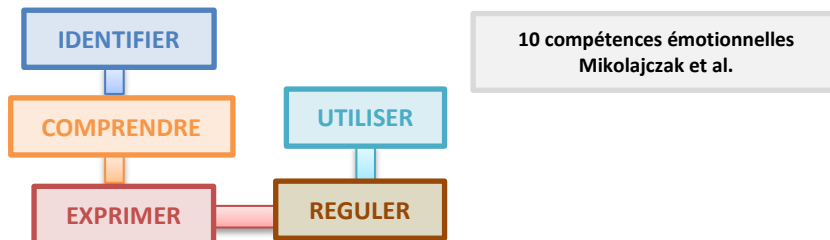
- Anglais : *social and emotional learning* (SEL, CASEL)
- Français : *(compétences psychosociales) ⇒ compétences sociales et civiques* (Education Nationale)

Psychologie (récemment) : *compétences émotionnelles, habiletés sociales*

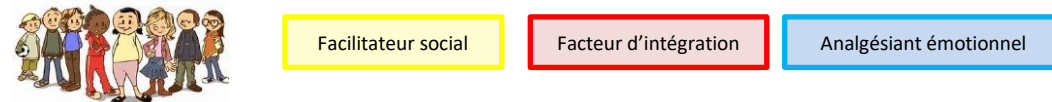
LES CPS : DETERMINANTS DE LA SANTE et de la réussite éducative



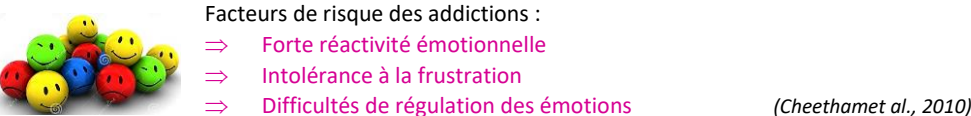
Focus sur les **COMPETENCES EMOTIONNELLES** et **RELATIONNELLES** en PREVENTION DES ADDICTIONS



Utilité des **COMPETENCES PSYCHOSOCIALES** en prévention des addictions : Les consommations utilisées pour réguler les émotions et les relations



Utilité de la **REGULATION DU STRESS ET DES EMOTIONS** en prévention des addictions

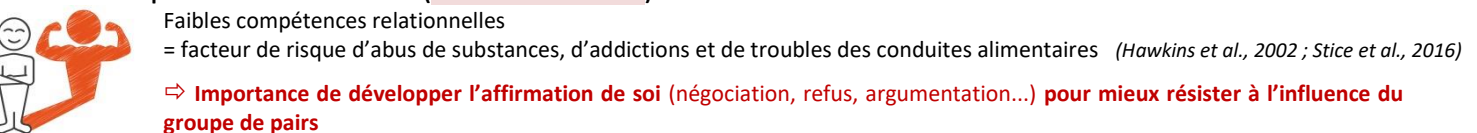


Régulation dysfonctionnelle des émotions : **ADDICTIONS**



⇒ Utilité de l'apprentissage de techniques de régulation des émotions

Déficit de compétences **RELATIONNELLES (AFFIRMATION DE SOI)**



Partie 2 : Les interventions CPS validées

- De quoi parle-t-on ?
- Quels effets sur la santé et le bien-être ?
- Exemples

Les interventions CPS validées (Evidence-Based SEL program)

Un cycle d'ateliers

- Chaque atelier aborde **1 CPS**
- **Structuré** : **manuel** (intervenant) et **livret** (participant)
- **Dans la durée** : séance hebdomadaire de 1h à 2h, minimum 10 séances (pluriannuel pour les enfants)

«Validé»

- **Intervention précise et définie** : manuels pour les professionnels (intervention, implantation) et livrets pour les participants
- **Efficacité démontrée**
 - ⇒ Résultats + sur le problème ou l'état de santé
 - ⇒ Démontrés par une recherche évaluative de qualité : Essai Contrôlé Randomisé (ECR) ou étude comparative quasi-expérimentale
 - ⇒ Résultats répliqués dans une seconde étude (autre contexte)

Effets des centaines de programmes CPS validés (enfants, adolescents et parents)

Effets finaux

- **Santé mentale** : moins de troubles affectifs et de comportement, meilleure santé mentale positive (bien-être)
- **Conduites à risque** : moins de consommation de substances (tabac, alcool, drogues), de violence, de harcèlement scolaire, des comportements sexuels à risque
- **Réussite éducative et professionnelle** : meilleurs résultats, moins d'échec scolaire, meilleurs diplômes, meilleure insertion sociale et professionnelle

Effets intermédiaires sur les déterminants de la santé

- **Développement des CPS** : sociales, émotionnels, cognitives
- **Meilleure estime de soi**
- **Meilleures relations** : soi, parents, école

Caractéristiques des interventions CPS validées

Reproduction des conditions naturelles d'apprentissage des compétences (psychosociales) : expérience, observation, imitation

Des méthodes pédagogiques interactives et expérientielles

Des adultes qui ont développé les CPS eux-mêmes ⇔ *processus de modeling*

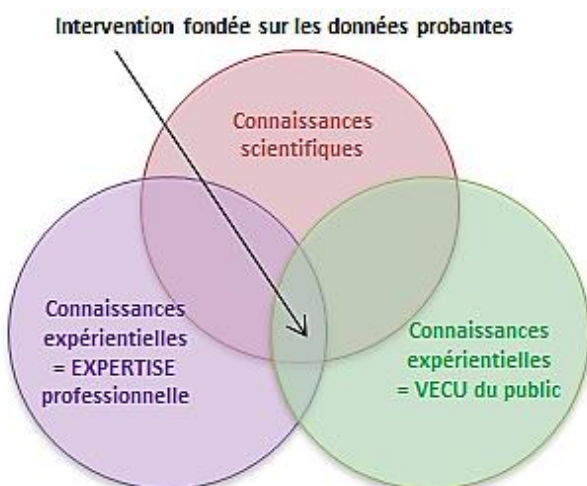
Des CPS choisies en fonction du problème de santé :

- *Ex. addictions* : régulation des émotions, affirmation de soi
- *Ex. santé sexuelle* : négociation, affirmation de soi, résolution de problème
- *Ex. violence* : empathie, régulation des émotions (colère)

Facteurs d'efficacité des interventions CPS

- Des **ateliers formels structurés**
- Des **pratiques informelles répétées** : pendant la journée, dans différents milieux (école, famille, communauté...)
- Des **interventions articulées** avec les autres interventions
- **Environnement constructif** : prévention du harcèlement, activités favorisant les relations positives

Représentation du paradigme des interventions fondées sur les données probantes



Fondements

- Données scientifiques sur les **facteurs de risque et de protection de la consommation de substances**
- **Modèles théoriques du développement/fonctionnement psychologique:** psychologie clinique, psychologie appliquée à l'éducation, psychologie sociale cognitive (Bandura)

Supports d'intervention (programme d'origine enfants 6-11 ans et parents)

- **Supports intervenants** (14 ateliers de 2h) : 14 fiches (groupe parents) + 14 fiches (groupe enfants) + 14 fiches (groupe famille)
- **Livret parents + livret enfants** (14 séances)

Effets démontrés (+ 100 études évaluatives dont + 20 ECR)

- Baisse de la consommation **substances** (enfants, parents)
- Baisse des problèmes de **santé mentale** (TC, dépression, anxiété)
- Baisse des problèmes de **comportements** (violence, délinquance)
- Amélioration du **climat familial, communication, attachement, efficacité parentale**
- Amélioration des **CPS enfants et résultats scolaires**

EXEMPLE TYPE 1 : programme CPS validé (addictions) *Programme SFP* (Kumpfer, USA, années 80)

Livret de l'intervenant

« Groupe des enfants »



Le programme de Soutien aux Familles et à la Parentalité
(SFP 6-11 ans)
Karol L. Kumpler, Ph.D.
Édition révisée, 2006

ACCUEIL	
<u>TABIE DES MATIÈRES</u> (Groupe des enfants)	
1. ACCUEIL	Séance 1
2. ECOUTER	Séance 2
3. PARLER	Séance 3
4. ENCOURAGER LES COMPORTEMENTS POSITIFS	Séance 4
5. DIRE « NON » POUR ÉVITER LES PROBLÈMES	Séance 5
6. COMMUNICATION I : DES RELATIONS HARMONIEUSES	Séance 6
7. COMMUNICATION II : PARLER POUR TROUVER DE L'AIDE	Séance 7
8. ALCOOL, TABAC, DROGUE ET ENFANTS	Séance 8
9. RÉSOUDRE DES PROBLÈMES	Séance 9
10. PRÉSENTATION DU JEU DES PARENTS	Séance 10
11. RECONNAÎTRE LES ÉMOTIONS	Séance 11
12. FAIRE ET ACCEPTER LES CRITIQUES	Séance 12
13. GÉRER SA COLÈRE	Séance 13
14. RESSOURCES, BILAN	Séance 14

III. Résoudre des problèmes, maîtriser et exprimer sa colère

A. Rappel sur la résolution des problèmes

(30 minutes)
5 minutes

Nous avons déjà appris à résoudre des problèmes. Nous pouvons nous en servir pour gérer la colère. Qui peut nous rappeler les cinq étapes pour résoudre un problème ?

1. Identifier le problème.
2. Déterminer ce que l'on veut qu'il arrive.
3. Dresser la liste de toutes les solutions possibles.
4. Choisir la meilleure idée, en fonction de ce qui pourrait arriver.
5. Appliquer l'idée pour voir si elle fonctionne.
6. Mettre en place une autre idée si la première ne fonctionne pas.

B. Maîtriser sa colère 10 minutes

Dites par exemple : Vous pouvez que quelque fois être en colère que vous ne savez pas quoi faire. Ce n'est pas une très bonne idée de parler à la personne après qui vous êtes en colère à ce moment-là. Vous devez d'abord « gérer » votre colère. Une fois votre colère gérée (et si le moment s'y prête), vous pouvez utiliser les aptitudes de communication que nous avons apprises auparavant pour exprimer votre colère de manière adaptée.

Gérer sa colère en cinq étapes :

Livret de l'enfant : Activité 1 (Séance 13)

1. **S'arrêter.**
C'est sans doute l'étape la plus importante. Lorsque vous sentez que vous allez perdre le contrôle, arrêtez-vous. Comment savoir

quand on est rendu à ce degré de colère ? (Vous élevez la voix, votre voix tremble, vous rougissez, vous avez des palpitations, vos mains tremblent, vous serrez les dents, vous respirez plus vite, vous avez chaud, vous souhaitez que tout le monde vous laisse tranquille, vous avez du mal à vous concentrer, etc.)

2. **Réfléchir à ce qui va venir si on perd le contrôle**
3. **Se demander pourquoi on est en colère exactement.**
Il s'agit d'une étape importante car elle vous évite de vous en prendre à la mauvaise personne. Si vous êtes en colère après un ami parce qu'il vous a cassé un jouet, ne rentrez pas à la maison pour courir sur votre famille. Réfléchissez c'est après votre ami que vous en avez eu le gâche cette colère.
4. **Se calmer.**
Comme il peut-on aller, se soigner ? Demandez pour les enfants de penser à s'aider de moyens qui le peuvent. Parmi ceux-ci : écouter la musique jusqu'à 10, parer de sa colère, faire une pause, marcher, prendre un bain, écouter la radio, lire un livre, assister à un concert de musique, faire le ménage, lire un magazine, penser à un bon moment partagé avec la personne après qui on est en colère, etc.

5. **Se récompenser.**
- Cette étape agréable consiste à vous accorder un petit plaisir car vous avez réussi à gérer votre colère. Que pouvez-vous faire pour vous récompenser d'avoir réussi à bien gérer votre colère ? (Faire quelque chose qui vous fait vraiment plaisir et qui ne coûte pas grand chose)

Adapté du livre de Hawkins, et al. (1995).

C. Exprimer sa colère

5 minutes

Livret de l'enfant : Activité 2 (Séance 13)

- Dites par exemple : Nous avons déjà parlé de la façon dont on peut exprimer ses émotions aux autres. Pourquoi est-ce important ? Dire à la personne après qu'on l'a vexé que vous êtes en colère après elle lui permet de comprendre vos émotions, cela peut être la première étape.

Développé et évalué dans 7 pays Européen

Implanté en France

Évalué région Orléans

En cours d'évaluation dans d'autres régions

⇒ Vous aurez une formation spécifique et détaillée concernant ce programme

GERER UN PROJET DE PREVENTION

PROJET = intention ou décision d'agir

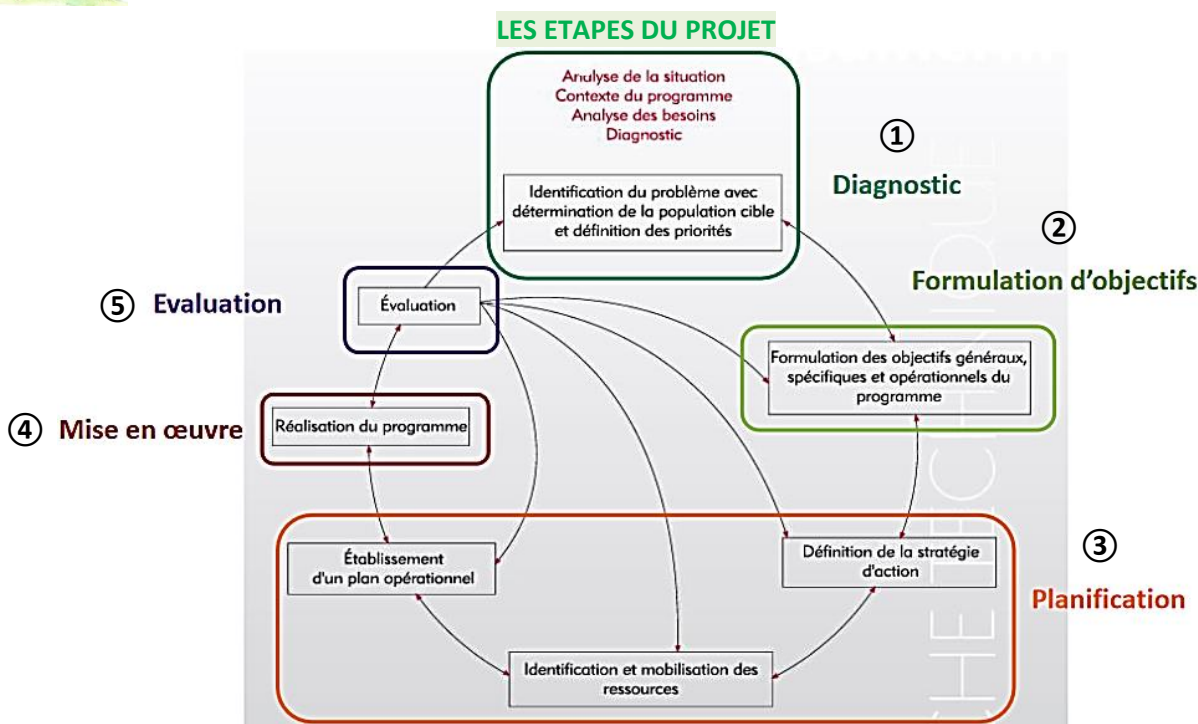
- Une action, un plan d'actions, un programme
- Initié par un commanditaire (la demande)

La gestion de projet est une démarche visant à organiser de bout en bout le bon déroulement d'un projet.



Les bonnes pratiques de la gestion de projet : Le modèle CORSE

- ✓ Calendrier
- ✓ Objectifs
- ✓ Responsable
- ✓ Suivi du projet
- ✓ Evaluation



Objectifs : Définir clairement les objectifs du projet

La population cible : qui, combien

Objectif général = le but à atteindre, la finalité

Ex : Promotion de la vaccination dans une population scolaire

Objectifs spécifiques

- Sensibiliser, informer
- Apporter des connaissances, former
- Combattre les fausses idées

Objectifs opérationnels = les choses à faire

- Des supports d'information : plaquette, affiche, etc.
- Ateliers de réflexion : vidéos, outils d'animation de groupe, jeux, etc.
- Conférence : exposé, débat, etc.
- Travail sur le carnet de vaccination (ex : mesvaccins.net)



Responsable

Désigner un «chef» de projet (un seul)

- Ayant le statut et les capacités de mener à bien le projet

Affecter des ressources (si nécessaire)

- Collaborateurs = groupe projet
- Temps (fixer une date de fin du projet)
- Moyens

Calendrier

Définir les tâches

- Inscrire les tâches dans le temps

Fixer une date de fin

- En accord avec le commanditaire
- Compatible avec les tâches à accomplir
- Modulable en fonction des difficultés rencontrées



SUIVI de projet



Interne au projet (chef de projet)

- Planifier les tâches à accomplir
- Suivre le plan

Externe au projet (commanditaire, décideur)

- Vérifier l'avancement du projet
- Identifier les difficultés, obstacles
- Adapter les ressources

Diagramme de Gantt

Outil de planification

- Identifier toutes les tâches (début, fin)
- Inscrire les tâches dans un calendrier

Outil de suivi du projet

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Définir les objectifs									
Recherche documentaire									
Choix/élaboration des supports									
Elaborer le plan, calendrier									
Mise en œuvre									
Evaluation									

EVALUATION



Vérifier que les objectifs ont été atteints

Objectifs OPERATIONNELS (facile)

Ex : Les ateliers ont été faits, les supports ont été diffusés, la population cible a été atteinte.

Objectifs GENERAUX (plus difficile)

Evaluation de critères intermédiaires

- Les connaissances sur les vaccins
- Les opinions sur les vaccins

Evaluation de critères de résultat

- La couverture vaccinale



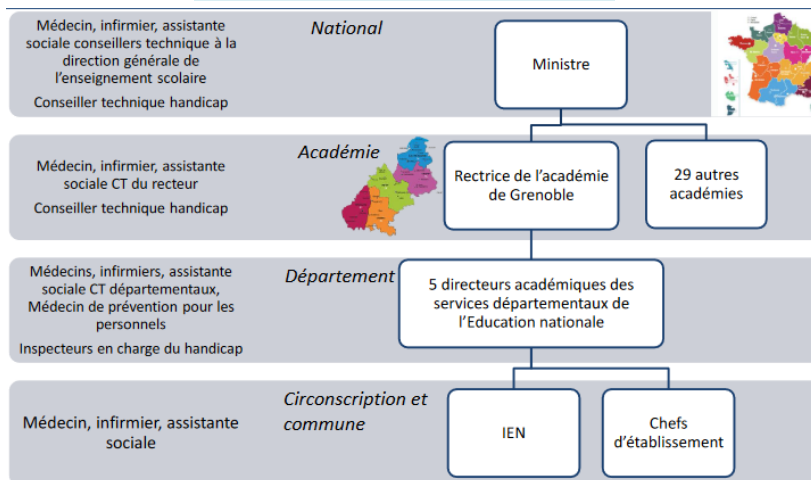
Points essentiels

- ♣ Pour gérer un projet il faut du bon sens et de la rigueur.
- ♣ Commencer par un diagnostic : définir l'objectif général (la finalité) et les objectifs opérationnels.
- ♣ Organiser le suivi du projet selon un calendrier prévisionnel.
- ♣ Définir l'évaluation de l'atteinte des objectifs dès le début du projet.



Promotion, éducation à la santé : rôle de l'éducation nationale

Organisation de l'Éducation Nationale



L'administration de l'Éducation Nationale est dirigée par le Ministre de l'EN de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.

Elle prend en charge 12 M d'élèves et est présente dans chaque département.

Ce sont les services déconcentrés du ministère de l'EN.

Son organisation s'articule autour de 17 régions académiques autour des recteurs (30 académies).

Le recteur est nommé par décret en conseil des ministres par le Président de la République, et pilote une académie.

Il est chargé de mettre en œuvre la politique nationale.

Il a autorité sur les personnels académiques et détient les pouvoirs de gestion et de contrôle sur l'ensemble des services et des établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat du primaire à l'université.

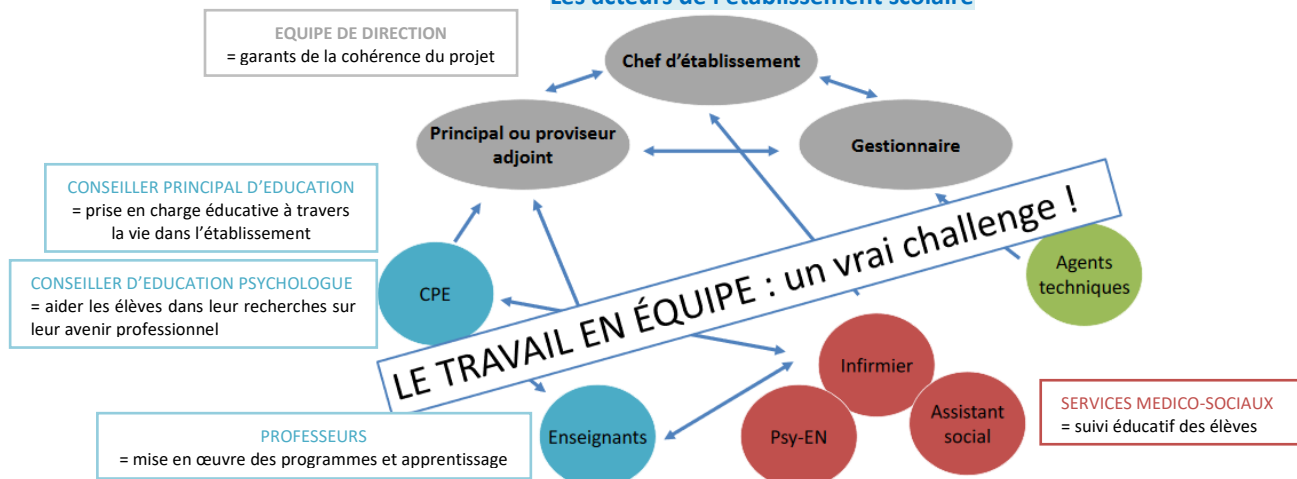
Il anime une politique de concertation avec les partenaires du système éducatif, services de l'Etat, collectivités locales ou territoriales, entreprises, organisations socio-professionnelles.

Le recteur est par ailleurs chancelier des universités : il représente le ministre auprès des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel. Il assure la coordination des enseignements supérieurs avec les autres degrés d'enseignement, un contrôle, et peut faire appel des décisions prises.

97 directions composent le périmètre, autour d'inspecteurs, directeurs des services de l'EN.

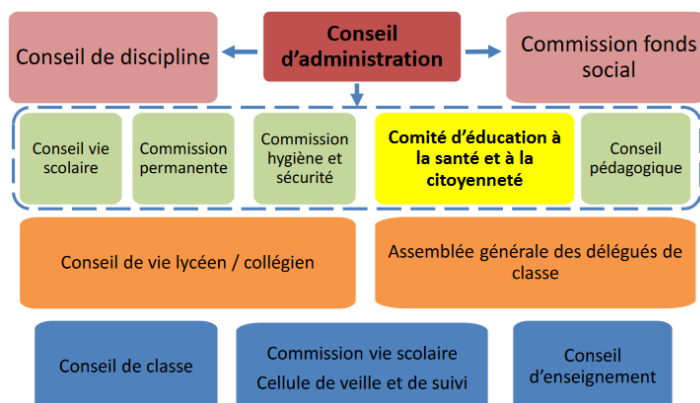
A l'échelon local ce sont les circonscriptions qui organisent : écoles autour des inspecteurs, collèges et lycées autour des principaux et proviseurs.

Les acteurs de l'établissement scolaire



Instances de l'établissement scolaire

⇒ Politique éducative locale autour du contrat d'objectif triennal



Le **contrat d'objectif triennal** s'inscrit dans les priorités académiques, et est construit en réponse aux besoins des élèves scolarisés dans l'établissement. Sa teneur est définie compte-tenu des **ressources humaines** internes et externes disponibles dans l'établissement, des possibilités de **coopération** avec les institutions et associations de l'environnement de l'établissement. Il est rédigé sous forme d'**objectifs opérationnels** déclinés en **actions triennales**.

Les parcours des élèves sont au nombre de 4 :

- le parcours **avenir** en lien avec l'éducation à l'orientation et l'insertion professionnelle
- le parcours d'éducation **artistique et culturelle**
- le parcours **citoyen** visant à développer l'engagement des élèves et l'éducation à la démocratie
- le parcours éducatif de **santé**, qui prend appui plus particulièrement sur les travaux du comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté et du conseil de vie lycéenne.

L'éducation, l'ensemble du système éducatif, mais également des professeurs et personnels d'éducation sont régis autour d'un référentiel. Ce référentiel des compétences professionnelles définit les objectifs et la culture commune à tous les professionnels du professorat et de l'éducation.

⇒ **Faire partager les valeurs de la République**

⇒ **S'inscrire dans les principes fondamentaux du système éducatif**

- **Liberté de l'enseignement** : en France le système d'enseignement public coexiste avec des établissements privés soumis aux contrôles de l'Etat et pouvant bénéficier de son aide - en contrepartie d'un contrat signé avec l'Etat. C'est une manifestation de la liberté d'expression (loi du 31 décembre 1959). L'Etat est le seul à délivrer grades et diplômes universitaires.
- **Gratuité** : posé par la loi du 16 juin 1881, étendue à l'enseignement 2^{ndaire} par la loi du 31 mai 1933. Manuels scolaires gratuits jusqu'à la 3^{ème}, dans les lycées à la charge des familles
- **Neutralité** : philosophique et politique imposée aux enseignants et aux élèves
- **Laïcité** : fondement du système éducatif français depuis la fin du 19^{ème} siècle (mars 1882 et octobre 1886). Accentuée par la loi du 09 décembre 1905 instaurant la laïcité d'Etat. Le respect des croyances des élèves et de leurs parents implique l'absence d'instruction religieuse dans les programmes, la laïcité du personnel, l'interdiction du prosélytisme.
- **Obligation scolaire** : depuis la loi Jules Ferry du 28 mars 1882, l'instruction est obligatoire. Elle s'applique à partir de 6 ans pour tous les enfants français ou étrangers résidants en France. A l'origine la scolarisation était obligatoire jusqu'à l'âge de 13 ans. Depuis l'ordonnance du 6 janvier 1959 elle a été prolongée jusqu'à l'âge de 16 ans révolus.

⇒ Agir dans le cadre réglementaire de l'école

- Connaître les processus d'apprentissage
- Prendre en compte la diversité des élèves
- Agir de manière éthique
- Utiliser la langue française
- Utiliser une langue vivante étrangère dans les situations exigées par son métier
- Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l'exercice de son métier



- **Conseils aux intervenants:**

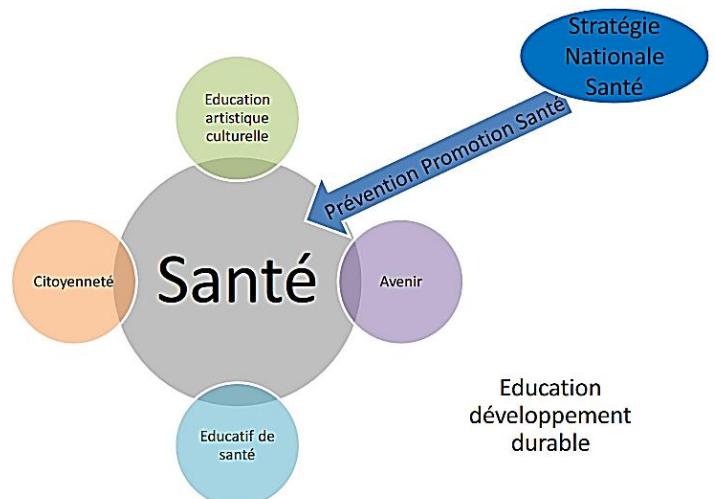
- Préparer l'intervention et l'inscrire dans le contexte de l'établissement
- Assurer un climat d'apprentissage bienveillant
- Favoriser la mise en activité des élèves plutôt que la transmission de contenu
- Se présenter et expliquer ce que l'on va faire
- S'adresser au groupe, bouger, se déplacer
- S'adapter au code de l'établissement

The diagram illustrates the relationship between geographical and social contexts and their impact on health indicators. It is structured as follows:

- Left Column (Geographical Context):**
 - Top: **Territoires isolés, zones montagneuses** (in a green oval).
 - Middle: **Des particularités géographiques** (in a green rectangle).
 - Bottom: **Ressources humaines** (in a purple rectangle).
 - Bottom Left: **Contextes locaux** (in a purple oval).
- Right Column (Social Context):**
 - Top: **Contexte social** (in a red oval).
 - Middle: **Des populations fragilisées** (in a red rectangle).
 - Bottom: **Des particularités dans les indicateurs de santé** (in a blue rectangle).
 - Bottom Right: **Santé, handicap** (in a blue oval).

An arrow points from the left column to the right column, indicating a flow or relationship between the two contexts.

⇒ Adapter les interventions en fonction des besoins de nos populations



Les parcours de formation....Eléments contextuels

Des relations inclusives possibles....et souhaitables !

Au cœur des 4 parcours: bien-être physique - mental - social

Education au développement durable



facebook.com/EducationFrance twitter.com/EducationFrance

Une mission de l'école en matière de santé

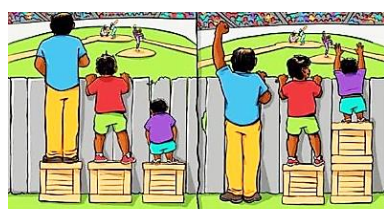
La promotion de la santé en milieu scolaire constitue **un des meilleurs leviers pour améliorer le bien-être et réduire les inégalités sociales, scolaires, et de santé.**

- Faire acquérir à chaque élève connaissances, compétences et culture pour prendre en charge sa propre santé
- Mettre en œuvre des projets de prévention sur les problématiques de santé dans une logique de parcours
- Créer un environnement scolaire favorable à la santé et à la réussite scolaire

➤ Poursuivre les actions au-delà de l'école...

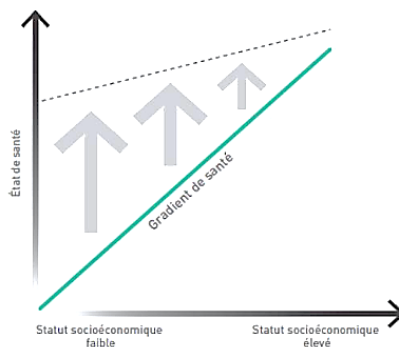
Universalisme proportionné: individualisation

- Offrir une intervention à **tous**, mais avec des **modalités** ou une **intensité** qui varient selon les besoins.
- **Individualisation des parcours** en fonction des besoins (statut socio-économique par exemple)



– Egalité ≠ Equité

REPRÉSENTATION THÉORIQUE DU GRADIENT DE SANTÉ ET DU NIVELLEMENT VERS LE HAUT

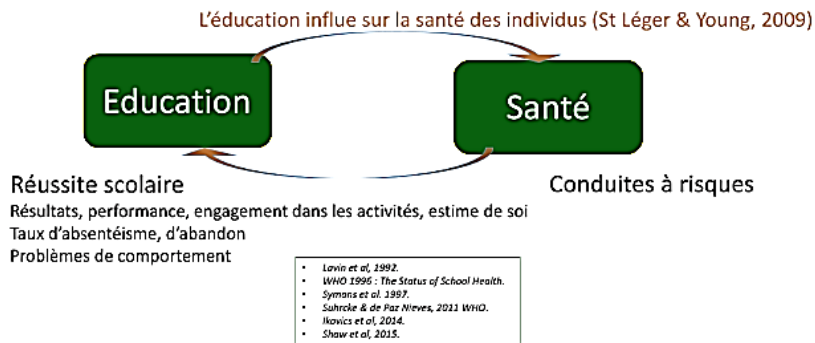


➤ **Objectif** : Agir sur le Gradient de santé

ECOLE ET SANTE

Cette présentation s'appuiera sur la littérature scientifique pour éclairer les liens entre la santé et l'éducation.

De nombreuses données collectées à l'échelle internationale attestent d'un lien étroit entre éducation et santé. Il est désormais acquis que **l'éducation a un impact majeur sur la santé des individus** (St Léger & Young, 2009). De façon générale, les jeunes qui fréquentent un établissement scolaire ont de meilleures chances d'être en bonne santé. D'un autre côté, la santé a un impact fort sur l'éducation.

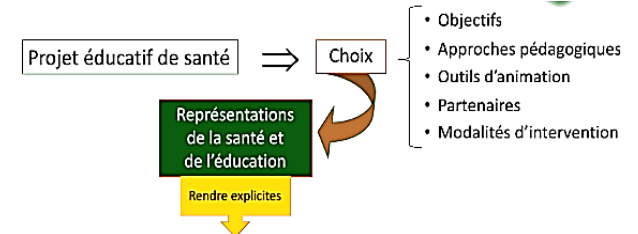


Des jeunes en bonne santé apprennent mieux et sont plus investis dans les apprentissages.

A l'inverse des jeunes en mauvaise santé ou concernés par des conduites à risques (tabac, alcool, autres drogues, sexe,...) réussissent moins bien à l'école en termes de résultats, **performance, engagement** dans les activités scolaires et présentent plus souvent un déficit d'**estime de soi**.

Les taux d'absentéisme ou d'abandon sont plus élevés et les problèmes de comportement plus fréquents (Lavin et al 1992 ; Symons et al. 1997 ; Suhrcke & de Paz Nieves, 2011 WHO).

Tout projet éducatif ayant un lien avec la santé implique pour son concepteur de **faire des choix** que ce soit en termes d'objectifs, d'approches, d'outils d'animation, de partenaires à mobiliser ou encore de modalités d'intervention. Ces choix ne sont pas neutres. Ils sont en effet le **reflet des représentations** que l'éducateur se fait, tant de la santé que de l'éducation.



Rendre explicites ces représentations et les modèles théoriques auxquels elles se rattachent est une nécessité car cela permet à l'éducateur (Clic6) de prendre conscience des **limites de leur champ de validité** mais aussi d'**identifier les modèles les plus pertinents et efficaces** en fonction du contexte d'action.

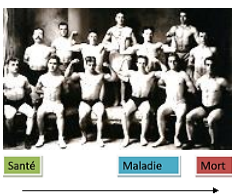
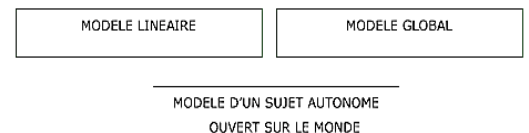
Prendre conscience des limites du champ de validité des modèles

Identifier les modèles les plus pertinents et efficaces en fonction du contexte d'action

Il ne saurait être question ici de présenter l'ensemble des modèles décrits dans la littérature. Nous nous limiterons aux travaux de Chantal Eymard (2004) qui proposent un **croisement entre modèles de santé et modèles éducatifs**.

La notion de santé est définie différemment selon les contextes culturel, social, économique ou politique. **Chantal Eymard** (2004) distingue 3 conceptions principales qui correspondent respectivement aux **modèles linéaire, global et du sujet autonome ouvert sur le monde**.

3 principaux modèles (Eymard, 2004)



Dans le **modèle linéaire ou biomédical**, la santé est définie comme l'état contraire de la maladie.

Selon cette conception, s'occuper de sa santé revient donc à lutter contre les maladies. Celles-ci sont considérées comme un **accident de la vie** qui vient en limiter la durée et peut conduire à la mort, qui représente alors un échec thérapeutique. Selon cette conception, l'homme se positionne ainsi sur un **axe opposant santé et mort**. Cette conception est de nos jours encore très présente et il convient d'en sortir.

En rupture avec le modèle précédent, le **modèle global** se fonde sur la définition proposée par l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) en 1946 : **"La santé est un état de complet bien-être physique, social et mental et ne consiste pas seulement en l'absence de maladie ou d'infirmité."**

Cette définition met donc en avant non seulement la dimension **physiologique**, mais aussi les dimensions **psychologique** et **sociale** de l'individu. Elle défend en outre une **vision positive de la santé** (celle-ci n'est plus définie comme la négation de la maladie) et introduit la notion de **bien-être**, purement subjective, en relation avec la **satisfaction des besoins** de l'individu.

Les critiques dont ont fait l'objet cette définition, notamment son caractère utopique et sa dimension statique, ont abouti à une nouvelle proposition de l'OMS en 1982 : **« La santé, c'est la mesure dans laquelle un groupe ou un individu peut, d'une part, réaliser ses ambitions et satisfaire ses besoins, et d'autre part, évoluer avec son milieu et s'adapter à celui-ci. »**

Cette nouvelle définition met ainsi l'accent sur les **capacités d'adaptation du sujet à un environnement sans cesse en évolution**.



Enfin le **modèle de l'existence d'un sujet autonome ouvert sur le monde** met en avant la capacité du sujet à **s'affirmer** dans un environnement donné, à exercer son **jugement** et sa **liberté**, comme celle de choisir la manière d'être soigné, celle de choisir son traitement, celle de choisir d'être soigné ou pas. Dans ce modèle de santé, l'individu est considéré comme un **sujet à part entière**. **« Il n'est pas seulement acteur de sa santé, mais en tant que sujet autonome, il devient partenaire des soins de santé avec les professionnels de la santé. »** (Eymard, 2004)

Afin de proposer des repères permettant d’analyser la relation entre santé et éducation, **Chantal Eymard** a confronté les modèles de santé décrits précédemment, **linéaire, global et du sujet autonome ouvert** sur le monde aux 3 principaux modèles éducatifs connus :

- le modèle de **l’instruction**, qui valorise la transmission de savoirs,
- le modèle du **développement du sujet**, basée sur une approche constructiviste
- et le modèle **d’interaction sociale**, centré sur une approche socioconstructiviste.
-

Modèles éducatifs	Modèles de santé		
	Linéaire - Absence de maladie - Approche hygiéniste ou biomédicale	Global - Adaptation individuelle ou ajustement social - Approche biopsychosociale	Sujet autonome ouvert sur le monde
Instruction			
Développement du sujet			
Interaction sociale			

Actions de prévention des conduites addictives à destination d’adolescents

Les cases du tableau représentent ainsi **différents modèles d’éducation à la santé en référence à un couple donnée de modèles de santé et d’éducation**. Ces modèles d’éducation à la santé certes théoriques et susceptibles de s’entremêler dans la pratique, donnent toutefois des repères essentiels pour **analyser les interventions en éducation à la santé et les limites de leur champ de validité**.

Prenons l’exemple, d’actions de prévention des *conduites addictives à destination des adolescents dans un établissement*.

Si ces actions sont basées exclusivement sur l’apport d’information sur les produits et les risques, elles s’inscrivent alors dans une **approche transmissive de connaissances (modèle d’instruction)** et une **vision biomédicale de la santé**.

Si les actions reposent plutôt sur l’identification des situations de stress et la manière de les gérer ou encore sur la capacité à résister à la pression des pairs, le **développement du sujet** et une **approche biopsychosociale** sont alors mis en avant.

Si les actions s’inscrivent dans un projet DES élèves, s’appuyant sur des méthodes interactives tels jeux de rôle ou réalisation de vidéos, impliquant les familles et prenant en compte l’environnement global, elles sont alors fondées sur les **modèles d’interaction sociale** et du **sujet autonome ouvert sur le monde**.

Pour conclure...

Si la refondation a pour objet de faire de l’école un lieu de réussite, d’autonomie et d’épanouissement pour tous, éduquer à la santé suppose pour l’éducateur d’avoir recours à une **diversité de modèles** pour fonder son intervention, permettant ainsi tout à la fois l’apport de **connaissances** (sur la santé, les risques, les comportements), le développement des **compétences** personnelles sociales et civiques et du **jugement critique** face à l’environnement.

L’éducateur en santé doit être capable enfin d’**identifier** dans chaque contexte le/les modèles pertinents.

Pour cela, il doit avoir une **bonne connaissance du public visé**, de ses besoins et de ses aptitudes.

Il est par exemple bien connu que les **approches transmissives** favorisent davantage les élèves qui savent.



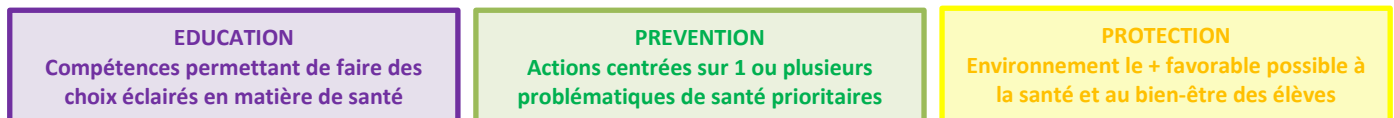
Le parcours éducatif de santé

Le parcours éducatif de santé, un parcours en faveur de la promotion de la santé à l'Ecole.

Le **PES** inscrit dans la **loi de fondation de l'école en 2013** est un parcours qui concerne **tous les élèves de la maternelle au lycée**.

En lien avec les projets d'écoles et d'établissements, son contenu doit être adapté aux besoins identifiés et prendre appui sur le socle commun et les enseignements.

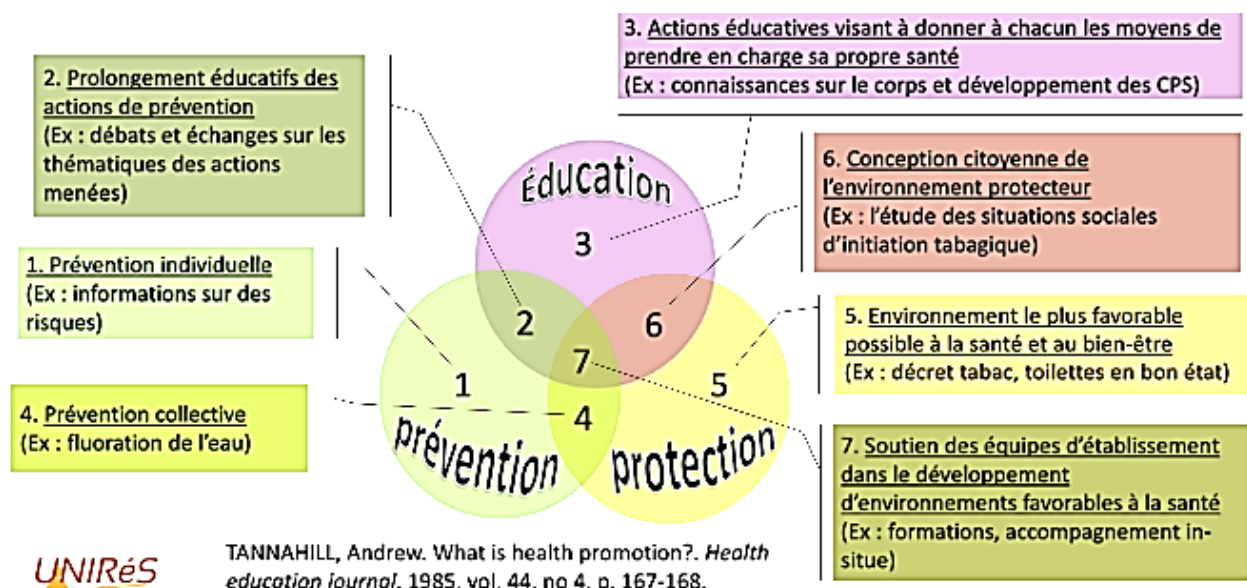
Il doit permettre une **construction progressive des compétences et des connaissances** nécessaires pour prendre en charge sa santé et se présenter sous une forme **intelligible** notamment pour les familles dans un souci de **cohérence** des actions éducatives.



Le décret du 15 novembre 2006, qui interdit de fumer dans tous les espaces couverts et non couverts des établissements d'enseignement de formation, est clairement une action de **PROTECTION**. Mais il est bien souvent difficile de classer les actions uniquement dans l'un des 3 axes. Ceux-ci étant largement perméables car une action relève fréquemment de 2 voire des 3 axes.

La **modélisation de la promotion de la santé** par **Andrew TANNAHILL**, dans son article *What is health promotion ?* en 1985, est depuis devenue une référence dans le monde entier. Son modèle peut servir de cadre pour l'élaboration d'activités de promotion de la santé en catégorisant les actions selon les axes ou leurs intersections.

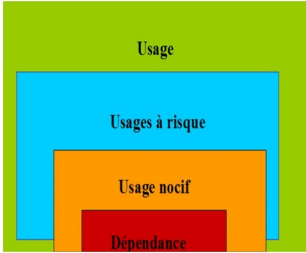
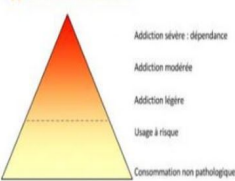
Des chercheurs proposent des pistes d'utilisation de cette modélisation dans le milieu scolaire.



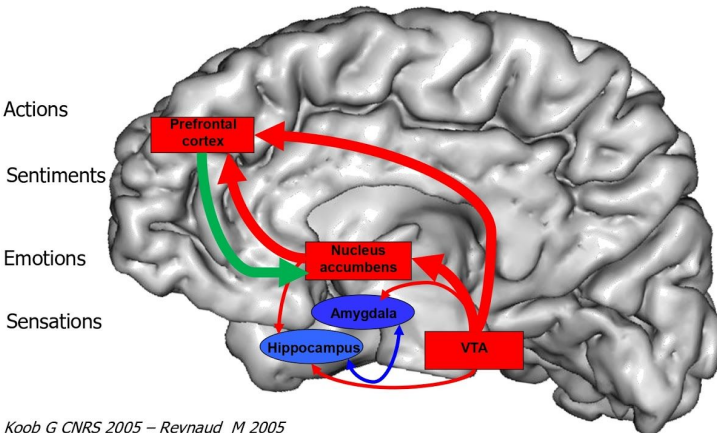
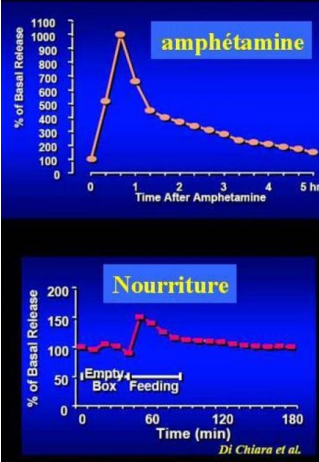
⇒ Diagnostic des actions de promotion menées dans un établissement

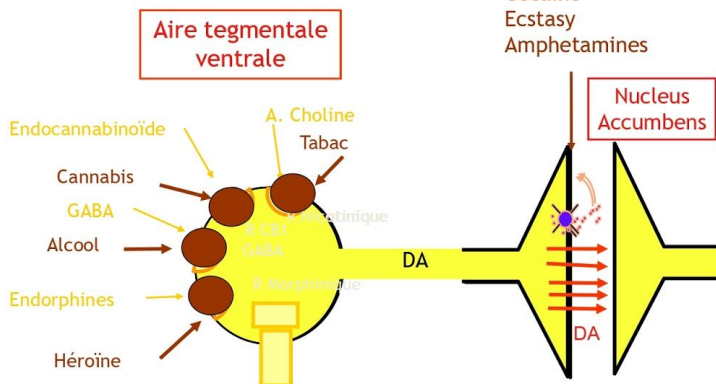
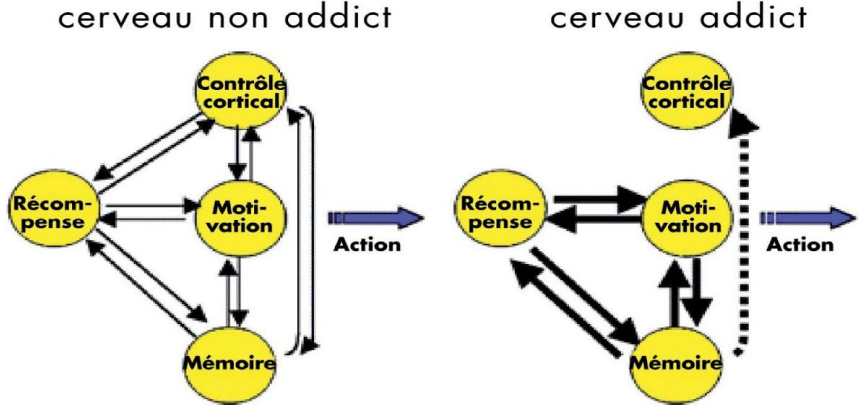
La **modélisation de TANNAHILL**, fondement de la prescription législative, sous semble être utile à plus d'un titre.

En fonction du contexte elle pourra être mobilisée comme une **aide au pilotage d'un projet**, ou une **aide au diagnostic** d'un établissement. Elle constitue également un **support de communication** explicite et mobilisateur.

Addiction et conduites addictives	
Introduction	Addiction = comportement visant à produire du plaisir ou écarter une sensation de malaise interne, répété, avec perte de contrôle et l'usage persiste malgré les effets nocifs Dépendance psychique : ⇒ <i>Craving</i> = envie irrésistible aboutissant à la recherche compulsive du produit Dépendance physique ⇒ <i>Tolérance</i>: besoin de doses augmentées pour ressentir le même effet ⇒ <i>Syndrome de sevrage</i>: symptômes physiques, en partie spécifique du produit, apparaissant en cas de manque. Ex: tremblement pour alcool, tension interne pour le cannabis, mydriase et sueur pour les opiacés. Evolution de l'addiction est progressive et nous sommes inégaux en capacité de résistance.
Les conduites addictives	
Débute pour la plupart comme des modalités de recherche de bien être et de lien social.	
Consommation de substance psychoactive	• Licites: alcool, tabac, médicaments psychotropes • Illicites: cannabis, héroïne, cocaïne, amphétamine, hallucinogènes, drogues de synthèse, dopage, solvants
Conduite addictive sans produit	Jeu d'argent, jeux vidéos et (cyberdépendance), conduites sportives pathologiques, boulimie, addiction sexuelle, achats compulsif, Work-addiction, Smartphone
Description de l'addiction	
Conduites addictives ont toute en commun une capacité addictogène mais tous les usagers ne deviennent pas addict. A partir d'un usage, hédonique, réconfortant, les pratiques de certains évoluent progressivement vers l'addiction, d'où les critères d'évaluation 2 description du processus addictif se sont succédé ces dernières années • Approche catégorielle • Approche dimensionnelle	
Approche catégorielle	Décrit le passage progressif d'une catégorie d'usage à l'autre: - Usage simple: ni a risque, ni nocif, ni dépendant - Usage à risque: supérieur au seuil de risque mais pas encore nocif - Usage nocif: lorsqu'au moins un effet nocif s'est manifesté. - Usage dépendant: caractérisé par l'apparition des signes DSM IV de dépendance psychologique et physique. DSM = Manuel Diagnostic et Statistique publié par l'association américaine de psychiatrie. Le terme conduite addictive s'applique donc à partir d'un usage/mésusage à risque ⇒ trop souvent, trop, dans des situations à risque. C'est à partir de cela que certains vont parcourir le continuum des mésusages. Ce constat argumente, dans le domaine de la prévention, la notion de modération 
Approche dimensionnelle de l'addiction	DSM/ICM 10 Approche catégorielle  DSM-V Approche dimensionnelle  Approche par catégorie d'usage est parlante mais il est apparu cliniquement que entre l'usage nocif et la dépendance avérée, il existe pour les sujets qui deviendront dépendants une aggravation progressive des besoins impérieux et irrésistibles. Il y a donc bien une zone de passage progressif et donc d'imprécision entre usage nocif et dépendance. 2013 ⇒ approche dimensionnelle de l'addiction sur laquelle insiste désormais les classifications internationales, prend acte de cette progressivité et met en valeur dans les critères DSM 5 du trouble de l'usage des substances 2 nouveautés: - Le craving: besoin impérieux - Dimension d'aggravation progressive de la dépendance Ces schémas illustre le passage de la classification en catégorie d'usage à la classification dimensionnelle. La même base de consommation ou de comportements non pathologique est surmonté de catégorie de mésusage, pour l'une ⇒ abus et dépendance; et d'une addiction de légère à sévère pour l'autre. Dans le DSM 5 le trouble de l'usage est coté absent en dessous de 2 critères, puis l'addiction évolue de légère (critères) à sévères (plus de 6 critères)

Exemple des types d'usages de l'alcool	Experts de santé publique France et de l'INCA ont tenté de définir les risques acceptables pour l'alcool et propose qu'il n'existe pas d'usage sans aucun risque mais un usage à risque faible en dessous du seuil suivant (valable pour les 2 sexes) ⇒ moins de 2 verres/jour, 10 verres/semaine, au moins un jour/semaine sans conso, ne pas consommer en situation à risque: grossesse et allaitement, enfance, adolescence, toute la période de la croissance, conduite auto, sports à risque, conso de certains médicaments, certaines maladies. Usage à risque: moyen ou fort, augmente au dessus de ce seuil. Effets nocifs bien connus ⇒ perte permis de conduire, accident, pancréatite, etc. Dépendance: signe de manque par hyperexcitabilité du SNC pouvant aboutir au décès par épilepsie ou <i>délirium tremen</i>. Continuum de gravité est particulièrement impressionnant pour cette conduite addictive ⇒ toute personne alcoolo dépendante en danger, à commencé par une consommation normale.
Exemple de l'exercice physique	• Usage simple: favorable à la santé • Usage à risque: intensif, hédonique et longtemps favorable • Usage nocif: blessure, envahissement, abandon activité familiale et pro, burn out • Dépendance: effets négatifs sur l'humeur à la moindre privation (sensation de manque) Addiction = poursuite malgré les effets nocifs et les sensations de manques. Addiction ≠ Dépendance
Les déterminants d'une conduite addictive	
	Le risque d'addiction se trouve à la croisée des chemins. D'une part une personne vulnérable avec un produit addictogène dans un contexte favorisant, de plus des scientifiques ont mis en évidence le rôle aggravant de certains modes de consommation. Facteurs de risques ⇒ Interaction de Produit X Individu X Environnement (X Modes de consommation) Chaque histoire d'addiction est influencé par ces 4 groupes de facteurs de risques et chaque combinaison est unique
Produit	Le produit ne rend addict que s'il un pouvoir addictogène. • Il faut qu'il ait un effet psychoactif capable d'augmenter le plaisir ou de diminuer le malaise interne par une action psychoactive direct sur le cerveau ⇒ stimulante, sédatrice, ou à type de distorsion sensorielle comme les hallucinogènes; mais aussi capable d'induire une pharmacodépendance physique. • Le caractère toxique du produit va en déterminer les complications médicales et psychiatrique par nocivité immédiate ou chronique. • Le statut social du produit aura des conséquences en terme d'offre et de demande, de disponibilité, ainsi qu'en cas de nécessité d'abstinence après une intoxication.
Individu	Le sujet peut être vulnérable à plusieurs titre ⇒ son histoire va déterminer des facteur de protections ou de vulnérabilité. Ainsi une personne est plus fragile en cas d'antécédents de traumatismes familiaux et de traumatisme précoce (maltraitance, abus sexuel, troubles identitaires). • Sa vulnérabilité psychologique dépend aussi de la fonction de la conduite addictive dans son économie psychique et de l'éventail de ressource qu'il peut déployer contre ce risque. L'angoisse est un symptôme fréquent, s'il elle n'est pas exprimée, adressée à un thérapeute et soulagé est un puissant facteur d'addiction car les conduites addictives vont fonctionner pour ce sujet comme des masques. • La personne peut souffrir d'un facteur psychiatrique ⇒ dépression ++, troubles anxieux, phobie sociale, troubles bipolaires, psychoses, TCA, hyperactivité, troubles de la personnalité. • Des facteurs génétiques ont été identifié ⇒ la variabilité de l'allèle A1 du récepteur D2 à la dopamine, qui modifie la sensibilité à la dopamine. • Enfin des vulnérabilités biologiques tel qu'une exposition foetale aux substances psychoactives, un déficit d'inhibition d'origine cérébrale, ou l'addiction préalable à d'autres substances.

Environnement	Famille , influence des copains , besoin de trouver sa place parmi eux. L'offre et la demande de produit dans le milieu social , la situation de la personne, son mode de vie, une éventuelle précarité, le stress.
Modes de consommation	Épidémiologistes et cliniciens se sont rendu comptes de l'influence du mode de consommation sur le risque nocif et d'addiction. Sont à plus haut risque d'addiction : précocité de l'usage, les excès , la polyconsommation et l' usage auto-thérapeutique ⇒ le fait de chercher un soulagement dans un produit psychoactif au détriment d'une autre recherche de solution. Cet usage est différent de l'usage purement convivial et est plus souvent associé à un profil psychologique à risque.
Neurobiologie de la dépendance	
Système de la récompense	Au centre du cerveau, le principale neurobiologique de l'addiction est le système de la récompense. Circuit mésocorticolimbique soutient un mécanisme naturel de recherche de plaisir et évitement de la souffrance et réponse aux besoin fondamentaux. Les désirs plaisirs naturels activent les neurones dopaminergiques. La dopamine code la valeur du plaisir. Le comportement acquiert ainsi une signification motivante, de "récompense". Il fonctionne par feed-back en réponse aux besoins et module les émotions positives et négatives.  Les structures concernées sont l'aire tegmentale ventrale, noyau accumbens, cortex préfrontal, ainsi que 2 structure limbiques ⇒ amygdale en relation avec les émotions, et l'hippocampe en relation avec la mémoire. Les plaisirs ou soulagement naturels, activent la sécrétion de dopamine de l'aire tegmentale ventrale vers le noyau accumbens. Le cortex préfrontal est informé de l'information initiale, de la valeur motivante de la sécrétion dopaminergique. Dans les conditions normales le cortex préfrontal exerce un rétrocontrôle inhibiteur. Les liens entre la voie dopaminergique, l'hippocampe et l'amygdale vont permettre la mémorisation des comportements favorables. A l'état normal il n'a pas d'emballement du système de la récompense, du fait - du fonctionnement en feed-back, cad du fait que l'obtention d'un résultat favorable supprime la stimulation - de l'élimination de la dopamine - de l'intégrité de la voie inhibitrice cortico frontale. L'individu conserve donc des ressources de satisfaction et de soulagement varié
Effets de la drogue sur le système de récompense	Dans l'addiction ce sont sur ces mêmes voies de la récompense que les substances psychoactives vont exercer leur pouvoir addictogène. Elles vont fonctionner comme des leures pharmacologique et se greffant au niveau de ATV sur des récepteurs situés sur les neurones dopaminergiques, elles vont stimuler la sécrétion de la dopamine dans le noyau accumbens et ceci beaucoup plus fortement que les plaisirs naturels. On voit sur ces graphiques que le pique dopaminergique provoqué par une prise d'amphétamine est 10 fois plus élevé que celui déclenché par la nourriture. Cela donne au produit une signification plus motivante et un effet de renforcement. 

Conséquences	Dans l'addiction, la poursuite de consommation du produit va aboutir - au phénomène d'accoutumance ⇒ la personne va ressentir de moins en moins de satisfaction ce qui peut entraîner une accélération du comportement - au craving positif ⇒ recherche de plaisir - au craving négatif ⇒ évitement plus ou moins conscient de la souffrance du manque - à la perte de contrôle de la consommation du produit ou du comportement - syndrome de sevrage variable suivant les substances du fait de la complexité de leurs actions On a prouvé que certains de leur comportements sur activent aussi la dopamine ou les endorphines ⇒ jeu d'argent, compétition sportive, etc.					
Effets des substances psychoactives sur la synapse dopaminergique	Certaines substances psychoactives se greffent sur les récepteurs présynaptique dédiés à des neuromédiateurs naturels comme les récepteurs endorphiniques, nicotiniques, endocannabinoïde. D'autres bloquent dans l'espace intersynaptique la recapture de la dopamine ⇒ accumulation de la dopamine. Il existe des addiction croisées, les substances interagissent avec la sensibilisation du récepteur d'un autre produit  Toutes les substances addictives ont donc en commun un effet dopaminergique					
Cortex préfrontal dans l'addiction	Dans un cerveau addict le contrôle cortical est moins efficient ou en échec. Du fait de l'altération du cortex préfrontal, par ex une certaines quantité de destruction neuronale et du fait de la puissance de l'effet de renforcement. 					
Une société addictogène						
Frontière normal / pathologique	<table><tr><td>Les dérives admises:</td><td>Ce qui est dénoncé:</td><td rowspan="2">Les conduites addictives sont à la frontière du normal et du pathologique. Par exemple l'alcool et les psychotropes se trouvent des 2 côtés de cette limite floue.</td></tr><tr><td> • Alcoolisation sociale • Dopage même au travail • Médicaments psychotropes • Boissons énergisantes • Internet, smartphone • Hyperactivité promue par les medias • Addiction au sport • Musculation </td><td> • Alcoolisme • Tabagisme • Médicaments psychotropes • Cocaïne • Cannabis • Drogues de synthèse • Jeux , cyberaddiction • Dopages </td></tr></table>	Les dérives admises:	Ce qui est dénoncé:	Les conduites addictives sont à la frontière du normal et du pathologique. Par exemple l'alcool et les psychotropes se trouvent des 2 côtés de cette limite floue.	• Alcoolisation sociale • Dopage même au travail • Médicaments psychotropes • Boissons énergisantes • Internet, smartphone • Hyperactivité promue par les medias • Addiction au sport • Musculation	• Alcoolisme • Tabagisme • Médicaments psychotropes • Cocaïne • Cannabis • Drogues de synthèse • Jeux , cyberaddiction • Dopages
Les dérives admises:	Ce qui est dénoncé:	Les conduites addictives sont à la frontière du normal et du pathologique. Par exemple l'alcool et les psychotropes se trouvent des 2 côtés de cette limite floue.				
• Alcoolisation sociale • Dopage même au travail • Médicaments psychotropes • Boissons énergisantes • Internet, smartphone • Hyperactivité promue par les medias • Addiction au sport • Musculation	• Alcoolisme • Tabagisme • Médicaments psychotropes • Cocaïne • Cannabis • Drogues de synthèse • Jeux , cyberaddiction • Dopages					

Rôle de la société	• Hyperconsommation, loi de l'offre et de la demande • course à la performance • 'tout tout de suite', réponses instantanées et individuelles • recherche de sensation, besoin d'intensité • pression, stress au travail, précarité • Être cool à tout prix, refuser l'anxiété • Recherche d'anesthésie • Eviter la relation à l'autre, éviter les conflits • Auto-administration rapide des plaisirs et soulagements par divers produits...	Environnement encourage à l'hyperconsommation et même à la perte de contrôle de cette consommation, il encourage à la performance jusqu'à épuisement, à des solutions individuelles pour tout plaisir et pour tout soulagement, décourageant de les rechercher dans la relation. Il encourage à masquer son anxiété et à rechercher l'anesthésie.
Comment agir?		
Intervention selon le stade addictif: • La prévention primaire tente d'influer sur: - <u>Le contexte sociétal</u>: L'offre et la demande par la répression du trafic de stupéfiant et par les taxes et législations sur les drogues licites ⇒ Loi Evin, législation s'opposant à l'alcoolisation des mineurs, prévention auprès des femmes enceintes, paquets neutres - <u>Le risque d'expérimentation précoce</u>: programme éducatif visant à développer les compétences psychosociales des enfants et adolescents ⇒ capacité autoaffirmation, la confiance - <u>La situation psychosociale</u> ⇒ protéger les personnes vulnérables • La prévention secondaire: fondée sur le repérage précoce et intervention brève pour éviter les effets nocifs pdt une grossesse par exemple, et éviter l'évolution vers la dépendance. • Accompagnement vers le soin ⇒ sevrage ou réduction des risques: soignent les effets nocifs et la dépendance, soutient vers abstention ou réduction des risques soignent les effets nocifs et la dépendance. Prise en charge globale médico-sociale sont les plus efficaces.		

Addiction au tabac

Introduction et chiffres

Quand on parle de tabac on est obligé de donner des chiffres pour comprendre la gravité en terme de santé publique mais aussi l'amplitude de cette intoxication tabagique ⇒ **urgence planétaire**

- Tue **5 millions** de victime par an dans le monde ⇒ 1 personne meurt toute les 6 secondes
- **1/2** des consommateurs meurt de son tabagisme
- **1ere cause de décès évitable**
- Effets nocifs n'apparaissent que plusieurs décennies après le début de la consommation ⇒ quand on commence jeune on ne se rend pas compte des conséquences sur la santé quand on aura 40/60 ans

Le tabagisme en France:

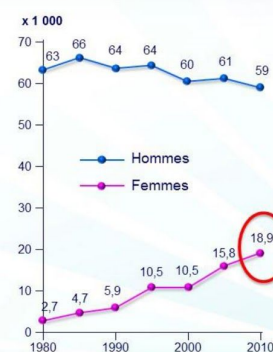
- 1ere cigarette vers **11 ans**
- 27% des 12-85 ans déclarent fumer quotidiennement (4.7% déclarent fumer occasionnellement)
- Etat reçoit 12 milliard d'euros des taxes issues du tabac mais le coût social du tabac est de 15 milliards d'euros ⇒ Assurance maladie, arrêt de travail
- Tue ≈ 73000 personnes soit autant que l'alcool, les accidents de la route, le SIDA, les suicides, les homicides et les drogues illicites, **toutes ces causes réunies**
- 1ere cause de cancer, loin devant la pollution et en ne prenant en compte QUE les substances **cancérigène certaines**

Les femmes fument quasiment autant que les hommes:

- Dans les années 50 les hommes étaient beaucoup plus fumeurs que les femmes
- Dans les années 2010 le nombre de fumeur régulier chez les hommes et chez les femmes se rejoint et ≈ 30% de la population fume

⇒ **Le nombre de décès en France attribué au tabac augmente chez les femmes et diminue chez les hommes**

• Nombre de décès attribuables au tabac en France (tous âges)



Aucun organe épargné par le tabac. Certains sont beaucoup plus concernés comme les poumons, mais il y a aussi des atteintes vasculaires (⇒ infarctus, lésions des vaisseaux cérébraux, artériopathie des membres inférieurs), augmente le risque de diabète ⇒ diabète + tabac = toxique ++ pour les vaisseaux.

1/2 fumeurs n'atteindront pas l'âge de la retraite

Tabac + pilule = cocktail explosif

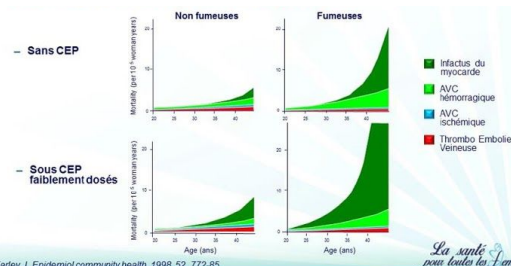
⇒ augmentation ++ du risque cardiovasculaire et AVC

⇒ risque de phlébite et/ou d'embolie pulmonaire

On attribue souvent ce risque seulement à la contraception

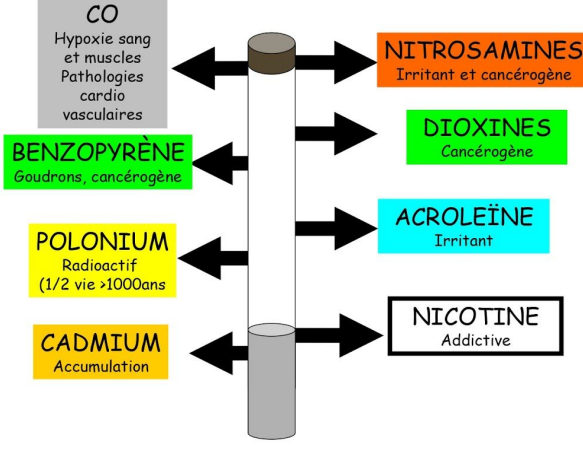
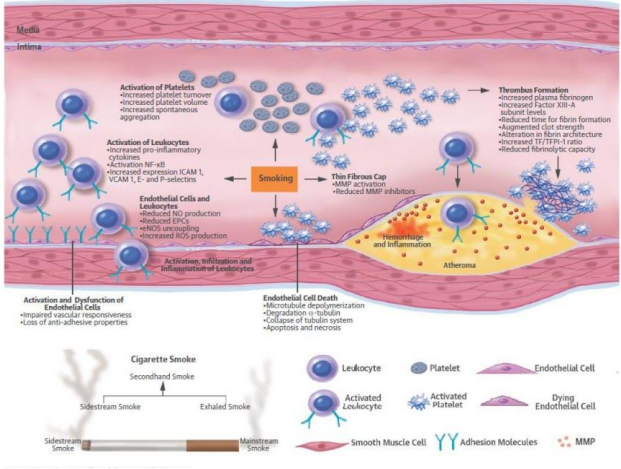
Graphique: on voit que chez les femmes non fumeuses la contraception oestro progestative (CEP) augmente surtout après 40 ans le risque de mortalité par AVC ou par problème cardiaque. Mais chez les femmes fumeuses, la courbe est exponentielle après 35 ans ⇒ tabac qu'il faut arrêter et pas la contraception.

Risque de cancer du sein augmente de 50% chez les fumeuses.



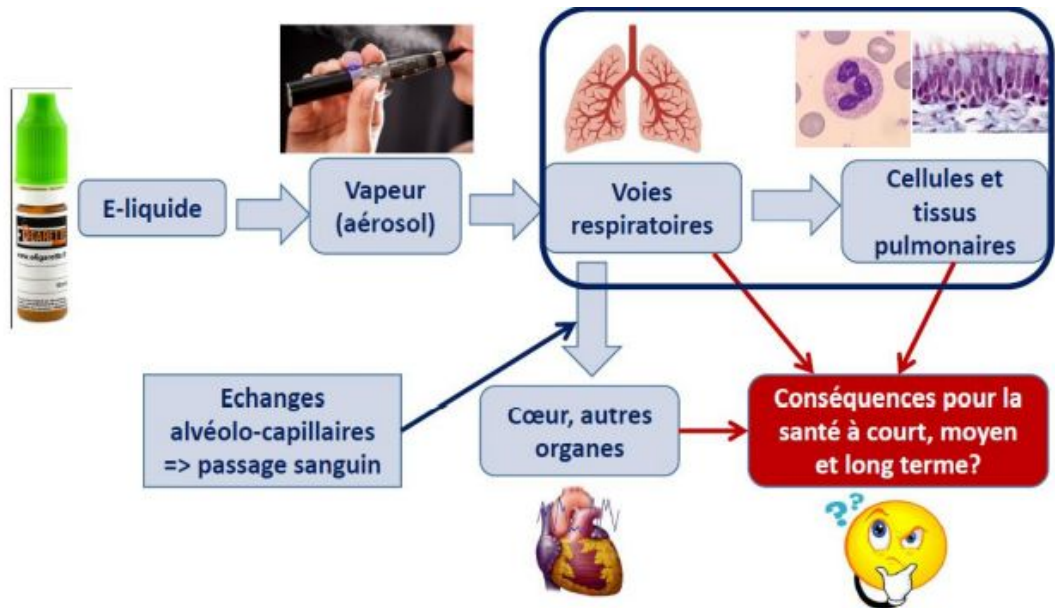
Des risques spécifiques pour les femmes

- Le tabac est un frein à la fécondité de la femme
 - Réduction de la fécondité de 1/3
 - Fumeuses mettent 2 X plus de temps à avoir un enfant
 - Ménopause est plus précoce de 2 ans avec augmentation de l'**ostéoporose**
- Tabac et grossesse
 - Risque de fausse couche ou prématurité X2
 - Risque de grossesse extra-utérine multiplié par 3 à partir de 20 cigarettes/jour
 - Retard du développement du fœtus, moins bien oxygéné (CO)
 - Risque de mort subite du nourrisson X3
 - Diminution de la production de lait dans lequel **passse la nicotine**
- Tabac et poids: mythe de **je fume donc je vais maigrir** ⇒ le tabac entraîne une modification des graisses corporelles au niveau du ventre et donne une silhouette masculine

Influence marketing VS vraie vie	Marketing des cigarettier est extrêmement puissant ⇒ payent des actrices pour fumer à l'écran Aspect plus sexy et plus libre de la fumeuse Vraie vie ⇒ les hommes et les femmes ont des lésions esthétiques liées au tabac: - + de ride - cheveux ternes - voix plus grave L'arrêt du tabac permet une amélioration assez rapide et sensible  Sœurs jumelles homozygotes 52 ans FUMEUSE NON FUMEUSE
Des risques spécifiques aux hommes	- Tabac est un facteur de risque cardiovasculaire supplémentaire - 80% des hommes frappés par un infarctus avant 50 ans ont pour seul risque la consommation de tabac - Vie sexuelle réduite en cendre ⇒ troubles de l'érection possible à 25 ans chez les fumeurs, X27 voir 30 le risque d'impuissance - Diminution de la libido par baisse de testostérone MAIS réversibilité en cas d'arrêt - Diminution de la fécondité et risque de stérilité plus élevé ⇒ altération de l'ADN des spermatozoïdes, d'où risque d'anomalies congénitales de l'enfant
Idées reçues	Beaucoup de personnes pensent que ne fumer que quelques cigarettes par jour n'a aucun risque. Pour le risque cardiovasculaire le fait de fumer que quelques cigarettes par jour augmente déjà le risque (x 1.5), voire même le tabagisme passif (x 1.3). Fumer un paquet par jour augmente x2 le risque.
Composition	Comment la cigarette est responsable de toute ces pathologies? Il y a dans la fumée de cigarette 4000 composés, on élimine d'emblée la nicotine car ce n'est pas elle qui pose des problème de santé ⇒ c'est la drogue qui est responsable de la dépendance. Exemple du Monoxyde de carbone (CO): - Mesure dans le poumon par un CO testeur. - La quantité normale est de 5 particules / 1 millions dans l'air qu'on expire. Chez les fumeur la quantité peut augmenter à 60/70 chez ceux qui fument plus d'un paquet par jour. - Une fois inhalé le CO va prendre la place de l'O₂ dans les alvéoles pulmonaires - ⇒ lieu d'échange entre l'aire et la circulation sanguine et les GR vont se charger en CO à la place de l'O₂ car l'affinité de l'hémoglobine pour le CO est bien supérieure à son affinité pour l'O₂. - Le CO va donc être responsable d'une hypoxie de tout l'organisme - En cas d'intoxication au CO il faut traiter par tente à oxygène. 
Effets du CO sur le cœur	Aggravation de la plaque de cholestérol + lésions sur l'endothélium ⇒ la plaque de cholestérol peut s'ouvrir et aller activer tout le système plaquettaire et créer des thrombus. C'est donc le CO dans la fumée de cigarette qui va être responsable de l'infarctus et de l'AVC. Avantage, à l'arrêt du tabac le CO diminue d'emblée en 2 ou 3 jours pour se retrouver à la valeur normale. ⇒ Quand on arrête de fumer, l'hypoxie globale de l'organisme est réversible assez rapidement. 

Bénéfices à l'arrêt du tabac	- Diminution du CO qui va avoir un retentissement assez rapide, perceptible par la personne qui fume - Après les 20 premières minutes la tension artérielle et les pulsations cardiaques redeviennent normales - Au bout de 8h l'oxygénation des C s'améliore - Au bout de 24h le risque de crise cardiaque diminue déjà - Poumons se remettent à fonctionner, les cils qui bordent toutes les C commencent à éliminer le mucus et les résidus de la fumée - 48H: le goût et l'odorat s'améliorent - 72H on respire mieux, on est moins essoufflé - 2 semaine/ 3 mois: la fatigue diminue car le corps est mieux oxygéné, on marche plus facilement - Au bout d'un an le risque d'arrêt cardiaque est divisé par 2 et le risque d'atteinte cérébrale rejoint celui d'un non fumeur - 10 à 15 ans pour que l'espérance de vie retrouve son chiffre normale JOUR 1^{er} Après les 20 premières minutes : la pression sanguine et les pulsations du cœur redeviennent normales. Après les 8 premières heures : L'oxygénation des cellules redevient normale. Après les 24 premières heures : Le risque de crise cardiaque diminue déjà. Les poumons commencent à éliminer le mucus et les résidus de fumée. Le corps ne contient plus de nicotine. JOURS 2 À 3^{es} Après 48 heures : Le goût et l'odorat s'améliorent. Après 72 heures : Respirer devient plus facile. Les bronches commencent à se relâcher et on se sent plus énergique. MOIS¹³ Après 2 semaines à 3 mois : La toux et la fatigue diminuent. On récupère du souffle. On marche plus facilement. Après 1 à 9 mois : Les cils bronchiques repoussent. On est de moins en moins essoufflé. ANNÉES¹³ Au bout d'un an : Le risque de crise cardiaque diminue de moitié. Le risque d'attaque cérébrale rejoint celui d'un non fumeur. Au bout de 5 ans : Le risque de cancer du poumon diminue presque de moitié Après 10 à 15 ans : L'espérance de vie redevient identique à celle des personnes n'ayant jamais fumé.
Conseil minimal	Devoir des professionnels de santé, devant toute personne qui vient consulté on se doit de demander "est ce que vous fumez?", s'il répond oui on doit demander s'il envisage d'arrêter? est ce qu'il redoute cet arrêt? Quelles sont les raisons qu'il pourrait avoir d'arrêter de fumer? Même s'il dit qu'il ne veut pas arrêter de fumer, il faut avoir quelques phrases lui disant qu'au niveau de sa santé ça va être toxique mais c'est souvent difficile de trouver une motivation. Le Conseil Minimal <pre> graph TD A[A : Devant tout fumeur : le conseil minimal] --> B{Fumez-vous ?} B -- Non --> C[Stop] B -- Oui --> D{Voulez-vous arrêter ?} D -- Non --> E[Intervention brève : - Evoquer les raisons pour continuer à fumer - Evoquer la disponibilité que vous pouvez offrir au patient pour en reparler quand il sera prêt à tenter un sevrage] D -- Oui --> F{Redoutez-vous l'arrêt ?} F -- Non --> G[Proposer une discussion sur le tabagisme - Donner des informations sur les bénéfices d'un sevrage - Distribuer une brochure sur le tabagisme] F -- Oui --> H[Instaurer un climat de confiance - Proposer un discours neutre et positif : il est toujours possible d'arrêter de fumer - Rassurer] </pre> Ce conseil minimal qui prend que 2 ou 3 minutes, quand il est fait par un médecin ou autres, le taux de succès à l'arrêt par rapport à un arrêt spontané est déjà nettement augmenté. Si cette question est posée par tous les médecins on gagne 2% d'arrêts en plus.
Pourquoi l'arrêt est si difficile?	La principale raison est que la nicotine est une drogue. Comme toute drogue, quand on arrête la nicotine on peut présenter un syndrome de sevrage ⇒ "pulsions à fumer", troubles de la concentration, augmentation de l'appétit, insomnies, irritabilité, agressivité, anxiété, humeur dépressive. Dépendance s'évalue par le test de Fagerstrom: 2 questions pour le test minimum mais existe aussi en 6 questions ⇒ recueillir le nombre de cigarette fumé par jour et le délai qui se passe entre le réveil et la première cigarette. Quand on ne fume pas la nuit, le cerveau le matin n'a plus de nicotine et donc la 1ère cigarette quand on est dépendant va venir dès le réveil. Dès le score 2 ou 3 on a une dépendance modérée. La nicotine est la drogue la plus addictive ⇒ plus que cocaïne, héroïne, alcool, par ex. ★ Pour mémoire : Un test de Fagerstrom¹³ simplifié en deux questions a également été élaboré. Il prend en compte le délai entre le réveil et la première cigarette et les quantités moyennes de cigarettes fumées chaque jour. Combien (n) de cigarettes fumez-vous par jour ? → n = 10 ou moins : cote = 0 → n = 11 à 20 : cote = 1 → n = 21 à 30 : cote = 2 → n = 31 ou plus : cote = 3 Dans quel délai (t) après le réveil fumez-vous votre première cigarette ? → t = moins de 5 minutes : cote = 3 → t = 6 à 30 minutes : cote = 2 → t = 31 à 60 minutes : cote = 1 → t = après plus d'1 heure : cote = 0 Interprétation : → cote = 0-1 : pas de dépendance ; → cote = 2-3 : dépendance modérée ; → cote = 4-5-6 : dépendance forte.

Prise en charge de la dépendance	Ils sont nombreux car la PEC est difficile • Les substituts nicotiniques : patchs, gommes, pastilles, inhalateur et spray ⇒ ces éléments ne donnent pas le shoot que donne la cigarette, c'est ce shoot qui va faire durer la dépendance. La désadaptation progressive à la nicotine va donc être plus facile • La Varénicline (Champix) ⇒ en 2^{de} ligne quand les substituts n'ont pas marché • Le Bupropion (Zyban) • Les Thérapies cognitives et comportementales : ⇒ le but est de changer les comportement qu'on avait mis en place en tant que fumeur, ex fumer en buvant un café ⇒ il faut trouver autre chose à faire en buvant son café, voire arrêter le café, modifier ses pensées. Thérapie d'accompagnement au changement qui souvent sont faites par des psychologues • Hypnose • Auriculothérapie • Acupuncture • Magnétiseur, Homéopathie ⇒ pas de validation scientifique mais peuvent être une aide intéressante • Cigarette électronique...														
Motivations	Accompagnement avec des entretiens qui ont pour but d'augmenter la motivation ⇒ Il faut trouver des raisons Personnelles et pérennes qu'on a d'arrêter de fumer : - La peur ⇒ raison qui dur pas trop longtemps - La famille - Meilleur odorat, goût, haleine - Les économies ⇒ prix qui augmente - Ne plus être esclave - Ma santé (et celle de mon entourage) - Meilleur souffle, - Mesure de CO - Gagner un pari Le patient doit trouver la motivation qui va lui permettre de se sevrer sans trop de difficultés.														
Efficacité comparé	1. SN seuls 2 2. soutien comportemental seul. 3. soutien comportemental + SN 4. soutien comportemental et Bupropion 5. soutien comportemental et 2 formes de SN (patchs et pastilles ou gommes) ⇒ la plus recommandé actuellement 6. soutien comportemental et Varenicline														
Autres façons de fumer	<table border="1" data-bbox="323 1209 986 1653"> <thead> <tr> <th></th><th>Equivalent/Cigarettes</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tabac à rouler</td><td>= 1 – 2 cigarettes</td></tr> <tr> <td>Cigarillo</td><td>= 2 cigarettes</td></tr> <tr> <td>Le cigare</td><td>1 heure = 20 cigarettes</td></tr> <tr> <td>La Pipe</td><td>= 5 cigarettes</td></tr> <tr> <td>Le narguilé / La chicha</td><td>1h = 20 à 40 cigarettes</td></tr> <tr> <td>Tabagisme passif</td><td>1h = 5 cigarettes</td></tr> </tbody> </table> Tabac à rouler: moins cher mais plus nocif (contrairement à leur réputation) que les cigarettes manufacturées car les rendements de goudrons et de nicotine sont nettement supérieurs; <u>Les cigarettes roulées sont rallumées à plusieurs reprises renforçant l'exposition au CO et aux goudrons.</u> Narguilé ou Chicha : fumée refroidie en passant à travers l'eau qui va plus profondément dans les poumons, durée d'exposition plus longue. + Ambiance souvent fermée donc tabagisme passif ++		Equivalent/Cigarettes	Tabac à rouler	= 1 – 2 cigarettes	Cigarillo	= 2 cigarettes	Le cigare	1 heure = 20 cigarettes	La Pipe	= 5 cigarettes	Le narguilé / La chicha	1h = 20 à 40 cigarettes	Tabagisme passif	1h = 5 cigarettes
	Equivalent/Cigarettes														
Tabac à rouler	= 1 – 2 cigarettes														
Cigarillo	= 2 cigarettes														
Le cigare	1 heure = 20 cigarettes														
La Pipe	= 5 cigarettes														
Le narguilé / La chicha	1h = 20 à 40 cigarettes														
Tabagisme passif	1h = 5 cigarettes														
La cigarette électronique	Cigarette qui contient une batterie au Lithium, va déclencher le chauffage d'une cartouche qui contient un liquide et qui contient ou non de la nicotine  Nicotine Les cartouches de nicotine existent en différentes concentrations : ■ 6-8 mg / ml ■ 10-14 mg / ml ■ 16-18 mg / ml ■ 24-36 mg / ml Arôme liquide Certaines cartouches imitent les saveurs des cigarettes ordinaires : tabac régulier, menthol, fruits, vanille, caramel, café, etc. concentration max de nicotine en France : 20mg/ml														

Cigarette électronique	 Plus de CO car c'est de la vapeur d'eau, on ne connaît pas encore les conséquences pour la santé à moyen et long terme.															
Comparaison CE et cigarette classique	<table><tr><th>Substances de la fumée de cigarette</th><th>Pathologies</th><th>Substances de la vapeur de e-cigarette</th></tr><tr><td>Nicotine +++</td><td>addiction</td><td>Nicotine +/- à +++ Si la e-cig en contient</td></tr><tr><td>Carcinogènes +++</td><td>cancers</td><td>Carcinogènes Nitrosamines Traces ou 0</td></tr><tr><td>CO +++</td><td>M C V</td><td>CO : Non</td></tr><tr><td>Irritants +++</td><td>Irritation (ORL et bronchique) BPCO</td><td>Irritants + (Propylène glycol, glycérols formaldéhyde...)</td></tr></table> On peut être sûr que la CE est moins toxique, elle peut ne pas contenir de nicotine et de toute manière on a vu que ce n'était pas la nicotine qui posait un problème pour la santé. Elle cause "seulement" l'addiction. Carcinogène en bcp plus grande quantité dans la fumée que dans la vapeur Pas de CO dans la CE ⇒ pas de risque pour maladie cardiovasculaire Beaucoup moins d'irritant dans la vapeur mais améliore par forcément l'asthme pour le cas des asthmatiques fumeurs, et on observe toujours de la toux avec la CE	Substances de la fumée de cigarette	Pathologies	Substances de la vapeur de e-cigarette	Nicotine +++	addiction	Nicotine +/- à +++ Si la e-cig en contient	Carcinogènes +++	cancers	Carcinogènes Nitrosamines Traces ou 0	CO +++	M C V	CO : Non	Irritants +++	Irritation (ORL et bronchique) BPCO	Irritants + (Propylène glycol, glycérols formaldéhyde...)
Substances de la fumée de cigarette	Pathologies	Substances de la vapeur de e-cigarette														
Nicotine +++	addiction	Nicotine +/- à +++ Si la e-cig en contient														
Carcinogènes +++	cancers	Carcinogènes Nitrosamines Traces ou 0														
CO +++	M C V	CO : Non														
Irritants +++	Irritation (ORL et bronchique) BPCO	Irritants + (Propylène glycol, glycérols formaldéhyde...)														
Toxicité CE	- Effet toxique aigu si ingestion du liquide (nausées, vomissements, céphalées, vertiges). Ingestion par un enfant d'une cartouche de 10 ml peut être létale. - Utilisation par Non fumeurs : risque addiction nicotine (26% des 15-25 ans, 58% des fumeurs ont essayé la e-cigarette « Janvier 2018 , une étude publiée par le Journal of the American Medical Association montrait que les jeunes qui vapotent la cigarette électronique sont deux à trois fois plus susceptibles de devenir fumeurs que ceux qui n'ont jamais fumé la e-cigarette » ⇒ bon moyen d'arrêter mais ne doit pas être une porte d'entrée dans le tabagisme - 30% des vapoteurs n'ont jamais fumé ou étaient d'ex-fumeurs - 75% des vapoteurs fument aussi du tabac - Toxicité cutanée															

Avis Haut Conseil de la Santé Publique	Recommandations : – Poursuivre lutte anti tabac – Informer sans publicité professionnels de santé et fumeurs – Maintenir modalités d'interdiction de vente (en particulier en pharmacie) et de publicité – interdiction utilisation dans les lieux à usage collectif – « Données scientifiques insuffisantes pour recommander ce produit à nos patients » mais il faut accompagner ceux qui l'ont choisie. Invitation – À faire des études épidémiologiques et cliniques sur la e-cig – A clarifier le statut – A assurer le maximum d'information aux consommateurs. Quantité de nicotine, arômes artificiels souvent inconnus. Eviter les produits importés – A engager l'industrie pharmaceutique pour créer une e-cig « médicament »
Convention-Cadre de l'OMS pour la lutte anti-tabac (CCLAT) 2003	Réduire la demande de tabac – Augmentation du prix en majorant les taxes : la plus efficace si hausse importante (au moins 10% du prix du paquet) – Protection contre la fumée passive : interdiction de fumer dans les lieux publics et espaces de travail. Ceci change aussi l'image sociale du tabac. – Réglementation de la composition des produits du tabac – Réglementation sur l'emballage (information des conséquences sur la santé, suppression de la mention « light ») – Interdiction publicité (qui fait du tabac un produit « normal » et qui est efficace auprès des jeunes), promotion et parrainage – Programmes d'éducation, communication et formation : dia suivante – Mesures d'aide à la prise en charge de l'arrêt du tabac : aide comportementale et/ou médicamenteuse accessible et d'un coût abordable Réduire l'offre de tabac – Lutte contre le commerce illicite (contrebande, contrefaçon) – Interdiction « active » de la vente aux mineurs et par les mineurs – Programmes d'aides économiques pour l'abandon de la culture du tabac et remplacement par autres activités
Education, formation, communication, sensibilisation du public	Informar sur les conséquences négatives du tabagisme et les avantages d'une vie sans tabac Campagnes de prévention grand public : rendre le tabac moins attractif socialement. Journée Mondiale Sans Tabac, tous les 31 mai, instaurée par l'OMS. Intervention sur le terrain : projets spécifiques auprès de publics prioritaires (jeunes et populations vulnérables) - intervention dans les milieux de vie, avec les personnels qui travaillent dans ces milieux spécifiques - messages adaptés aux caractéristiques et aux besoins Formation de professionnels-relais des secteurs social, médical, de l'enfance et de la jeunesse
Politique anti-tabac en France	Prévention structurelle – Interdiction vente aux mineurs – Interdiction fumer dans les lieux publics – Interdiction de promouvoir le tabagisme – Suppression appellation « light », « légères » ou « mild » – Paquets neutres et avertissements sanitaires « choc » – Augmentation du tarif de vente des produits du tabac Prévention comportementale – Forfait/remboursement SN – Consultations de tabacologie – Assistance téléphonique (3989), application mobile site internet Tabac Info Service – « Moi(s) sans tabac », – Journée mondiale sans tabac le 31 mai – Education à la santé dans collèges et Lycée Ne pas Commencer!

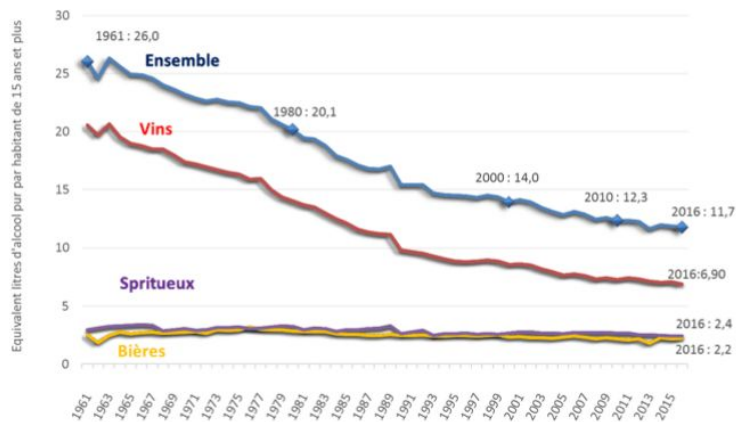
Relation Prix / Consommation	Le marché des cigarettes presque divisé par deux depuis l'an 2000 ● Ventes de cigarettes en France (en milliards d'unités) ● Prix du paquet de cigarettes de la marque la plus vendue (en euros) PRÉVISIONS POUR 2020 10 € le paquet 82,5 milliards de cigarettes vendues (2000) 44,9 milliards de cigarettes vendues (2016) 3,20 € le paquet (2000) → 7 € le paquet (2016) - 45,6 % depuis 2000 Augmenter le prix est une mesure de santé publique efficace. Mois sans tabac: kit, application, numéro de téléphone, mobilisation des professionnels de santé.
Espoir	- 29,4% (2016) 26,9% (2017) de fumeurs quotidiens en France. ⇒ 1ère fois que ça diminue - Pour la première fois en 2017, 1 million de fumeurs quotidiens en moins (y compris dans les populations précaires) - 66 % des fumeurs (contre 58% en 1999) déclarent avoir envie d'arrêter de fumer.
Impact sur l'environnement	- Déforestation : 200000 hectares de forêts disparaissent chaque année en raison de la plantation de tabac soit 1, 5% de la déforestation globale (12m³ de bois sont nécessaires à la fabrication d'une tonne de tabac). - Pesticides : Le tabac est une plante fragile susceptible d'attraper de nombreuses maladies, d'où l'utilisation d'importantes quantités de fertilisants, herbicides, pesticides. La fumigation des sols avant la pousse est réalisée avec du bromure de méthyl, portant fortement atteinte à la couche d'ozone. - Appauvrissement des pays producteurs : L'affectation des terres actuellement utilisées pour les cultures du tabac, à des cultures vivrières permettrait de nourrir de 10 à 20 millions de personnes. - Pollution et incendies : 220 millions de mégots jetés tous les jours soit 122 tonnes d'ordures. Les filtres pour les cigarettes nécessitent plus de 12 années pour être décomposés. Les 4, 5 milliards de mégots dispersés chaque année dans le monde tuent des millions d'oiseaux, poissons..... - Les cigarettes constituent la première source de déchets dans le monde sur les plages : 1,9 millions de débris mégots sur 7,7 millions de débris. Les cigarettes représentent la principale sources de déchets dans les rues, soit 70 à 90% de tous les déchets urbains.

Alcool : risque et prévention

Epidémiologie la consommation d'alcool en France

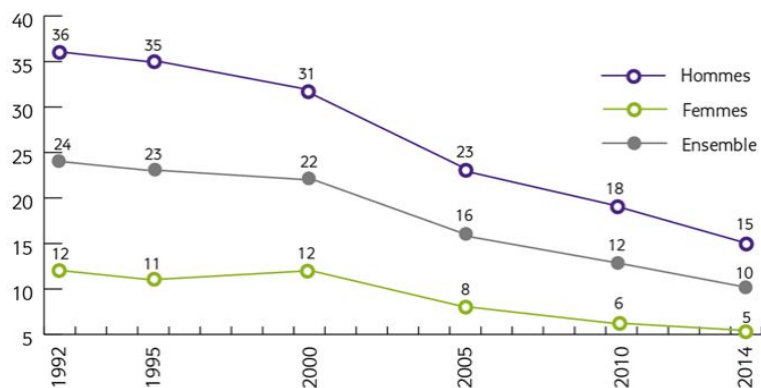
- En population générale (Baromètres Santé)
- A l'âge de 17 ans (étude ESCAPAD)
- Au collège (étude BLITZ - Isère)

Quantité d'alcool consommé par habitant âgés de 15 ans et plus depuis 1961 (en litre équivalents alcool pur)



La consommation d'alcool tend à diminuer depuis 1961, principalement pour vin.
On passe de 26 L à 11,7 L.

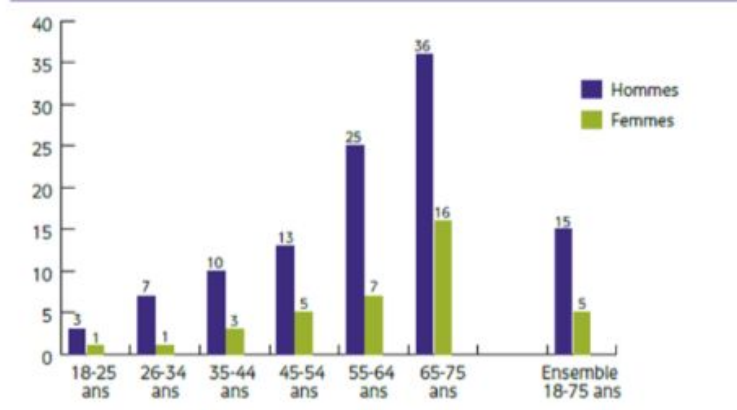
Evolution de l'usage quotidien d'alcool au cours des 7 derniers jours parmi les 18-75 ans



Source : Baromètre santé 1995, 2000, 2005, 2010 et 2014, Inpes - OFDT

L'usage quotidien est aussi en nette diminution. On remarque que l'usage quotidien est plus élevé chez les hommes que chez les femmes (quelque soit la classe d'âge).

Figure 1 - Usage quotidien d'alcool, selon le sexe et l'âge en 2014 (en %)



Source : Baromètre santé 2014, INPES

A 17 ans (étude ESCAPAD – OFDT)

- L'expérimentation d'alcool est en **net recul depuis 2008**, tout comme l'usage régulier (10 verres et plus par mois).
- Cela concerne cependant **8,4% des jeunes**, surtout les garçons (3 fois plus nombreux que les filles) : **12,0%** vs 4,6%
- Les alcoolisations ponctuelles importantes (API : 5 verres ou plus en une occasion) au cours du mois concernent **44,0%** des jeunes.

Enquête Blitz de l'OTCRA

- 8 115 jeunes de 13-14 ans (classes de 4ème) provenant de 69 collèges de l'Isère ont rempli un questionnaire anonyme (30 mn de passation) entre octobre 2017 et février 2018.
- Cette enquête sera proposée chaque année, afin d'obtenir une photographie du climat scolaire, du bien-être des élèves, des usages de substances et autres conduites à risque, ainsi que de la relation qu'il entretiennent avec la société.

As-tu déjà bu de l'alcool ?

	N	%
Oui	3799	47,9
Non	4127	52,1
Total	7926	100,0

As-tu déjà consommé de l'alcool au point d'être complètement ivre?

	N	%
Non, jamais	7356	93,1
Oui, 1 fois	364	4,6
Oui, 2 fois ou plus	185	2,3
Total	7905	100,0

Devenir de l'alcool dans l'organisme • Absorption • Passage dans le sang • Élimination • Courbe d'alcoolémie

Absorption de l'alcool et passage dans le sang

Par la muqueuse buccale et l'œsophage (très faible part)

Par l'estomac (chez l'homme ; 20%)

Par l'intestin grêle (80%)

Par **DIFFUSION PASSIVE** (pas d'énergie nécessaire)

Foie : usine de transformation

• Voie principale (ADH et ALDH) – **Alcool** → **acétaldéhyde** → **acétyl coA + CO2**

• Voie du MEOS (microsomes)

• Voie accessoire (catalase)

ALCOOL (ÉTHANOL) → énergie (**un gramme = 7 Kcal**) **non utilisable** → **stockage** dans les graisses

Élimination de l'alcool

Non transformé (5 – 10%)

- air (poumons)

- sueur (peau)

- urines (rein)

Lait maternel : +10%

Transformation (90%) par le **foie** (hépatocytes)

L'ÉLIMINATION DE L'ALCOOL EST LENTE : 0,10 à 0,15 g/l/Heure

Alcoolémie maximale, en 45 à 90 mn

En **45 minutes** après ingestion (**sujet à jeun**)

En **90 minutes** après ingestion (au cours d'**un repas**)

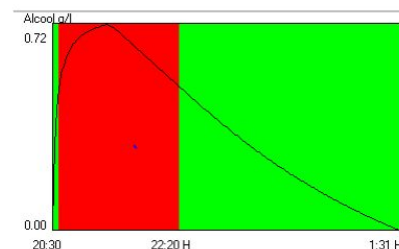
Cela dépend de plusieurs paramètres

- âge, sexe

- à jeun / au cours d'un repas

- boisson gazeuse ou non (absorption plus rapide avec boisson gazeuse)

- ajout de sucre



Inégalité homme- femme

• Pour une même quantité d'alcool ingérée, l'**alcoolémie sera plus élevée chez la femme** que chez l'homme.

• Ceci reste vrai à **poids égal**.

• De plus, l'élimination au niveau du foie sera plus lente chez la femme que chez l'homme (moins d'enzymes de dégradation de l'alcool).

L'association Alcool – Boissons énergisantes est loin d'être anodine

On ressent moins de maux de tête, moins de fatigue, moins souvent la bouche sèche, moindre perception des troubles de la coordination motrice..

Associée à la consommation d'autres substances (tabac, cannabis) ce qui conduit à des **comportements à risque** :

- sport extrême, défit, sexe non protégé, non voulus
- pas de ceinture de sécurité au volant,
- accidents de la route.

Effets sur l'organisme

• Atteinte des **membranes des cellules**

- Déformation
- Rigidité
- Éclatement, remaniement
- Effets à court, moyen et long terme

Tous les organes sont touchés • **Cerveau** • Yeux • Œsophage • Peau • Cœur • **Foie** • Pancréas • Appareil génital • Système nerveux périphérique • Poumon

Mais il faut d'abord parler des effets immédiats, à court terme

- Effets directs de l'éthanol : **l'ivresse**
- Trois phases successives :
 - Phase **d'euphorie** et d'excitation,
 - Phase plus calme, avec **perte de la coordination motrice**, pupilles dilatées, nausées ou vomissements,
 - Phase **léthargique**, sommeil coma

Alcoolisation massive (API) : 5 verres et plus par occasion (jeunes actuels)

- Les risques pour la santé sont nombreux et ne doivent pas être sousestimés :
 - **Rapports sexuels à risques** : le risque de **grossesses non désirées** et d'**infections sexuellement transmissibles** est multiplié par 4 !!
 - Atteinte du système nerveux central avec **lésions cérébrales** ;
 - Apparition d'une **dépendance alcoolique** (dépendance psychologique).
- Un tel comportement a également des conséquences sociales :
 - Comportements **violents** ;
 - Absentéisme et **baisse des performances** scolaires et/ou professionnelles ;
 - Risque accru d'**accidents de la route**.

Atteinte de la matière grise et de la matière blanche liée aux alcoolisations massives (API)

- Depuis quelques années, l'imagerie fonctionnelle (IRM) permet d'objectiver les atteintes cérébrales liées au mésusage d'alcool :
 - atteinte globale,
 - atteinte de la matière grise (cellules nerveuses),
 - atteinte de la matière blanche (fibres nerveuses, glie).
- Ceci entraîne des répercussions sur le **fonctionnement cognitif** : apprentissage, mémorisation et fonctions exécutives.
- Cela **met ainsi en jeu la vie scolaire**, universitaire et l'avenir professionnel des jeunes.

Les effets de l'alcool sur la conduite automobile

- Sensation de bien-être, **de confiance** en soi amenant à sous-estimer le danger,
- **Mauvaise appréciation** des vitesses, des distances, des largeurs et des risques,
- Rétrécissement du champ visuel,
- Prise de risques inutile,
- Freinage violent et brutal,
- Diminution des réflexes,
- Sensibilisation accrue à l'éblouissement lors de conduite nocturne.

Les effets à long terme de l'alcool

- Dépendance à l'alcool (psychologique, physique)
- Cirrhose hépatique, cancer du foie
- Cancer des voies aéro-digestives supérieures (œsophage, cavité orale, larynx)
- Cancer de l'estomac, du côlon, du rectum
- Cancer de la vessie, cancer du poumon
- Pancréatite aiguë
- HTA, infarctus du myocarde
- Diabète
- Polynévrite

Le coût social des drogues en France Pierre Kopp, 2015

Tableau 2 - Synthèse des données d'impact sanitaire des drogues en 2010

Pathologies	Alcool	Cancers	Maladies cardiologiques	Maladies digestives	Autres maladies*	Causes externes*	Inconnues*	Hypertension	Total
Âge au décès	62	67	59	54	63	59	69	63	
Durée de vie en traitement	5	11	7	15	1	0,5	-	6	
Nombre d'années de vie perdus	18	15	21	26	17	21	11	17	
Nombre de malades	143 080	288 915	55 230	607 537	10 230	1 613	311 632	1 418 237	
Nombre de décès	15 200	9 947	7 775	4 076	8 154	1 613	2 286	49 051	
Années de vies perdus	213 918	129 311	163 275	105 976	138 618	33 873	25 146	810 117	

L'ALCOOL EST RESPONSABLE DE 49 000 décès par an, dont 40% avant l'âge de 65 ans

1 verre = 1 unité d'alcool ≈ 10 g d'alcool pur (éthanol)



Un verre de vin à 12 degrés équivaut à un whiskey à 40 degrés pour un volume de bar. Recommandations françaises (2017)

- Pas plus de **2 unités d'alcool par jour**, pour les hommes comme pour les femmes
- Pas plus de 10 unités par semaine, soit 5 jours où l'alcool peut être consommé et 2 jours d'abstinence
- Pour un risque « acceptable » de **1 décès pour 100 attribuable à l'alcool**

Prévention primaire

- Réduire les **consommations** (quantité, fréquence) % **ivresse aiguë**
 - Éviter l'entrée dans la dépendance et la survenue des complications somatiques et psychiques
- Cadre réglementaire et législatif / Campagnes de prévention grand public / Education sanitaire
Centres d'aide (CJC et CSAPA)

Prévention de l'ivresse aiguë

L'IVRESSE PUBLIQUE

L'ivresse publique et manifeste est une infraction réprimant l'état d'ébriété sur la voie publique. Elle a deux objectifs : prévenir les **atteintes à l'ordre public** et **protéger la personne**. Pour être sanctionnée, l'ivresse doit être publique (privée, elle n'est pas interdite) et elle doit être manifeste.

En d'autres termes, l'état d'ivresse est un **fait matériel se manifestant dans le comportement de la personne**, de ce fait elle n'est pas liée à un niveau d'alcool.

Deux types de mesures peuvent intervenir :

- Une sanction pénale par le biais d'une amende de 2e classe (maximum de 150 euros)
- Une mesure de rétention en « chambre de sûreté jusqu'à ce que l'intéressé ait recouvré la raison »

La Loi Évin (10 janvier 1991) Elle interdit :

- la **publicité pour des boissons alcoolisées** dans la presse pour la jeunesse et la diffusion de messages publicitaires à la radio le **mercredi**, et les autres jours entre **17 h et minuit**
- la distribution aux mineurs de documents ou objets nommant, représentant ou vantant les mérites d'une boisson alcoolisée
- la vente, la distribution et l'introduction de boissons alcoolisées dans tous les établissements d'**activités physiques et sportives** (l'ouverture d'une buvette lors d'une manifestation sportive peut toutefois être délivrée sur autorisation)

Le code de la route

Première cause de mortalité sur la route et responsable d'**1 accident sur 3**, la consommation d'alcool avant de prendre le volant est très réglementée.

Taux compris entre 0.5 et 0.8 g/l

- Amende forfaitaire de **135 euros**
- Retrait de **6 points** sur le permis de conduire

Taux égal ou supérieur à 0.8 g/l

- Retrait de **6 points** sur le permis de conduire
- Amende pouvant aller jusqu'à **4 500 euros**
- Immobilisation du véhicule
- Suspension (jusqu'à 3 ans) voire annulation du permis
- Obligation de suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière aux frais du contrevenant

Le code de la route et les jeunes conducteurs

Désormais c'est **0,2 g d'alcool par litre de sang** pour les jeunes conducteurs :

- Désormais, le taux d'alcool autorisé est 0,2 g/l pour tous les permis probatoires.
- La réglementation s'applique à tous les jeunes conducteurs pendant :
 - 3 ans après l'obtention du permis, la perte de 12 points ou l'annulation de son permis
 - 2 ans si le permis a été obtenu dans le cadre de la conduite accompagnée.
- **0.2 g/l, c'est zéro verre d'alcool car dès le 1er verre**, ce seuil peut être dépassé.
- Les jeunes conducteurs contrôlés avec un taux d'alcoolémie supérieur ou égal à 0,2 g/l encours :
 - un retrait de **6 points** sur leur permis.
 - une amende forfaitaire de **135 €**.
 - une **immobilisation** du véhicule.

Les taxes sur l'alcool

- Plus l'alcool est **fort**, plus la **taxe est élevée**.
- Pour une bouteille de **vin**, le total des taxes représente environ **20%** du prix, alors que c'est **60%** pour une bouteille de **Whisky**.
- En plus de la **TVA**, il y a des **impôts indirects** (ou droits d'accise) et la **cotisation de sécurité sociale**, due en raison des risques sanitaires.

Les campagnes de prévention (SPF)

- Depuis 1984, avec le CFES puis l'INPES et maintenant Santé Publique France.
- La communication en matière de lutte contre l'alcool a donc logiquement évolué : du général au particulier, du discours d'alerte à la pédagogie, puis à la valorisation des dispositifs d'aide, de conseil et d'accompagnement, tout en bénéficiant des nouvelles opportunités offertes par les nouvelles technologies de l'information et de la communication.

L'éducation sanitaire auprès des jeunes

- Il s'agit de poursuivre le développement d'actions en milieu scolaire en lien avec l'Education nationale et la promotion d'Alcool Info Service, de mobiliser les professionnels de santé de premier recours et dispositif d'aide à distance.
- En Isère, déploiement de la **méthode Unplugged**, basée sur les **Compétences psychosociales** (CPS) au collège (classe de 4ème) et au lycée (classe de 2nde). Ces CPS sont des facteurs de protection associées aux consommations d'alcool.

Les Consultations jeunes consommateurs (CJC)

- L'objectif de ces consultations est d'**accueillir des jeunes consommateurs** en questionnement sur leur consommation, ainsi que leur entourage.

Les CSAPA ambulatoires Les Centre de Soins, d'Accompagnement et de Prévention en Addictologie, ou CSAPA, permettent de faire le point avec un professionnel sur les difficultés rencontrées.

Sites à consulter

- Observatoire territorial des conduites à risque de l'adolescent (<https://otcra.fr/>)
- Le Village des addictions (<https://www.addictaide.fr/>)
- Alcool Info Service (<https://www.alcool-info-service.fr/>)
- Média d'information scientifique sur les addictions (<http://www.maad-digital.fr/>)
- Observatoire français des drogues et des toxicomanies (<https://www.ofdt.fr/>)
- Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives (<http://www.drogues.gouv.fr/>)
- Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie (<https://www.anpaa.asso.fr/>)

⇒ Objectif: protéger la santé publique

La protection des mineurs

Des règles spécifiques de protection :

- ❑ Lorsque les mineurs sont visés
- ❑ **Dans ou à proximité d'un établissement scolaire**

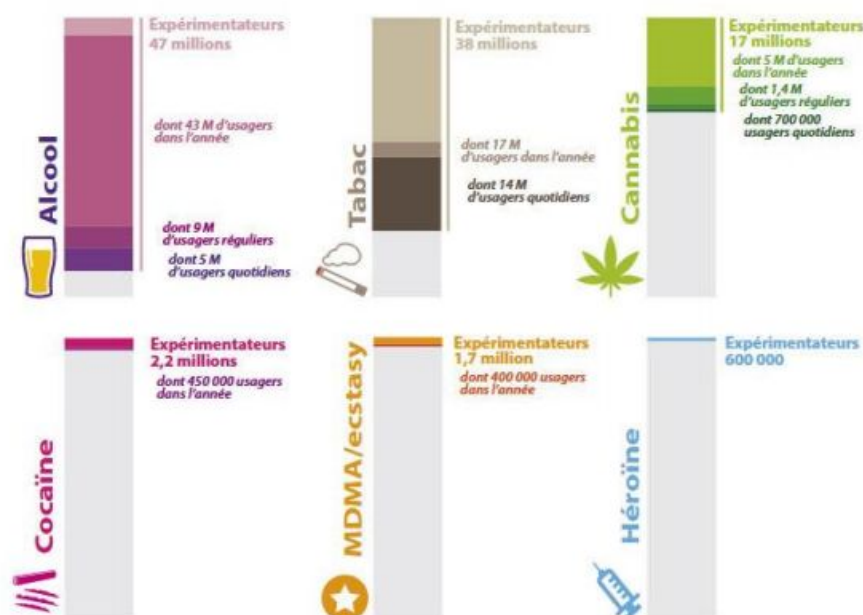
L'école, lieu de règles :

- ❑ Le règlement intérieur des établissements scolaires rappelle l'interdiction par la loi de l'usage et de la possession de stupéfiants
- ❑ **Sanctions disciplinaires** + signalement au **Procureur de la République**

Lieu de prévention et d'aide :

- ❑ Rencontrer le personnel de santé de l'établissement
- ❑ **Consultations Jeunes Consommateurs (CJC)**, maison des adolescents, etc

Epidémiologie



Cannabis = drogue illicite la plus consommée en France !

Europe du Nord : peu consommatrice

Italie, République Tchèque, Espagne consommateurs +++

1. Le cannabis

- Plante : **Cannabis sativa** (chanvre indien)
- Effets **neuropharmacologiques** essentiellement dus au THC

3 formes :

- ❑ **l'herbe** : feuilles, tiges et sommités fleuries séchées → joints
- ❑ la **résine** ou « haschisch », obtenue en pressant les fleurs → joints
- ❑ **l'huile** : résine macérée dans de l'alcool (+ concentrée en principe actif) → consommé à l'aide d'une pipe

Cannabis : caractère **collectif** de la consommation

Appellations : marijuana, ganja, beuh, zeb, weed, zamal, haschisch, h, shit, chocolate...

Prix : **11 €/g herbe** (augmentation car les consommateurs cherchent une herbe de "bonne qualité"), **7 €/g résine**

La teneur moyenne en THC dans les résines, en augmentation depuis les années 2000, semble se stabiliser en 2017 à 23 % . Pour l'herbe, la teneur moyenne est stable depuis 2015 autour de 10 %

En population adolescente

Collégiens	Fin de l'adolescence
- 1ère substance illicite consommée par les adolescents - À partir de la 4ème - Très forte progression entre la 6e (1,4 %) et la fin du collège, où elle est rapportée par près de un jeune sur quatre (23,9 %) - Essentiellement les garçons parmi les + jeunes, mais les écarts s'amenuisent ensuite nettement	- En 2017, près de quatre adolescents de 17 ans sur dix ont déjà fumé du cannabis au cours de leur vie (39,1 %) - Les consommations sont d'autant + masculines que leur fréquence est élevée

⇒ Les jeunes français restent parmi les plus gros consommateurs de cannabis en Europe.

Risques liés à la consommation

Les effets **neuropsychiques** apparaissent environ **15 à 20 mn après son inhalation** chez un consommateur occasionnel, un peu + tard chez un usager régulier

Prise unique : euphorie modérée et sentiment de bien être suivi d'une **somnolence**, d'un affaiblissement de la **mémoire** à court terme et des troubles de l'**attention**, ↑ du **temps de réaction**, troubles de la **coordination motrice** susceptibles d'augmenter les risques associés à la conduite, potentialise les effets de l'**alcool**, symptômes **psychiatriques** : hallucinations, troubles anxieux

Usage régulier : ↓ des capacités de mémorisation et d'apprentissage, **désintérêt** pour les activités habituelles, **fatigue** physique et intellectuelle, humeur **dépressive**

- A un **niveau élevé de consommation** : **dépendance (psychique ++)**, problèmes relationnels, scolaires et professionnels

- A 17 ans, 7,4 % des adolescents seraient susceptibles de présenter un risque élevé d'usage problématique de cannabis

Consommation de cannabis :

→ x3 cancer du poumon

→ x15 risque d'accidents de la route si conduite sous emprise du cannabis

2. Cocaïne

Substance d'origine **végétale**, obtenue par transformation de la feuille de coca

C'est un **stimulant** !

Consommé par **voie nasale** (sniff), par **inhalation** ou **IV**

La cocaïne base, « crack » ou « free base », résulte de l'adjonction de bicarbonate ou d'ammoniac → cristallisation de la poudre en petits cailloux, destinés à être fumés ou plus rarement injectés = effets beaucoup plus puissants et rapides

En 2017, parmi les jeunes âgés de 17 ans, le niveau d'expérimentation de la cocaïne est de 2,8 % (2,4 % ♀, 3,1 % ♂)

Appellations : coke, poudre, blanche, C, CC, coco, caroline, neige

Prix : 80-85 €/g

↑ **très nette de la pureté** de la cocaïne depuis plusieurs années = 65 % en 2017

Principal produit de coupe : **lévamisole** (80 %) = vermifuge utilisé en médecine vétérinaire.

Risques liés à la consommation

Sensation de **puissance intellectuelle et physique**, engendrant une indifférence à la fatigue, couplée à un sentiment d'euphorie. Puis « **phase de descente** », marquée par des symptômes de type dépressif, une anxiété et une forte irritabilité. Les complications : **cardiaques**, **neurologiques**, lésions de la **cloison nasale**, **infections bactériennes** ou **virales** (VIH, VHB et surtout VHC), troubles **délirants**

⇒ Forte **dépendance psychique**, conduisant à des envies irrépessibles de consommer (**craving**)

3. MDMA (ecstasy / amphétamine (speed))

Drogues de **synthèse**

MDMA (cristal ou poudre, ecstasy = comprimé) :



❑ **Hallucinogène** à forte dose

❑ Avalée, mais aussi sniffée, + rarement fumée ou injectée

❑ Appellations : ecsta, E (prononcé à l'anglo-saxonne « i »), X et XTC, Molly, MD

Prix : 54 €/g cristal, 2,5 à 10 €/comprimé d'ecstasy

- Cristal : 27 % en 2009 à 73 % en 2017

- Ecstasy (= comprimé) : 44 mg de MDMA dans un comprimé en 2009, 128 mg en 2017 (dose toxique = 120 mg)

L'amphétamine (speed) :

❑ **Psychostimulant** + puissant

❑ Poudre sniffée + marginalement injectée, pâte, comprimé ou cristal

❑ Appellations : speed, amphet, amphé, crank, Tina

Prix : 15 €/g

Méthamphétamine : marginale en France (crystal Meth)

⇒ Parmi les jeunes âgés de 17 ans, le niveau d'expérimentation de la MDMA s'établit à 3,4 % et 2,3 % pour l'amphétamine

Risques liés à la consommation

Les dérivés amphétaminiques dissipent les sensations de fatigue et de faim, prodiguent un sentiment d'euphorie et d'hyperconcentration, de confiance en soi, et facilitent contacts et communication .

Phase de descente : sensation d'épuisement, dépression, anxiété, confusion, troubles du sommeil peuvent durer parfois plusieurs semaines

Complications : troubles **neuropsychiatriques** (crise d'angoisse, confusion, désorientation, hallucinations), hypertonie, hyperthermie, **troubles cardiovasculaires potentiellement mortels**

4. Héroïne

Opioïde

Poudre blanche (sel acide) ou marron (sel basique) injectée en IV, sniffée ou fumée = « chasser le dragon ».

Propriétés comparables à celles de la morphine, mais action + rapide, + intense et + brève

Prix de l'héroïne brune : 35-40 €/g, pureté : 14-16 %

Des particularités régionales : Lyon, Annemasse, Annecy, etc.

Un usage rare en population adolescente : 0,7 % des jeunes âgés de 17 ans en 2017

Dépendance ++ (**physique** et **psychique**) et « **overdose** » souvent mortelle par **arrêt respiratoire**.

Appellations : héro, came, meca, rabla, poudre, blanche, smack, brown sugar, black tar

5. Hallucinogènes

- **Naturels** : champignons ou plantes (sauge divinatoire)

- De **synthèse** :

- ❑ **LSD** (acide lysergique) : modifications sensorielles intenses. Descente très désagréable avec profond mal être
- ❑ **Kétamine** → ébriété cotonneuse, effet dissociatif entre corps et esprit
- ❑ **GHB/GBL** → ! **SOUSSION CHIMIQUE** !

GBL = précurseur du GHB. Pas inscrit sur la liste des stupéfiants mais interdit à la vente car risque de soumission chimique.

⇒ **Distorsions des perceptions** visuelles, auditives, spatiales, temporelles et de la perception de son corps. Les effets peuvent parfois durer plusieurs jours.

Complications : « bad trips », épisodes délirants, effets parfois durables, traumatismes graves, **comas**

En 2017, 1,6 % de jeunes de 17 ans déclarent avoir consommé du LSD au cours de leur vie (1,3 % ♀ et 1,9 % ♂)

6. Nouveaux produits de synthèse (NPS)

Très **hétérogènes**

« **Imitent** » les effets d'autres substances (ecstasy, cannabis, etc.)

Des structures proches mais pas identiques.

Certains classés stupéfiants, d'autres n'ont pas de statut juridique clair

Généralement achetés sur **internet**.

En France :

- ❑ **Cannabinoïdes** de synthèse ou « Spice », proches du **THC**
- ❑ **Phénéthylamines**, proches soit de la **MDMA** (cathinones), soit du **LSD**
- ❑ **Méthoxétamine** (MXE) → effets apparentés à la kétamine mais effets plus puissants et plus durables

Problèmes : Véritable nature des produits ? Grande variabilité des dosages, donc des effets ressentis et indésirables.

La plupart des NPS identifiés en Europe ont été produits et importés de **Chine** et dans une moindre mesure **d'Inde**.

En Europe : plus de 450 NPS depuis 1997

Prix : 8 à 20 €/g sur internet, 3x supérieur dans la rue

Associés à des pratiques dites « **Slam** » ou « **Chemsex** » → utilisation dans un cadre sexuel.

3,8 % des jeunes de 17 ans déclarent avoir déjà consommé un produit imitant les effets d'une drogue

11,8 % d'entre eux ont précisé de quel produit il s'agissait, principalement un cannabinoïde de synthèse.

7. Licites mais pas sans risque : poppers, protoxyde d'azote

Poppers	Protoxyde d'azote
- Dérivés du nitrite, autorisés en France - <u>Inhalation</u> : euphorie, rire, vasodilatation, contexte sexuel → facilite l'érection, retarde l'éjaculation. - <u>Appellations</u> : arôme, encens liquide (room odorizer), Rush®, Jungle Juice®, Pig Juice®, Fuck Me®, Sex Line®, Gate®, Hot®, Bronx®, Girly Power®, Wesh Cousin® (liste non exhaustive) <u>Risque et expérimentation</u> <u>Prise unique</u> : nausées, vomissements, céphalées • <u>Prises répétées</u> : lésions nasales et du visage, atteintes hépatiques <u>Intoxication</u> : hypotension artérielle et troubles cardiovasculaires exceptionnellement mortels, anémie aiguë et grave (méthémoglobinémie) et perte prolongée de l'acuité visuelle En 2017, 8,8 % des jeunes de 17 ans ont expérimenté les poppers	- Gaz détourné de son usage initial pour ses propriétés euphorisantes - Inhalation - <u>Risques</u> : brûlures par le froid, asphyxie et décès, chute grave, risque potentiellement mortel de fausse route <u>Usage régulier</u> : pertes de mémoire, troubles de l'humeur, hallucinations visuelles, troubles du rythme cardiaque <u>Appellations</u> : gaz hilarant, bonbonne, proto, ballon, oxyde nitreux, N2O

En résumé

⇒ **Toute consommation expose à des risques !**

Toujours préférable de s'abstenir ou de ↓ les risques :

- Reporter la consommation quand on se sent fatigué, stressé, mal ou qu'on éprouve de l'appréhension
- Ne pas consommer seul mais avec des gens de confiance, dans un contexte rassurant, certains ne consommant pas (hallucinogènes)
- Être attentif aux doses, surtout les 1ères fois
- Éviter de consommer plusieurs produits en même temps, alcool compris
- Limiter la fréquence de consommation
- L'injection est à éviter
- Ne jamais partager le « matériel » (paille, seringues, etc.), préférer l'utilisation de kits disponibles dans des centres ou en pharmacie (wtf)
- Ne pas utiliser de bangs artisanaux
- Ne pas conduire de véhicule ou entreprendre une activité « à risques »
- Boire régulièrement de l'eau (stimulants) pour éviter la déshydratation
- Appeler les secours si vous vous sentez mal ou si vous êtes témoin
- Rassurer face à une réaction de panique (« bad trip »)

Médicaments

Usage simple	Consommation sans complication / ponctuelle par curiosité ou par entraînement / occasionnelle en petite quantité.
Mésusage	Utilisation intentionnelle non conforme d'un médicament
Abus	Consommation intentionnelle et excessive d'un ou plusieurs produits avec des conséquences préjudiciables à la santé
Pharmacodépendance (OMS)	- Relation aliénante à une substance psychoactive, dont l'absence de consommation entraîne une souffrance psychique, voire physique, caractérisé par un état de manque - Désir obsessionnel hautement prioritaire de s'en procurer et d'en consommer de manière compulsive (craving), quelles que soient les conséquences pour sa santé

Dépendance PSYCHIQUE	Dépendance PHYSIQUE
- Le plus puissant des facteurs de dépendance ! 2 mécanismes : - Etat de satisfaction dû au plaisir (renforcement positif) - Soulagement d'un malaise engendré par la privation du médicament (renforcement négatif)	- Que certains médicaments - Adaptation de l'organisme à une consommation prolongée (tolérance) - ↑ des doses pour retrouver l'effet initial - La privation du médicament entraîne un syndrome de sevrage

La dépendance médicamenteuse

Dépendance médicamenteuse méconnue	Dépendance médicamenteuse avérée	Dépendance médicamenteuse des toxicomanes
Dérive d'une prescription médicale = escalade médicamenteuse	- De nombreuses classes de médicaments peuvent aboutir à une addiction ⇒ Dépendance secondaire	- Traitements de substitution aux opiacés (TSO), licites - Toxicomanie de trafic, illicite

La toxicomanie médicamenteuse peut aboutir à des comportements de transgression : ordonnances volées, détournées.... L'enquête **OSIAP** (Ordonnances Suspectes Indicateur d'Abus Possible) permet chaque année pendant 1 mois d'identifier les médicaments détournés à partir d'ordonnances falsifiées présentées en pharmacie.

En 2016 :

- ☐ 1326 ordonnances falsifiées recueillies pendant 1 mois
- ☐ Les demandeurs étaient le + souvent des hommes
- ☐ L'âge moyen était de 42,1 ± 14,7 ans
- ☐ Dans 16 % des cas, le patient était connu de la pharmacie

Critères : falsification évidente, éléments de contexte suspect (refuse de présenter sa carte vitale, « part en courant ») ou ordonnances volées

Le médicament le plus détourné est un hypnotique apparenté aux BZD appelé **Zolpidem**

Les comportements de transgression

Finalités : Récréatives , Lucratives , Délictuelles , Criminelles

La **soumission chimique** en particulier, se définit comme l'administration volontaire de substances psychoactives à l'insu d'une victime à des fins criminelles ou délictuelles : viol, violence, vol, etc.

1. Les médicaments psychotropes

Plusieurs catégories qui agissent sur l'activité cérébrale :

- ❑ **Anxiolytiques et hypnotiques** (**benzodiazépines** : dépendance **physique** et apparentés +) : diminuent l'angoisse en anxiété
- ❑ **Antidépresseurs** : rarement usage addictive
- ❑ **Antipsychotiques**
- ❑ **Régulateurs de l'humeur** (lithium notamment)
- ❑ **Psychostimulants** (méthylphénidate et modafinil) : trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité ou narcolepsie.

Dans la majorité des cas, la prise de ces médicaments ne relève pas de pratiques toxicomaniaques, mais thérapeutiques (**automédication**). Du fait des perturbations de la vigilance et des dépendances que certains entraînent, ces médicaments peuvent donner lieu à des usages problématiques ou à risques

Des produits illicites

Les médicaments psychotropes sont obtenus sur **prescription**, même s'ils n'ont pas toujours été prescrits au consommateur lui-même . L'obtention par ordonnance falsifiée semble marginale : 11 benzodiazépines ou apparentés figurent dans le top 20 des tentatives de falsification d'ordonnance . Si le marché parallèle de médicaments peut être bien visible dans certaines zones des grandes villes, aucun trafic organisé de médicaments psychotropes non opiacés n'a été repéré . Aucune information sur le poids du commerce de médicaments sur internet

Epidémiologie

Consommation française de psychotrope (BZD) = **une des plus importante d'Europe**.

Entre 2012 et 2015, la France a quand même connue la plus forte diminution de consommation de BZD.

Très peu de données quantitatives permettant de mesurer l'addiction aux psychotropes.

⇒ **enjeu de santé publique !**

En population adolescente : les jeunes filles sont plus concernées que les garçons.

→ banalisation des psychotropes chez les adolescents

Risques liés à la consommation de psychotropes

1. Chez l'ensemble des consommateurs : troubles de la **mémoire** et du comportement, baisse de la **vigilance**, facilitant la survenue d'accidents

- Principalement pour les **benzodiazépines**
- Risques plus importants en début de traitement, lors de prises occasionnelles, en association avec l'alcool ou d'autres psychotropes

2. Des risques **propres à chaque individu** (en cas d'antécédents médicaux particuliers, de variations du métabolisme hépatique, de traitement au long cours, etc.)

3. Des **mésusages** de médicaments : abus, dépendance ou l'usage pour un autre effet que thérapeutique (usage « récréatif », dopage pour les psychostimulants, soumission chimique, etc.)

⇒ la prise de médicaments psychotropes **interdit la conduite** (pictogramme n°3) → BZD responsables de la moitié des accidents mortels impliquant les médicaments.

Tous ces risques sont majorés en cas d'usage non conformes :

- **durée** de prescription non respectée

Anxiolytiques maximum **12 semaines**

Hypnotiques **4 semaines**

→ Pourtant la durée médiane de traitement par une benzodiazépine est de 7 mois !

- Consommation chez les **usagers de drogues**

- Principalement les **benzodiazépines**
- Rarement voie d'entrée dans la toxicomanie
- 29 % des usagers actifs déclarent en avoir pris au cours du dernier mois
- Des pratiques d'injection sont parfois décrites

- Risque **d'usage criminel**

Benzodiazépines et soumission chimique

2. Les opiacées

Famille de produits obtenus à partir de **l'opium**, produit sédatif d'origine naturelle, provenant de cultures de **pavot**:

- ❑ **alcaloïdes naturels (opiacés)** : morphine, codéine, papavérine, noscapine, buprénorphine
- ❑ **semi-synthétiques ou synthétiques (opioïdes)** : héroïne, hydromorphone, hydrocodone, oxycodone, oxycodone, méthadone, dihydrocodéine, tramadol, fentanyl

→ Prescrits comme **antalgiques** ou **antitussifs**, **TSO** -traitement de substitution aux opiacés) ou comme **anesthésiques**

Antalgiques opiacés

- Indiqués dans les douleurs **modérées à sévères**
- Capacité ++ à induire une dépendance **psychique** et **physique**

Antalgiques de palier II (opioïdes faibles) : **codéine, dihydrocodéine, tramadol, opium**

- Possible détournement d'usage
- Risque de dépendance majoré en cas d'usage prolongé à dose élevée
- Possible dépendance **physique**, surtout avec la codéine et le tramadol

Antalgiques de palier III (opioïdes forts) : **morphine, fentanyl, oxycodone, hydromorphone**

- Lorsque les antalgiques moins puissants sont insuffisants
- Dans les douleurs non cancéreuses : utilisation la + courte possible !
- Possible dépendance **psychique** et **physique** rapide

Epidémiologie

Le recours aux opioïdes forts a nettement augmenté ces dernières années.

SIGNES D'INTOXICATIONS PAR OPIACÉS OU OPIOÏDES

1. **Coma** (calme, hypotonique, avec myorelaxation)
2. **Bradypnée** (fréquence respiratoire $\leq 12/\text{min}$)
3. **Myosis** (bilatéral, serré, en tête d'épingle)

Tous les morphiniques induisent une **dépression respiratoire** faisant courir le risque d'apnée centrale et de décès. L'association fréquente de psychotropes, tels que les benzodiazépines ou l'alcool, $\uparrow$ l'intensité de la dépression respiratoire. La consommation par voie injectable expose à des abcès et à des risques de contamination (VIH, VHC, VHB)

Antitussifs opiacés

« **Purple drank** » = boisson à base de sirops antitussifs (prométhazine = anti H1, codéine) et de soda

- 1ers signalements rapportés en France en 2013
- **Potentiel d'abus et de dépendance** : adolescents (♂ et ♀), jeunes adultes
- **Risques** : troubles de la vigilance (sommolence), du comportement (agitation, confusion, délire), convulsions, décès
- En 2017 : 8,5 % des jeunes de 17 ans déclaraient avoir déjà consommé

En résumé

- Parmi les médicaments psychotropes, les **anxiolytiques** et **hypnotiques** présentent un potentiel addictif reconnu
- **Hypnotiques** : PAS de prise régulière sur une longue période
- **Anxiolytiques** : dose minimale efficace pour limiter le risque de dépendance
- Le **sevrage** des psychotropes peut nécessiter une **hospitalisation**, il est toujours **très progressif**, sur plusieurs **semaines** et guidé par les symptômes
- ⇒ **DANGER** en cas de prise concomitante **d'alcool**
- ⇒ **DANGER** vis-à-vis de la **conduite**
- Les antalgiques ou antitussifs opiacés présentent un risque majeur d'abus ou de dépendance
- Antalgiques opiacés : réévaluation régulière et **arrêt progressif**
- Les **antitussifs opiacés ne sont plus disponibles en vente libre** depuis juillet 2017
- La dépendance aux opiacés peut nécessiter la mise en œuvre d'un TSO, des mesures d'accompagnement psychologique et de soutien à long terme pour prévenir une rechute
- L'intoxication ou « **overdose** » aux opiacés fait courir un risque de **décès**
- D'autres médicaments peuvent faire l'objet d'abus et/ou de dépendance : antihistaminiques sédatifs, antiparkinsoniens, antimigraineux, laxatifs et diurétiques (troubles du comportement alimentaire), corticoïdes et bronchodilatateurs (dopage), vasoconstricteurs, etc.
- **Les signes d'alerte** : $\uparrow$ des doses, nomadisme médical ou pharmaceutique, demande insistante pour un médicament et refus d'une alternative, prise du traitement des proches ou automédication...
- Les médicaments en vente libre ne sont PAS sans danger !

Les écrans

Utiliser de manière excessive les écrans : une addiction, vraiment ?

Epidémiologie Sommes-nous accros aux écrans ?	- Chez les jeunes (11 – 25 ans) - Durée d'expo + activités faites sur les écrans - Rapports du HCSP (2019) et de la MIDECA (2021) en France : Parmi les 15 – 24 ans : 24% regardent des vidéos + de 4h par jour 33% jouent à des jeux en ligne + de 4h par jour 80% déclarent passer plus de temps que prévu devant les écrans - Les adolescents qui passent + de 7h par jour devant les écrans... 11% des 11-14 ans 23% des 15-17ans - Surtout : - Les réseaux sociaux pour les filles - Les jeux vidéos pour les garçons = Disparités de conso selon le genre - Pas vraiment le cas pour le visionnage de vidéos
Définitions Peut-on parler d'addiction aux écrans ?	- Ajd : pas de reconnaissance par l'association américaine de psychiatrie - Mais on en parle dans la littérature scientifique (« digital addiction, internet addiction, smartphone addiction ») - On voit également d'autres notions qui s'y rapportent : - La Nomophobie : peur excessive d'être séparé de son smartphone - Le Sd FOMO : l'anxiété éprouvée à l'idée de rater des informations jugées importantes notamment sur les réseaux sociaux - Smombie : néologisme entre Smartphone et Zombie = être toujours accroché à son smartphone, même en marchant - Suède : panneaux de signalisation dans certains endroits car cela a causé des accidents -> prévenir les voitures - C'est un pbatique très actuelle, qui fait l'objet de recherches pour sa reconnaissance comme une pathologie - Mais vraie reconnaissance dans la littérature scientifique comme une pbatique à traiter - Des critères sont déclarés/observés chez certains utilisateurs : - Difficultés voire échec à planifier, surveiller et contrôler sa consommation d'écrans - Des csq négatives psychologiques, physiques et relationnelles dans leur quotidien
Facteurs de risque	- Modèle théorique I6PACE : cherche à mettre en lumière les processus sous jacents au dvpt et au maintien d'une utilisation pbatique d'internet - Ce modèle permet de décrire qq fdr : - Facteurs génétiques - Sursensibilité des systèmes dopaminergiques à la récompense - Facteurs acquis et environnementaux : - Expériences négatives de la petite enfance (traumatismes précoces, abus émotionnels ou physiques) -> peut engendrer un stress favorisant une conso excessive et pbatique des écrans - Facteurs psychopathologiques, de personnalité et cognitions sociales - Principales comorbidités : tblets dépressifs, anxieux, TDAH - Une faible estime de soi, une grande timidité, une tendance à procrastiner - Un soutien social peu élevé, des sentiments d'isolement et de solitude
Conséquences	- Addiction est une addiction car elle a des csq sur la vie des personnes - Des effets négatifs, notamment sur : - Les troubles de l'humeur, troubles anxieux : donc réciprocity !

	– Le sommeil et ses rythmes : perturbation du rythme circadien, décalage -> csq sur la qualité, diminution du temps de sommeil – Les capacités cognitives et académiques plus faibles : moins de capacités d'autorégulation et d'attention, scolarité
Outils de repérage et d'évaluation Comment diagnostiquer cette pbatique ?	2 modes principaux : • Subjectif, passant par des questionnaires ou un entretien – Prend en compte les aspects psychologiques • Objectif et automatique : collecte passive des données via les écrans (données d'utilisation dans le téléphone : appli, temps...) – Données plus précises mais on passe a coté de variables et facteurs psychologiques • Exemple de questionnaires : Smartphone Addiction Scale (SAS), validée sur un population d'adultes – Prend en compte plusieurs dimensions dont des dimensions psychologiques (pas que sur utilisation) ○ Perturbations de la vie quotidienne ○ Anticipation positive ○ Retrait ○ Cyber relations ○ Sur usage ○ Tolérance – Exemples d'items : ○ Utiliser un smartphone est la chose la plus amusante à faire ○ Je ne supporte pas le fait de sortir sans mon smartphone ○ Je ressens de l'impatience et de l'irritation lorsque je n'ai pas mon smartphone
Conseils et prise en charge Comment aider les personnes à mieux réguler leur utilisation ?	• L'abstinence ? Détox digitale = effet positif sur le temps d'utilisation du smartphone, mais des effets inconsistants sur la satisfaction de la vie, les affetcs et même les sp addictifs De plus, importants dans le quotidien, besoin, donc on ne peut pas demander d'arrêter complètement --> Régulation de l'utilisation plutôt • Régulation Conseils du gouvernement : nouveau plan d'actions 2022 pour un usage raisonné des écrans par les jeunes et les enfants Site internet (je protège mon enfant) donnant des conseils aux parents sur l'utilisation des écrans, sur comment installer et configurer les contrôles parentaux selon les utilisations = Conseils aux parents mais pas aux personnes concernées • Pour les personnes concernées : études – Ttt pharmacologiques ? Antidépresseurs ? Car on sait qu'il y a une comorbidité : réduction des sp mais peu de recherches actuellement – Ttt psychothérapeutiques ? TCC = la plus courante, effets positifs sur la santé des ados et des adultes, en cours d'études actuellement

La prévention du suicide

Les chiffres	• 9000 personnes meurent chaque année par suicide en France (2% des décès) → dont 400 jeunes de moins de 24 ans • Les hommes meurent 3 fois plus que les femmes par suicide mais les femmes réalisent plus de tentatives de suicide (200 000 tentatives de suicide en France chaque année) • Les tentatives de suicide sont nombreuses chez les jeunes avec parfois des séquelles graves
Facteurs de risques	• Le mal être, l'isolement • Des événements de vie difficiles (harcèlement ++, maltraitance, rejet, deuil, ruptures...) • Avoir déjà fait une tentative de suicide • La dépression Le suicide n'est pas un choix : c'est la dernière solution qui s'impose pour arrêter de souffrir.
	  Jeunes présentant une homosexualité : population particulièrement concernée par cette question du suicide → stigmatisation et rejet (4x plus de suicide que la moyenne)
La dépression	   8% des jeunes entre 12 et 18 ans souffriraient de dépression. ➔ Ce n'est pas un « coup de déprime »... ni une question de volonté ➔ C'est une vraie maladie qui peut être soignée Les signes : tristesse, perte d'intérêt, perte de plaisir, ralentissement, fatigue, irritabilité, dévalorisation, culpabilité, perte d'appétit, insomnie, plaintes physiques, idées suicidaires Les conséquences : repli, stress, absentéisme scolaire, conduites à risques, addictions, tentatives de suicide

La prévention du suicide : comment faire ?

Comment repérer ? → les signes d'alerte	Un ensemble de signes qui doivent nous y faire penser : • Signes dits « internalisés » : repli, isolement, tristesse, perte d'envie et de plaisir • Signes dits « externalisés » : comportements impulsifs (colères, violences, fugues), mise en danger (conduite, drogues, alcool, automutilations, anorexie) • Signes verbaux : des paroles évoquant le mal être doivent alerter : « j'en peux plus... », des envies de mourir, des idées suicidaires : « j'ai plus qu'à me foutre en l'air... » doivent toujours être prises au sérieux et faire réagir ! La majorité des personnes qui se suicide en avait parlé avant. Une demande d'aide... un appel au secours ! → c'est pas parce qu'ils n'en parlent qu'ils ne le feront pas, bien au contraire
Faire le premier pas	• Oser aller vers la personne qui souffre pour rompre son isolement • Se sentir légitime pour aider quelqu'un qui va mal • Ne pas attendre que quelqu'un d'autres réagisse même si on ne se sent pas à la hauteur • Ne pas cautionner le rejet ou le harcèlement d'un groupe • Il suffit d'un regard, d'un sourire, d'un petit mot, d'un texto pour amorcer cette aide • Trouver le bon moment pour faire ce premier pas et parfois le faire à deux (il ne faut pas faire ça n'importe comment, au milieu de la classe, mais plutôt trouver un endroit plus tranquille, dans la cours par exemple)
Lui parler	• Être attentif et bienveillant sans juger et sans vouloir trouver des solutions trop vite • Éviter de parler de soi ou de comparer (écoute ++) • Reconnaître qu'il puisse aller mal et lui dire que l'on voit qu'il est en difficulté • Respecter sa confiance mais en lui disant parfois qu'il est nécessaire d'en parler à un adulte (si il évoque des idées suicidaires) « ce que tu me dis est trop grave pour que je le garde pour moi... » • Oser lui demander si il a des idées suicidaires = lui permet d'évoquer son mal-être, d'évoquer sa souffrance
Vidéo	 « Seul », association « Stop Suicide » - diapo 13 → possibilité de montrer cette vidéo dans les collèges et lycées pour aborder la question du mal-être et de la démarche à suivre pour aider quelqu'un qui va mal <u>Questions qui peuvent leur être posées :</u> – Décrivez la scène ? Qu'est-ce qu'on voit dans cette vidéo ? – Comment se fait-il que le jeune soit à part ? – Qu'est-ce que les 2 jeunes filles qui regardent le garçon isolé se disent entre elles ? – Pourquoi elles ne se lèvent pas alors qu'elles semblaient repérer ce garçon tout seul au fond de la cours ? – Est-ce qu'elles auraient réagi de la même manière si elles avaient été seules ? – Concernant le garçon qui se lève pour aller parler au jeune isolé, que se passe-t-il dans sa tête ? Qu'est ce qu'il a ressenti ? Qu'est ce qui l'a motivé pour aller vers lui ? Qu'est ce qui aurait pu l'empêcher d'y aller ? Qu'est-ce qu'il aurait pu dire d'autre ? – Pourquoi quand on voit quelqu'un qui va mal, on fait la démarche d'aller le voir ou bien au contraire on ne l'a fait pas ? – Concernant le jeune qui porte la capuche : pourquoi ne va-t-il pas demander de l'aide au groupe ? Est-ce que vous vous êtes déjà retrouvé dans cette situation ? – Qu'est-ce que le jeune à la capuche ressent au moment où quelqu'un finit par venir vers lui ? Pourquoi il enlève sa capuche ? Pourquoi il accepte d'aller vers le groupe après ?

L'aider à se faire aider	• Le rassurer : « on ne peut pas toujours se débrouiller seul... » • Les adultes de confiance seront rassurés de le voir demander de l'aide • Parler de son problème, c'est pouvoir agir et tenter de trouver des solutions • L'aider à trouver un adulte en qui il a confiance et qui pourrait l'aider ➔ Un adulte de la famille ➔ Un adulte de l'établissement (prof, infirmière scolaire, CPE...), d'un club (entraîneur, animateur...) ➔ Le parent d'un ami ➔ Un professionnel • Ne pas lâcher, ne pas penser que tout est réglé, rester au contact : pouvoir l'accompagner ou l'aider à appeler, prendre des nouvelles, s'assurer qu'il a pu en parler
Coordonnées ressources	• Dans l'établissement scolaire Nom de l'infirmière scolaire, médecin scolaire, assistante social... • Médecin généraliste • Maison des adolescents https://www.ado38.fr/Grenoble.html GRENOBLE, 74 rue des Allies ☎ 04 56 58 82 00 VIENNE, 4 rue Emile Romanet ☎ 04 74 53 89 21 BOURGOIN JAILLIEU, 18 rue Joseph Cugnot ☎ 04 37 03 43 74 • Allo écoute Ados : 0 800 506 692 Appel gratuit depuis un poste fixe • Fil santé jeune : 0 800 235 236 • Urgence : possibilité de se rendre aux urgences à toutes heures en cas de danger pour rencontrer un professionnel de santé • SAMU centre 15 : si les idées suicidaires sont trop envahissantes et si le risque de passage à l'acte est imminent
Pour en savoir plus	https://www.unps.fr  http://www.alloecouteado.org  https://www.filsantejeunes.com  https://stopsuicide.ch   Application gratuite « Stop Blues » : vidéos qui évoquent la question du mal-être et comment être aidé
Vidéo	 https://www.youtube.com/LePsyLab - diapo 18

Le harcèlement scolaire

Ampleur du phénomène	Enquête victimation 2011, 2013-2015 DEPP : ➔ 1 enfant sur 10 est victime de harcèlement scolaire en France soit environ 1 million d'élèves • 12% en primaire • 10% au collège • 3 à 4% au lycée Enquête PISA 2015 dans les pays de l'OCDE : ➔ Toutes les cultures et tous les milieux sont touchés ➔ Les garçons sont plus souvent frappés et bousculés ➔ Les filles sont davantage exposées aux mauvaises rumeurs
Définition du harcèlement scolaire	Il s'agit de violences entre élèves du même âge ou de la même tranche d'âge. Se déroulant : - au sein de l'établissement scolaire (cour de récréation, couloirs, toilettes, vestiaire, cantine...) - et/ou sur les trajets entre le domicile et l'établissement scolaire - et jusqu'au sein du domicile de l'élève pour le cyber harcèlement La victime peut être harcelée par un agresseur ou un groupe d'agresseurs.
Exemple d'harcèlement scolaire	• Agressions physiques : claques, bousculades, coups de pieds, coups de poing • Agressions verbales : insultes, railleries, sobriquets, menaces • Agression à caractère sexuel : gestes obscènes, humiliations • Atteintes matérielles : vols, dégradation d'objets personnels • Atteintes relationnelles : mise à l'écart, rumeur La plupart du temps, le harcèlement est polymorphe.
Vidéos	 Les claques : https://www.youtube.com/watch?v=Rr4XEDK72iY  Les rumeurs : https://www.dailymotion.com/video/xof07h
Le cyber harcèlement	Variante du harcèlement reposant sur l'usage d'internet et des nouvelles technologies de communications (blogs, téléphones portables, courriers électroniques, forums, chats, jeux en ligne, réseaux sociaux, site de partage de photographies) ➔ Est favorisé par l'anonymat et l'absence de contrôle d'identité qui permettent aux harceleurs d'agir en toute discrétion. Prend différentes formes : • Intimidations, moqueries, menaces, insultes, chantage • Création d'une page sur un réseau social à l'encontre de la victime, propagation de rumeurs • Publication de photos ou de vidéos humiliantes, photo montages
Caractéristiques du harcèlement scolaire	Les critères constitutifs sont : - L'intentionnalité de nuire, de porter préjudice - La répétition des actes - La longue durée des actes - La dissymétrie des forces avec mise en place d'une relation dominé-dominant La dimension de répétition et d'emprise sont fondamentales : - Elles permettent de différencier le harcèlement des bagarres ou conflits - Elles expliquent la gravité des conséquences sur la victime

Fondement du harcèlement scolaire	Le harcèlement se fonde sur la perception d'une différence et la stigmatisation de certaines caractéristiques : - Apparence physique - Orientation sexuelle - Handicap physique, psychique ou intellectuel - Trouble de la parole comme le bégaiement - Appartenance à un groupe social, ethnique, culturel, religieux particulier - Mais aussi qualités « extrêmes » : meilleur de la classe, riche, très bien habillé
Les protagonistes di harcèlement scolaire	Quatre profils de protagonistes sont classiquement décrits : - les victimes qui subissent le harcèlement mais ne le pratiquent pas - Les agresseurs qui agressent sans subir eux-mêmes le harcèlement - Les agresseurs/victimes qui subissent du harcèlement par des élèves et le pratiquent à l'égard d'autres élèves - Les « neutres » qui sont des élèves non concernés ou qui ont les stratégies pour échapper au harcèlement
Psychologie des protagonistes du harcèlement scolaire	Les victimes : • L'emprise psychique exercée par le ou les harceleurs peut amener la victime à croire qu'elle mérite une telle situation • Possible endossement de la responsabilité qui conduit à la honte ou à la culpabilité qui empêchent de parler • Aggravation de l'isolement relationnel Les harceleurs : • La différence perçue chez la victime renvoie le harceleur à ses propres faiblesses qui sont évacuées sur un bouc émissaire • Ont peu de capacités d'empathie • Ont souvent des troubles psychiatriques dits externalisés (hyperactivité, impulsivité, troubles des conduites) Les « neutres » ou témoins ont peu tendance à intervenir car : • Peur des représailles • Sentiment que ce n'est pas leur affaire • On ne cafte pas • La victime devait se défendre seule...
Rôle primordial des témoins	Lorsqu'ils restent passifs, optant pour la loi du silence, les témoins : - Valident le procédé du harceleur qui se sent conforté - Privent la victime de soutien et d'empathie - Renforcent l'ostracisme et l'isolement de la victime Pour que les témoins puissent sortir de leur silence, il faut : - Qu'ils connaissent ce type d'agression qu'est le harcèlement - Qu'ils soient sûr de trouver des relais auprès des adultes de l'établissement scolaire ou de leur entourage
Facteur favorisant le harcèlement scolaire	• Fragilité psychique, environnementale et familiale tant de la victime que de l'agresseur • Climat scolaire de l'établissement dégradé • Insuffisance de repérage ou de prise en compte par l'équipe éducative • Témoins n'osant pas intervenir ou révéler les faits • Victimes n'osant pas se confier à leurs parents ou amis

Troubles psychiatriques pouvant apparaître	Troubles anxieux : - peurs, terreur - Troubles du sommeil, somatisations - Pensées obsédantes, ruminations, fléchissement des résultats scolaires - Peuvent conduire à un absentéisme scolaire voire une déscolarisation complète Troubles récents du comportements : colères, fugues, agressivité, conduites à risques État dépressif : tristesse, pleurs, irritabilité, asthénie, troubles de la mémoire, troubles de la concentration, culpabilité, dévalorisation, honte, sentiment d'impuissance, isolement relationnel, idées suicidaires, suicide État de stress post-traumatique : ruminations anxieuses, flash back, cauchemars, évitement, hyper réactivité neurovégétative, émotions négatives ⇒ Suicide
La lutte contre le harcèlement scolaire	• En faire une priorité en raison de sa fréquence et de son retentissement psychique • Connaître pour repérer et réagir : depuis 2015, il existe une journée nationale consacrée dans les écoles au harcèlement • Un bon climat scolaire est un facteur de protection du harcèlement scolaire • Notion d'élèves « ambassadeurs » développée par le ministre de l'Éducation Nationale le 5 mars 2018. Fait référence au rôle essentiel des témoins qui ne doivent pas garder le silence. • Formation des chefs d'établissement scolaire, psychologue et infirmière scolaires afin qu'ils apparaissent comme des « référents permanents » pour les élèves « ambassadeurs » et les victimes • Soutien et aide à la victime • Lutter contre l'isolement relationnel de la victime en allant vers elle et en lui parlant : rôle essentiel des témoins • Sortir de la loi du silence : tant les témoins que la victime devraient pouvoir se confier aux adultes référents • S'il n'est pas possible de parler avec un adulte, des numéros verts peuvent être utilisés : ➤ Pour le harcèlement : 3020, service et appel gratuit ➤ Pour le cyber harcèlement : 0800 200 200, service et appel gratuit • La victime peut trouver de l'aide auprès de l'association du réseau France Victimes : ☎ 01 41 83 42 08 • Tant la victime que l'agresseur peut être orienté vers des prises en charge spécifiques : - Développement de la confiance en soi et des habiletés relationnelles chez la victime - Développement des capacités d'empathie chez l'agresseur
Les numéros de téléphones utiles	   

Le harcèlement scolaire est un délit	➔ Le cyber harcèlement est une circonstance aggravante du délit de harcèlement ➔ Si la victime est âgée de moins de 15 ans, l’auteur (s’il est âgé de plus de 13 ans) encourt une peine de prison de 18 mois et de 7500 euros d’amende. ➔ Les parents de l’auteur sont civilement responsables et devront, le cas échéant, indemniser les parents de la victime
Bibliographie 	• Enquête PISA, 2015 • Site National « Non au harcèlement », Ministère de l’éducation Nationale • Vidéo : Les claques - Agir contre le harcèlement sexuel • Vidéo : Les rumeurs - Agir contre le harcèlement sexuel

Le sommeil et son hygiène

Le sommeil normal

Caractéristiques	Dure en moyenne 7 à 8 heures → mais variation en fonction de l'âge, du sexe, de l'individu lui-même (court/long dormeur)	
	- Un cycle de sommeil est composé de 2 phases différentes et alternantes : Le sommeil lent (de léger à profond) Le sommeil paradoxal - Chaque cycle dure environ 90 minutes, se répète 4 à 7 fois par nuit et débute par une phase de sommeil lent	
Le sommeil lent	- Le sommeil lent est prédominant en <u>début</u> de nuit - Il occupe la majeure partie d'un cycle et de ce fait la majeure partie du sommeil normal pour réduire son temps en fin de nuit - Il est également appelé sommeil réparateur	
Le sommeil paradoxal	- Il s'agit d'un état proche de l'état de veille se caractérisant par des mouvements oculaires rapides et d'un relâchement musculaire - Le temps de sommeil paradoxal augmente à mesure que celui du sommeil lent se réduit - Enfin, il est surtout connu pour être le siège des rêves	

L'hygiène du sommeil

La chambre à coucher		Afin de passer une bonne nuit, il est préférable de dormir dans une chambre : - Aérée - En limitant les bruits et la lumière - En veillant que la température ne soit pas excessive
L'heure de se coucher		➔ Doit être régulière ➔ En évitant les siestes longues ou tardives
L'exposition à la lumière		Est à favoriser la matin et à réduire le soir → permet d'instaurer un bon rythme chronobiologique
L'activité physique		À favoriser pendant la journée et à limiter en fin d'après-midi et le soir
L'alimentation		➔ Éviter les repas trop copieux et particulièrement gras le soir ➔ Limiter les produits excitants comme le café et le tabac

Les signes d'alertes

Des difficultés d'endormissement persistantes sur plusieurs jours ou semaines, des réveils nocturnes fréquents pendant plusieurs nuits :

- ➔ **Peuvent être des signes traduisant de l'anxiété, une dépression...**
- ➔ **Doivent motiver une consultation chez le médecin traitant**
- ➔ **Ne doivent aucunement justifier une automédication par des traitements favorisant le sommeil**

CQFR	- Un sommeil de qualité favorise la récupération et la mémoire - Il existe des règles d'hygiène permettant un sommeil de qualité - Des troubles du sommeil persistant depuis quelques jours doivent justifier une consultation médicale
-------------	---

Obésité : épidémiologie, risques associés, stigmatisation

Définition et prévalence

L'obésité est une **maladie** car elle affecte le bien-être **physique, psychique et social** d'un individu.

Prévalence en France : Etude ESTEBAN 2014-2016

Corpulence chez les adultes de 18 à 74 ans en 2015 **54 % des hommes** et **44 % des femmes** sont en **surpoids** ou **obèses** (IMC ≥ 25).

Prévalence de l'obésité (IMC ≥ 30) = **17 % hommes et femmes**.

Entre ENNS-2006 et Esteban-2015 la prévalence du **surpoids** et de **l'obésité** est **stable**.

La **prévalence** $\nearrow$ avec l'âge et reste supérieure chez les personnes les **moins diplômées**.

Indice de masse corporel = poids/taille² (kg/m²). On ne parle plus d'obésité "sévère", "morbide" ou "simple" car ces mots ont une connotation qui peut être contre-productive chez le patient.

Table 1. World Health Organization Classification of Obesity

Classification	BMI, kg/m ²
Underweight	<18.5
Normal weight	18.5–24.9
Overweight	25–29.9
Obese	
Class I	30–34.9
Class II	35–39.9
Class III	≥ 40

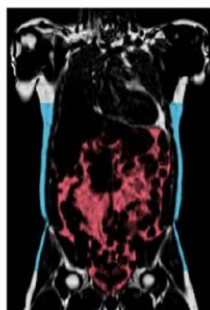
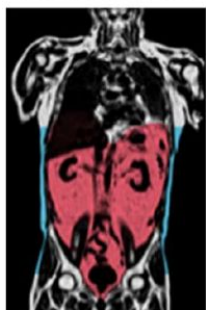
IMC et mortalité

L'obésité est associée à un risque de sur-mortalité. Il existe une relation en "J" entre l'IMC et la sur-mortalité. On a une surmortalité en état de maigreur et d'obésité, avec un IMC optimal autour de 22 à 25. Il faut noter que le risque de surmortalité reste relativement faible par rapport, par exemple, au sur risque de mortalité lié à la consommation de tabac.

Les limites de l'indice de masse corporelle

67 year old male
BMI 25 kg/m²
Visceral fat 2.58 L/m²

53 year old male
BMI 30 kg/m²
Visceral fat 0.88 L/m²



L'IMC ne donne aucune indication sur la **composition corporelle**.

Si on regarde ces 2 hommes il est difficile de dire qui a le risque cardiométabolique le plus élevé. C'est celui de gauche, qui a un IMC plus bas mais une quantité de graisse viscérale plus élevée.

Répartition des graisses et risque cardiométabolique

Répartition périphérique ou sous-cutanée : l'excès calorique induit une augmentation du tissu adipeux sous cutané principalement au niveau des fesses et des cuisses. Dans les autres zones du corps (joues, bras..) on a peu de graisse.

Obésité « **métaboliquement saine** » = **51,8% ♀** en obésité **25,3 % ♂** en obésité

La quantité de graisse sous-cutanée du bas du corps est **inversement** corrélée :

- Aux FRCV (DT2, HTA, dyslipidémie)
- Aux événements cardiovasculaires
- Cancers ? (selon les études)

! Plus on a de graisses sous cutanée (surtout dans le bas du corps) moins on a de risque de développer des maladies métaboliques.

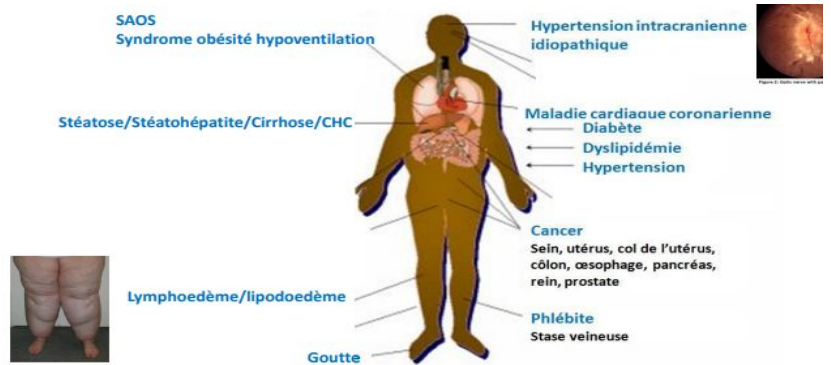
Répartition centrale ou viscérale : plutôt chez les hommes. On a une accumulation de graisse autour du tube digestif et du cœur.

La quantité de graisse viscérale est **corrélée** à l'incidence :

- Des maladies métaboliques (DT2, HTA, dyslipidémie, NASH, SOPK, SAOS)
- Aux événements cardiovasculaires
- Aux risques de cancer (côlon, sein, endomètre)

Quelles peuvent être les complications de l'obésité ?

Elles sont donc principalement associées à une **répartition centrales** des graisses, au niveau du tissu adipeux viscéral, parce qu'il génère dans un 2ème temps une **mobilisation des graisses vers les différents organes**.



Quel message doit-on porter en tant que soignant ?

Ces messages ont déjà atteint 95% de la population. Il s'agit donc de la manière d'apporter ce message.

A promouvoir :

- Une activité physique régulière
- Une alimentation basée sur le plaisir alimentaire, la convivialité, l'attention portée à ce que l'on fait lorsque l'on mange
- Faire émerger les propres projets de chaque personne

A éviter :

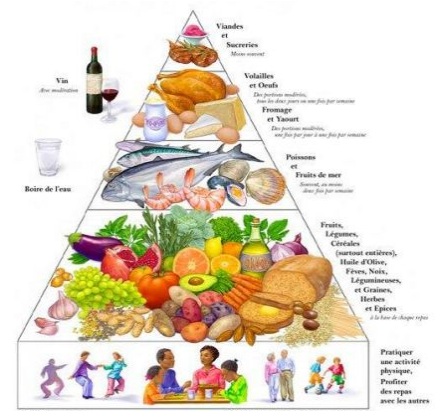
- Les conseils nutritionnels ou d'activité physique directifs
- La culpabilisation
- Les conseils favorisant une restriction cognitive (aliments interdits, pas d'alimentation entre les repas, petit déjeuner obligatoire...ces obligations n'ont pas de raisons scientifiques)

Comportements et changement de poids à long terme

Les messages prônant l'activité physique et une alimentation variée sont soutenus par des faits scientifiques. Études qui suivent des populations sur 4 ans : on regarde l'évolution de leur poids en fonction des aliments consommés. Certains aliments sont associés à une prise de poids (chips, jus de fruits, beurre), d'autres sont associés à une perte de poids (légumes, yaourt, noix).

Une augmentation de l'activité physique associée à un changement des comportements alimentaires sur 4 ans favorise la perte de poids (effet cumulé).

Pyramide des régimes méditerranéens → régime le plus favorable pour la prévention des risques cardiovasculaires. Pas de restriction mais plutôt des priorisations. Les protéines sont plus favorables si elles sont apportées par les poissons, viandes blanches et produits laitiers. La consommation d'un verre de vin par jour fait encore débat (diminue le risque cardiovasculaire mais augmente le risque de cancer digestif..?).



Comprendre pourquoi l'obésité est une maladie complexe pour éviter les discours simplistes et culpabilisants

Au-delà des observations et conseils généraux, il y a la maladie de l'obésité qui atteint un individu en particulier en résonance avec un **contexte physiopathologique** particulier et une histoire de vie.

Chez 60% des femmes et 30% des hommes obèses on retrouve des événements traumatiques qui ont eu pour conséquences un report émotionnel sur la nourriture. Les discours simplistes et culpabilisants sont à bannir !

Qualification du comportement alimentaire

• TCA prandiaux :

- Hyperphagie prandiale : prise alimentaire au repas dépassant la satiété (patient coupé de ses sensations alimentaires, convivialité, éducation (on est obligé de finir son assiette)...))
- Tachyphagie : manger trop rapidement en mastiquant peu (rend la perception de la satiété difficile)
- Restriction cognitive : tendance à limiter consciemment la prise alimentaire pour perdre du poids ou éviter d'en prendre

• TCA extra-prandiaux :

- Grignotages : consommation répétitive, sans faim, sans envie, de petites quantités d'aliments facilement accessibles
- Compulsions : consommation soudaine, rapide et en grande quantité d'un aliment donné sans lien avec la faim, s'orientant vers un aliment apprécié. Plaisir initial puis éventuellement culpabilité.
- Noctophagie (manger la nuit)

• **Désinhibition** : prises alimentaires incontrôlées dans un contexte de restriction et de privation chroniques

• **Impulsivité alimentaire primaire** : prises alimentaires incontrôlées dans un contexte variable, mais souvent émotionnel (positif ou négatif)

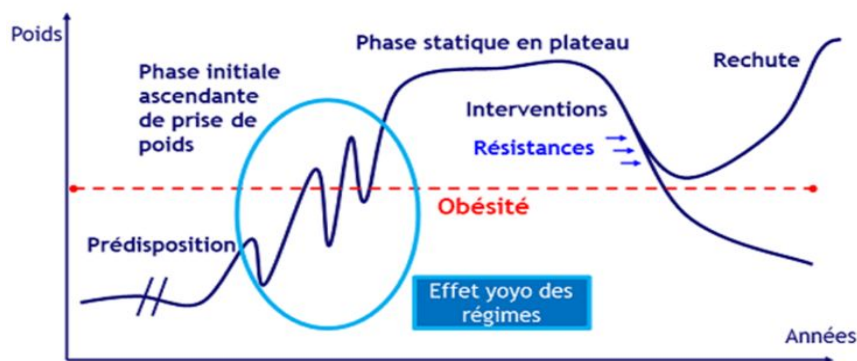
Troubles du comportement alimentaire plus sévères

• Crise boulimique :

- consommation d'une grande quantité de nourriture à l'intérieur d'une courte période temps (<2 h)
- sentiment de perte de contrôle pendant la crise
- Sans plaisir alimentaire

• **La boulimie** (bulimia nervosa) : 1 crises boulimiques par semaine pendant 3 mois + conduites compensatoires (vomissements, prise de comprimés pour maigrir, purges)

• **L'hyperphagie boulimique** (ou binge eating disorder) : 1 crise boulimique par semaine pendant 3 mois sans conduites compensatoires = le plus fréquent des TCA répertoriés chez l'obèse (mais non présente chez la majorité des personnes obèses)



Les régimes restrictifs sont délétères sur le poids, ils peuvent aboutir à un effet yoyo. En effet la **restrictions calorique** n'est pas possible à long terme, elle n'est **pas physiologique**, le corps est fait pour ingérer autant de calorie qu'il en dépense. De plus le patient va finir par compenser la frustration du régime et prendre du poids.

Facteur aggravant de la stigmatisation

• A partir de 1950 « l'embonpoint » devient le « mal en point »

• Préjugés culturels :

- Religieux : « péché de gourmandise »
- Moral : « prend plus que sa part »
- Médical : « met sa santé en danger »
- Santé publique : « lutter contre l'obésité = priorité » donne une importance majeure à ce facteur de risque alors qu'il n'a pas un coût de société et de santé très élevé par rapport à d'autres (tabac).

• **Imprégnation inconsciente** qui peut cohabiter avec la bienveillance

• **Discrimination** = d'inconscient à conscient

Culpabilité/honte → disqualification → dévalorisation intériorisée → éloignement des facultés d'adaptation (le patient perd confiance dans sa capacité à savoir manger).

Grossophobie médicale

• Daria, 37 ans, se rend chez le médecin pour un début d'angine. Elle a la gorge enflée et a besoin d'une ordonnance. Dans l'urgence, elle prend rendez-vous chez le médecin la plus proche. "A peine quelques secondes après mon arrivée, elle me dit que je vais mourir si je continue comme ça, qu'il n'y a pas de solution et que je dois mettre un by-pass. Je ne la connaissais ni d'Eve ni d'Adam ! J'ai dû insister pour qu'elle me prescrive quelque chose pour mon angine. Je ne dis pas que le poids ne peut pas être une cause de maux, je dis juste que, parfois, on a aussi les douleurs de monsieur et madame Tout-le-Monde."

• "Quand on arrive dans un cabinet, les médecins ne voient que notre corps, se focalisent dessus et parfois le rejettent", confirme Claudia. La présidente d'Allegro Fortissimo, association de soutien aux personnes grosses, rappelle cette fois où elle devait faire une échographie pelvienne et où le radiologue lui a demandé de s'introduire la sonde elle-même parce qu'il ne voulait pas "s'immiscer dans les couches de graisse". "J'étais tellement choquée et déstabilisée que je n'ai pas su répondre."

• Aujourd'hui, Olga a 28 ans et pèse 115 kilos. Elle a mis plus de vingt ans à trouver un médecin "bienveillant", qui la soigne comme n'importe quel autre patient. "Ce n'est pas qu'il banalise mon poids, mais il n'analyse pas tout via mes kilos", raconte-t-elle.

- « Les médecins sont beaucoup plus paternalistes avec les femmes, un homme gros est un bon mangeur, une femme grosse a forcément fait les mauvais choix et n'a aucune volonté. »

Site internet qui regroupe les témoignages de personnes obèses : <https://graspolitique.wordpress.com/liste-non-safe/>

Nom de soignants qui ont eu des propos déplacés.

Conseils avant de porter des messages de prévention de l'obésité

- Faire votre propre analyse des projections que vous pourriez avoir sur les personnes obèses
- Se questionner sur son propre rapport à l'alimentation : spontané, intuitif ? Restriction cognitive ? Préoccupation importante autour du poids ? Troubles du comportement alimentaire ?
- Promouvoir une alimentation équilibrée, non restrictive, et de l'activité physique
- Sans culpabilisation ou emphase démesurée sur les risques associés à l'obésité car cela induit un risque d'aggravation de la stigmatisation des personnes obèses

Troubles du Comportement Alimentaire

TCA définition

Pathologie psychiatrique qui ont des conséquences somatiques importante. Se définit par ses conséquences

biologiques:

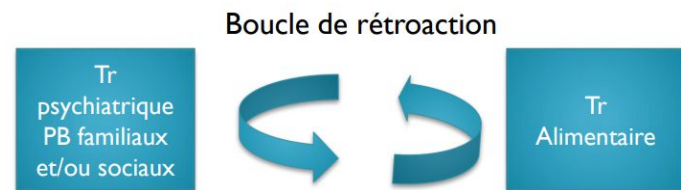
Anorexie mentale = $IMC < 17.5$ (dénutrition)

Boulimie nerveuse = $18,5 < IMC < 24$

Accès hyperphagique $IMC > 25$

Le plus souvent associé:

- À des troubles psychologiques/psychiatriques
- À des problèmes relationnels familiaux et/ou sociaux importants



Les principaux TCA

Anorexie Mentale // Boulimie Nerveuse // Trouble Accès Hyperphagique

Epidémiologie

Prévalence ensembles des TCA: **2.5%** de la population générale

Prévalence des formes graves d'AM : grave car risque somatique de dénutrition → **1%** des Ado (30000 en France) et semble en **augmentation**

Prévalence Anorexie: 0,9 à 1,5 % chez les femmes

1.5% des femmes entre 15 et 35 ans

0,2 à 0,3 % chez les hommes en population générale

Sex ratio 1:9 touche ++ les femmes

Prévalence Boulimie:

- Prévalence vie entière autour de **1-1.5%** (3- 4 % des femmes, entre 15-45 ans)
- **Formes partielles: x 2 à 3**
- Sex-ratio est de 1:3. Les hommes sont probablement sous évalués

Prévalence Accès Hyperphagiques

- Prévalence : **3 %** femme; **2,5 à 3%** homme (Hudson, 2007)
 - 2 à 3 fois plus fréquent que la boulimie
- Très méconnu mais pourtant trouble le plus fréquent !

Etiopathogénie des TCA : « Polyfactorielle » :

- Facteurs de **vulnérabilité**: « terrain » génétique et/ou anomalies biologiques préexistantes
- Facteurs **déclenchants**: régimes alimentaires stricts, événements de vie majeurs (maltraitance), puberté et œstrogènes
- Facteurs **d'entretien**: déséquilibres biologiques induits par la dénutrition mécanismes de défense
 - Se jeter sur la nourriture (perte de contrôle)
 - Se figer dans les restrictions

Théorie de l'influence socioculturelle

Contrairement à la schizophrénie par exemple les TCA sont plus présents dans la **société occidentale**. Il existe une différence entre les milieux : plus présent dans les sociétés où on a excès à l'idéal du corps mince.

Promouvoir une distorsion de l'image du corps et de la bonne alimentation.

Modeling: Imiter les comportements que l'on observe.

Renforcement Social: Internalisation des attitudes et des comportements approuvés par autrui.

Niveaux de l'influence sociale : Les Médias / La Famille / Les Pairs (milieux sportifs par exemple). Plus l'idéal de minceur s'éloigne de notre corps physiologique plus on va avoir de risque de développer des TCA.



CONSEQUENCES CHEZ LES ADOLESCENTS

Internalisation des idéaux culturels de beauté et de minceur

Vulnérabilité interpersonnelle ⇒ trouble de l'image de soi et du fonctionnement social ⇒ sentiment d'inefficacité et insatisfaction corporelle

Écart entre la forme corporelle actuelle et l'idéal de minceur ⇒ restriction alimentaires et ses conséquences

Adolescence et Image du Corps

A 8 ans: 23% des filles souhaitent être minces (Shapiro et al., 1997).

Entre 8 et 10 ans: **55% des filles sont insatisfaites** de leur poids et 46% veulent maigrir versus **3%** pour le garçon

46% des filles se trouvent **trop grosses** alors que 12% ont un surpoids.

→ augmentation de l'insatisfaction corporelle avec l'âge. ◦ 45% à l'âge de 11 ans ◦ 54% à l'âge de 13 ans (<10% des garçons).

1 - Anorexie Mentale

Le TCA le plus rare mais le plus connu car il peut être très dangereux.

Anorexie : une lutte contre la faim

- Restriction alimentaire volontaire (ces personnes ont faim)
- Sélection des aliments qualitative et / ou quantitative (considèrent que certains aliments sont inutiles ou trop caloriques)

Amaigrissement :

- Perte de plus de 25% du poids initial (aussi notion de rapidité)
- IMC < 17,5
- Dénier de la maigreur (peuvent se trouver trop grosse)

Aménorrhée : Primaire si anorexie avant la puberté ou secondaire. Elle marque la dénutrition, montre l'impact sur le corps (mais ce n'est pas un critère diagnostic).

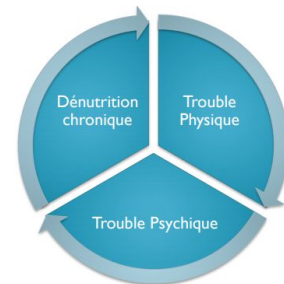
Restriction alimentaire

Restrictions Quantitatives : diminution des portions, saut de repas, dissimulation ou stockage de nourriture

Restrictions Qualitatives : Sélectivité = exclusion d'une catégorie d'aliment (féculent, lipide) / Végétarisme / Préférence pour des produits allégés. Autres stratégies :

- Vomissements
- Coupes faim, Diurétiques

Cercle vicieux de la pathologie anorexique : au départ souvent troubles psychologiques avec insatisfactions corporelle qui aboutissent à un contrôle alimentaire donc une dénutrition, qui donne des troubles psychologiques (irritabilité, syndrome dépressif..)



Conséquences

Pensées obsédantes:

- Sur l'alimentation: Menus, Recettes, etc.
- Sur le poids et la silhouette

Isolement social progressif : Irritabilité / Effondrement estime de soi / Altération de la vie familiale / sociale / scolaire / professionnelle

2 - Boulimie Nerveuse

Crise de Boulimie

Stratégie de contrôle du poids donc **Poids normal**

En commun avec l'anorexie mentale:

- Idéal de minceur, insatisfaction corporelle, dysmorphophobie
- Faible estime de soi
- Restriction alimentaire plus ou moins sévère
- Avec ou non conduite de purge (vomissement post crise de boulimie)

La crise de boulimie = Episode de surconsommation alimentaire, **brutal, impulsif et incontrôlable**, > repas copieux, de 1500 à 4000 cal, en général en cachette, en un temps limité (<2H). **Notion de plaisir absente** mais plutôt question de remplissage (aliments parfois non cuisinés, froids..).

Suspend ou occulte les pensées et affects pénibles, effet« dissociatif ».

3 - Trouble Accès hyperphagique

Crises de Boulimie

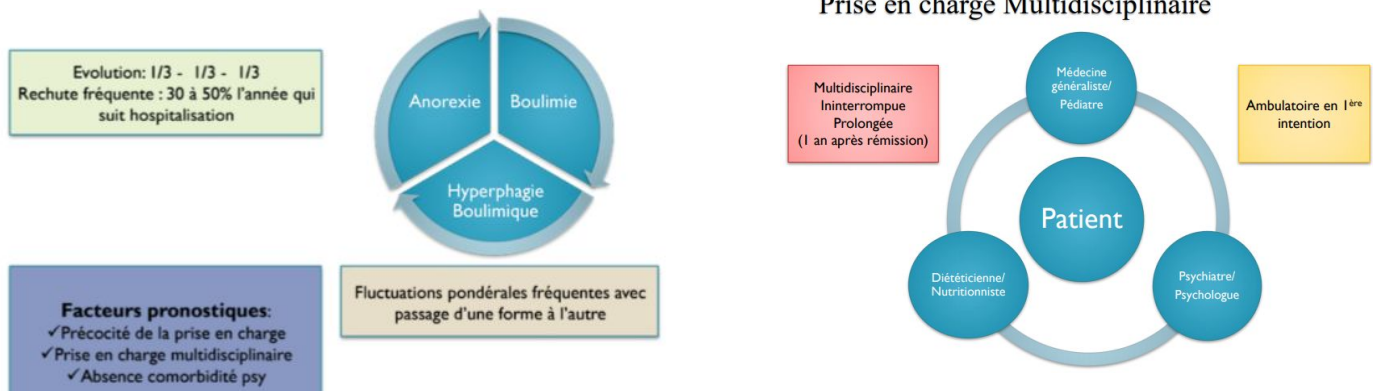
Pas de Stratégie de contrôle du poids donc **Surpoids voir Obésité**

En commun avec anorexie mentale et boulimie nerveuse :

- Idéal de minceur, insatisfaction corporelle, dysmorphophobie
- Faible estime de soi, culpabilité
- Restriction cognitive, aliments tabous

25 à 50% des sujets obèses qui se présente en traitement ont des accès boulimiques. (Spitzer et al. , 1992). Les sujets obèses avec accès boulimiques:

- se disent plus préoccupés par la nourriture
- se sentent moins aptes à contrôler leur alimentation
- sont plus insatisfaits de leur poids et de leur apparence physique. Certains ne voient pas leur obésité. Ils sont plus sujets aux troubles anxieux ou dépressifs (problème car les traitements pharmacologiques ont comme EI la prise de poids).



Prévention 1

Approche socio-culturelle : le corps idéal → Lutte contre les **représentations idéalisées du corps** (ex : mannequins et top modèles, mais aussi des sportifs comme ceux qui font de l'escalade)

Education à la santé → Développer les compétences psychosociales (**estime de soi**).

Prévention 2 - Dépistage

Repérage précoce prise en charge précoce : par les proches, par les professionnels (médecin traitant, médecine scolaire)

Populations à risque ◦ adolescentes, jeunes femmes, mannequins, danseurs, etc.

Signes d'appel : modifications alimentaires, amaigrissement et plaintes corporelles

Conclusion

Des pathologies qui inquiètent car **intrications médico psychiatriques**

Importance de la **précocité de la prise en charge**: identification des groupes à risque

Nécessité d'une prise en charge pluriprofessionnelle tant en ambulatoire qu'en hospitalisation

ACTIVITÉ PHYSIQUE

DÉFINITIONS

Activité physique

« Tout mouvement corporel produit par la contraction des muscles squelettiques entraînant une **augmentation de la dépense énergétique** au-dessus du métabolisme de repos » (Caspersen et al., 1985)

Activité professionnelle, loisirs, EPS, vie courante...

L'entraînement physique

« Forme d'AP, planifiée, structurée, répétitive, dont le but est d'améliorer ou de maintenir les **capacités physiques** d'un individu. » (Fox, Biddle & Boutcher, 2000)

Sport

« AP qui implique des situations de compétition gouvernées par des **règles**, généralement dans un **cadre structuré**. » (Fox, Biddle & Boutcher, 2000)

La condition physique

Ensemble d'attributs (endurance, force, équilibre...) acquis ou atteignables qui sont en relation avec la **capacité de la personne à réaliser une activité physique**.

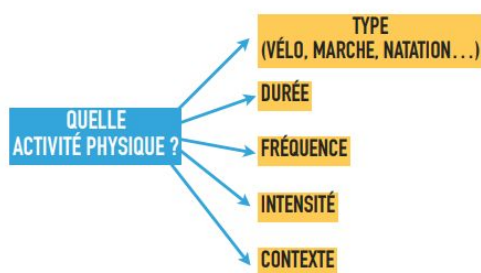
La sédentarité

Niveau insuffisant d'activité physique (en particulier durant le temps libre) < **au seuil préconisé d'Activités physiques bénéfiques pour la santé**.

L'inactivité physique

Participation à des activités spécifiques dont la dépense énergétique est proche de la **dépense de repos**.

EN QUOI L'ACTIVITÉ PHYSIQUE EST-ELLE UN COMPORTEMENT DE SANTÉ ATYPIQUE ?



Activité physique	Autres comportement bénéfique pour la santé
Comportement d'adoption	Comportement de sevrage (tabac, drogues, alcool)
Décision qui doit être maintenue tout au long de la vie	Décision ponctuelle : « j'arrête »
Temps d'engagement plutôt long (durée d'AP)	Temps d'engagement plutôt court (ex : lavage de dents)
Comportement qui provoque des réactions affectives variables (fatigue, douleurs...)	Réactions affectives plutôt positives (bénéfices de l'arrêt du comportement nocif)

CHEZ L'ADULTE (OMS 2010)

- Les adultes âgés de 18 à 64 ans devraient pratiquer au moins, au cours de la semaine, **150 minutes d'activité d'endurance** d'intensité modérée ou au moins **75 minutes d'activité d'endurance d'intensité soutenue**, ou une combinaison équivalente d'activité d'intensité modérée et soutenue
- L'activité devrait être pratiquée par périodes d'au moins 10 min.
- Pour pouvoir en retirer des bénéfices supplémentaires sur le plan de la santé, les adultes devraient augmenter la durée de leur activité d'endurance d'intensité modérée de façon à atteindre **300 minutes par semaine** ou pratiquer 150 minutes par semaine d'activité d'endurance d'intensité soutenue, ou une combinaison équivalente d'activité d'intensité modérée et soutenue.
- Des exercices de **renforcement musculaire** faisant intervenir les principaux groupes musculaires devraient être pratiqués au moins **deux jours par semaine** par périodes d'au moins 10 min.

CHEZ L'ENFANT

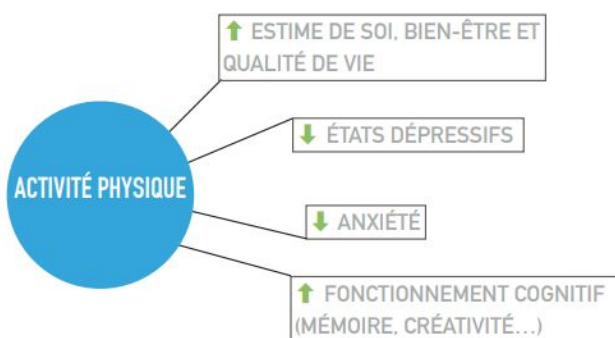
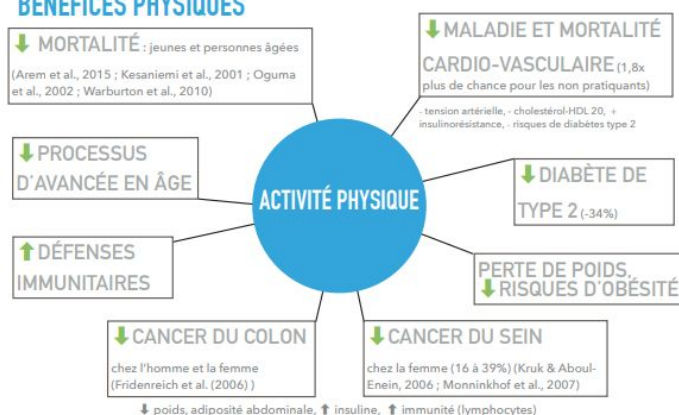
- ▶ Les enfants et jeunes gens âgés de 5 à 17 ans devraient accumuler au moins **60 minutes par jour d'activité physique d'intensité modérée à soutenue**.
- ▶ Le fait de pratiquer une activité physique pendant plus de 60 minutes apporte un bénéfice supplémentaire pour la santé.
- ▶ L'activité physique **quotidienne** devrait être essentiellement une **activité d'endurance**. Des activités d'intensité soutenue, notamment celles qui renforcent le système musculaire et l'état osseux, devraient être incorporées au moins trois fois par semaine.

CHEZ L'ENFANT, EN D'AUTRES TERMES

- ▶ Une dose minimale de **300 minutes hebdomadaires** (60 min x 5j) de marche à pied rapide pour les enfants en âge d'être scolarisés.
- ▶ éviter les plages horaires de **sédentarité supérieures à 2h**
- ▶ En nombre de pas : entre 10.000 et 12000 pas pour un adolescent (Guinouiha 2010)

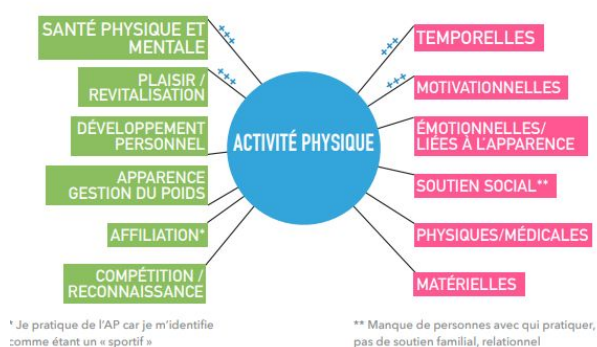
L'AP RÉGULIÈRE EST UN MOYEN DE PRÉVENTION PRIMAIRE ET SECONDAIRE EFFICACE POUR PLUS DE 25 CONDITIONS MÉDICALES CHRONIQUES ET LA MORTALITÉ PRÉMATURÉE.

BÉNÉFICES PHYSIQUES

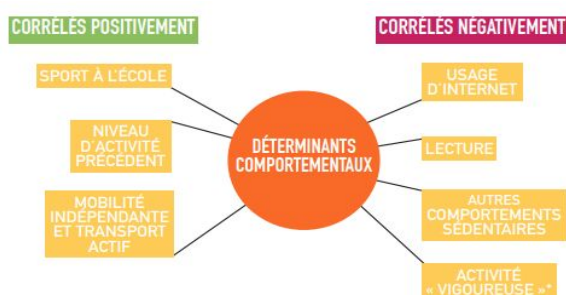
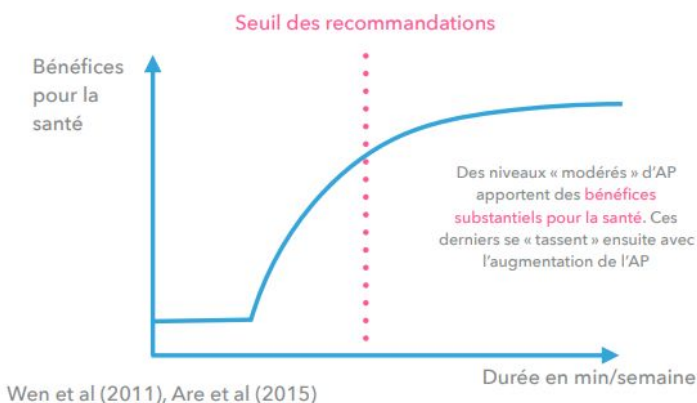


Aussi bénéfices psychologiques

SOURCES DE MOTIVATION VS OBSTACLES À LA PRATIQUE



RELATION EFFET-DOSE



* Plus l'activité pratiquée est vigoureuse, plus la quantité totale effectuée est faible



UN EFFONDREMENT DE LA PRATIQUE DE L'AP À L'ADOLESCENCE

- ▶ Entre l'enfance et l'adolescence, la pratique d'AP chute de **7% par an en moyenne**.
- ▶ Au total, c'est une chute de **60 à 70% durant l'adolescence** (entre 8-9 ans et 18-19 ans) (Dumith 2011)
- ▶ Ce déclin est plus marqué chez les filles entre 9 et 12 ans alors qu'il l'est entre 13 et 16 ans pour les garçons.

DÉFINITION DES « NIVEAUX D'ACTIVITÉ PHYSIQUE » (NAP)

niveau « élevé »	pratique d'une AP modérée ou intense tous les jours ou; pratique d'une AP intense au moins cinq fois par semaine
niveau « faible »	pratique d'une AP modérée ou intense au moins cinq fois par semaine ou; pratique d'une AP intense moins de trois fois par semaine
niveau « modéré »	toute autre situation intermédiaire

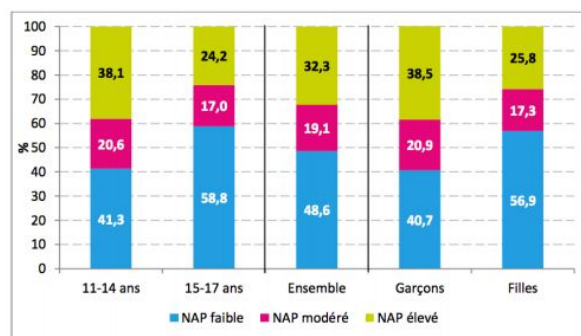
AP « MODÉRÉE »

Pratique physique pendant au moins 60 minutes consécutives, de façon peu intense, qui n'a fait ni transpirer, ni respirer plus difficilement que normalement.

AP « INTENSE »

Pratique physique pendant au moins 40 minutes consécutives, qui a fait transpirer et respirer plus difficilement que normalement.

REPARTITION DES NIVEAUX D'ACTIVITÉ PHYSIQUE DES ADOLESCENTS (11-17 ANS) SELON L'ÂGE ET LE SEXE.



Source : Étude INCA3, 2014-2015, traitement Anses

SUR L'ACTIVITÉ PHYSIQUE DES ADOS (11-17ANS) (ONAPS 2017)

- ▶ 12% des adolescents âgés de 11 à 14 ans déclarent suivre les recommandations actuelles (une heure d'activité physique au moins modérée par jour).
- ▶ **31% pratiquent au moins 1 heure par jour** d'activité physique au moins 5 jours par semaine.
- ▶ À cet âge, les **différences entre les sexes** commencent à se marquer.
- ▶ La fréquence de la pratique diminue avec l'âge.
- ▶ Il y a des différences de fréquence de pratique selon les régions.
- ▶ Deux tiers des collégiens ont eu au moins deux cours d'éducation physique au collège la semaine précédant l'enquête.
- ▶ Deux tiers des collégiens pratiquent un sport en dehors de l'école.

SUR LA SÉDENTARITÉ (3-17 ANS) (ONAPS 2017)

- ▶ La durée moyenne passée devant un écran par les enfants et adolescents âgés de 3 à 17 ans est d'environ **trois heures par jour**, chez les garçons comme chez les filles.
- ▶ Cette **durée moyenne augmente avec l'âge**, de façon plus marquée chez les garçons et avec une contribution de plus en plus importante du temps passé devant un ordinateur.
- ▶ La proportion d'enfants et d'adolescents passant plus de trois heures par jour devant un écran est d'environ 40%.
- ▶ Un collégien sur 9 passe plus de deux heures par jour devant un écran.
- ▶ La durée passée devant un écran est en moyenne **plus importante au nord de la France qu'au sud**, essentiellement en raison du temps passé devant la télévision.
- ▶ Près de **23% des enfants scolarisés en grande section de maternelle ont un écran dans leur chambre**. Le temps de sommeil diminue quand le temps passé devant un écran est plus élevé.

SUR LES MODES DE DÉPLACEMENTS (ENFANTS, ADOS, ÉTUDIANTS) (ONAPS 2017)

- ▶ Pour l'ensemble des enfants, adolescents et étudiants, le mode principal pour se rendre de leur domicile vers leur lieu d'études ou de garde **est la voiture**, avec 35% des déplacements, puis la marche et les transports en commun (environ 30% des déplacements chacun). Le vélo représente seulement 3% des déplacements.
- ▶ Le **vélo est deux fois plus utilisé par les garçons** que par les filles.
- ▶ Le mode de transport principal diffère selon l'âge : voiture chez les moins de 6 ans, marche chez les 6-14 ans et transports collectifs chez les plus de 15 ans.
- ▶ Près de 45% des jeunes ont moins de deux kilomètres à parcourir pour se rendre sur leur lieu d'études ou de garde et 21% entre 2 et 5 kilomètres.
- ▶ Plus de **70% des jeunes mettent moins de 15 minutes** pour se rendre sur leur lieu d'études ou de garde et 19% entre 16 et 30 minutes.
- ▶ L'utilisation de la marche pour se rendre sur leur lieu d'études n'a cessé de diminuer entre 1982 et 2008, contrairement à l'utilisation de la voiture, qui a augmenté sur cette période.
- ▶ Il existe de fortes disparités territoriales dans l'utilisation des modes actifs.
- ▶ 40% des jeunes de 2 ans ou plus scolarisés le sont hors de leur commune de résidence.

QUELQUES RESSOURCES AUTOUR DU PROJET « ICAPS »

- Le guide « Promouvoir l'activité physique des jeunes » (Fortement conseillé si vous développez une intervention sur le sujet de l'activité physique) : <http://inpes.santepubliquefrance.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1347.pdf>
- MOOC « Promouvoir l'activité physique et limiter la sédentarité des jeunes » (gratuit) : <http://moocaps.santepubliquefrance.fr/>
- Le projet ICAPS : <http://www.mangerbouger.fr/pro/collectivites-locales/agir-74/favoriser-l-activite-physique/promouvoir-l-activite-physique-desjeunes.html>

LECTURES CONSEILLÉES - TEXTES DE RÉFÉRENCE

- Les états des lieux ONAPS : <http://www.onaps.fr/Etudes-de-l-onaps/les-etudes-de-l-onaps/etats-deslieux/>
- Actualisation des repères du PNNS - Révisions des repères relatifs à l'activité physique et à la sédentarité. ANSES - 2016. <https://www.anses.fr/fr/system/files/NUT2012SA0155Ra.pdf>
- Recommandations mondiales en matière d'activité physique pour la santé. OMS - 2010 <https://www.who.int/dietphysicalactivity/publications/9789241599979/fr/>
- Activité physique : contexte et effets sur la santé. INSERM, 2008. <http://www.ipubli.inserm.fr/handle/10608/80>

Hygiène de vie - Écrans

Le cyberharcèlement

Avec les nombreux outils numériques disponibles, le harcèlement des élèves se poursuit en dehors de l'école.

Vidéo de lutte contre le harcèlement réalisée par des élèves de collèges :

- harcèlement physique (croche-pattes, coup, qui se répètent)
- harcèlement verbal (insultes, remarques sur le physique.. qui se répètent)
- cyber harcèlement

Que faire ? En parler ! La personne qui voit et qui ne fait rien est complice.

Définition du harcèlement

Les 3 caractéristiques du harcèlement en milieu scolaire :

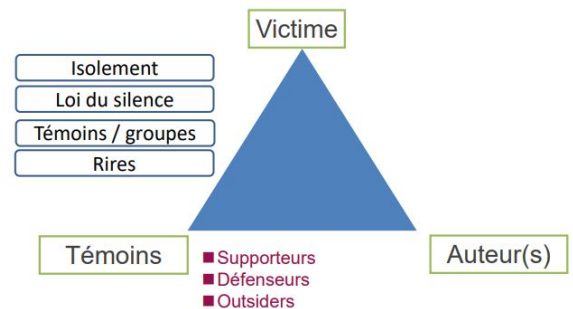
- La violence • **La répétitivité** • L'isolement de la victime

Le harcèlement touche tous les milieux sociaux et tous les milieux scolaires. Le harcèlement est une situation intentionnellement agressive.

12% des élèves de primaires

10% des collégiens

3,5% des lycéens



Processus du harcèlement

C'est un phénomène de groupe qui réunit plusieurs acteurs : victime, auteur et témoins. Les auteurs sont responsables d'une domination collective sur les victimes. Le **supporteurs** renforcent le harcèlement, les **défenseurs** se portent au secours des victimes et les **outsiders**, qui restent en retrait mais encouragent l'auteur par leur simple présence.

Être acteur ou victime peut avoir de très graves conséquences :

- difficultés scolaires
- absentéisme
- changement du comportement
- troubles métaboliques
- troubles anxio-dépressif

À terme, on peut avoir des troubles du comportement social avec l'apparition de comportements violents voire suicidaires. Même s'il n'y a pas de déterminisme, être auteur de violence dans sa jeunesse augmente le risque de violence intrafamiliale et de comportements délinquants.

Un profil type ? Il n'existe pas de profil type, tout le monde peut être victime de harcèlement à un moment de sa vie. Un élève victime de harcèlement serait un élève qui présente une différence que les autres ne peuvent accepter. "Chez sa victime, le harceleur reconnaît une faille qu'il ne veut pas voir chez lui".

Il existe différents profils d'auteurs, ils ont souvent un déficit d'empathie émotionnelle et cognitive. Certains sont dans la reproduction de la violence dont ils sont victimes (volonté de s'affirmer en harcelant).

Il existe des harcèlements directs et indirects (dont le cyberharcèlement).

Cyberharcèlement

Favorisé par :

- **Anonymat**, pas de contrôle d'identité des auteurs
- Aucun moment de répit pour la victime
- Diffusion massive et instantanée
- **1 élève sur 5 victime** selon l'éducation nationale

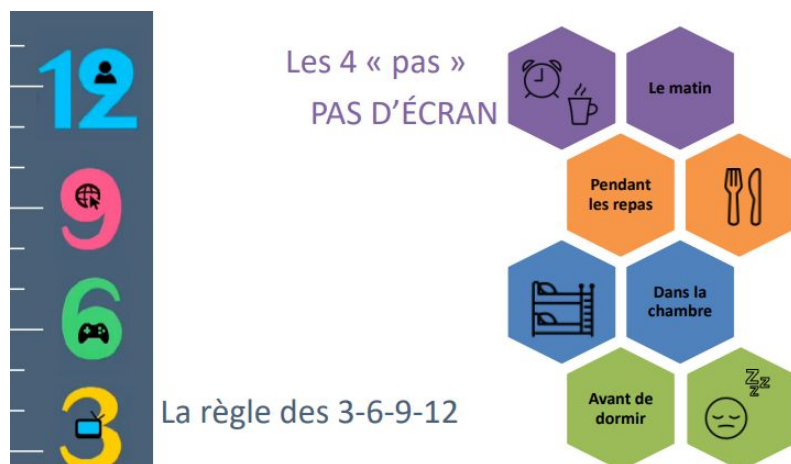
Les auteurs de cyberharcèlement risquent jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende si la victime a moins de 15 ans.

nonaharcelemnt.fr et numéro vert disponible 0800 200 000.

Temps d'écrans

Le temps passé sur les écrans rythme nos journées et celles de enfants. Il est nécessaire que ce temps soit régulé et ne soit pas une continuité.

Définitions, généralités



Le vécu des écrans est différent selon l'âge et le stade de développement de l'enfant. Il convient de ne pas laisser l'enfant seul et passif devant l'écran. Il a besoin d'un accompagnant adulte, d'un filtre critique pour faire face à ce qu'il perçoit.

La règle 3-6-9-12 se réfère à l'âge : par exemple pas de console de jeux avant 6 ans. La majorité numérique est fixée à 15 ans aujourd'hui.

Les réseaux sociaux

Points clefs

- Respect de sa vie privée personnelle et de celle des autres
- Régler les paramètres de confidentialité!
- Sécurité des profils
- Données privées
- Traitement soumis à la loi

- Exposition prolongée à de forts niveaux sonores
- Traumatisme sonore aigu

Ressources dispo sur comment sécuriser un mot de passe etc voir diapo

LES DIFFÉRENTS TROUBLES



Une surdité totale ou partielle qui peut apparaître prématurément et définitivement.



Des acouphènes: un bourdonnement ou un sifflement entendu tous les jours sans interruption.



Une hyperacousie qui rend la personne intolérante au moindre bruit.

POUR PLUS D'INFORMATIONS:
www.ecoute-ton-oreille.com

CES PROBLÈMES PEUVENT ARRIVER BRUTALEMENT ET À TOUT ÂGE. UN SEUL EXCÈS PEUT SUFFIRE.

LES BONS GESTES À ADOPTER

Avec un casque ou des écouteurs.



Réglez le volume à la moitié du maximum du baladeur.



Limitez la durée d'écoute.

Utilisez les casques ou écouteurs fournis avec l'appareil, ils garantissent un volume sonore maximum de 100 dB. Réglez le volume dans un endroit calme et ne l'augmentez pas en fonction du bruit environnant.

En concert et en boîte.



Éloignez-vous des enceintes.



Faites des pauses, 30mn toutes les 2h ou 10 mn toutes les 45 mn à l'extérieur ou dans une zone calme.



Portez des bouchons d'oreilles en cas d'inconfort ou de douleur. Pour les retirer, il est nécessaire d'être au calme pour ne pas exposer brutalement ses oreilles à un volume sonore élevé.

Risque auditifs

La compression audio dynamique

Permet de relever le niveau sonore des sons les plus faibles pour homogénéiser l'écoute. Le risque auditif est lié au fait que l'intensité maximale du son est éteinte bien plus fréquemment lors d'une écoute, voir de façon continue.

Ondes électromagnétiques

Wifi: protocole de connexion entre appareils par le biais d'ondes électromagnétiques.

Les données sont véhiculées par ondes radioélectriques (comme la TV et la radio).

Principes de précautions : Éviter une trop grande proximité (1m) sur un temps long.

Aujourd'hui le wifi est très peu présent dans les établissements scolaires

INTRODUCTION

Extrait de la **définition de l'OMS** :

- « Etat de bien-être physique, émotionnel, mental et social associé à la sexualité. Elle ne consiste pas seulement en l'absence de maladie, de dysfonctionnement ou d'infirmités.
- Une approche **positive et respectueuse** de la sexualité.
- Du plaisir en toute sécurité et sans contraintes, discrimination ou violence.
- Comprend le sexe biologique, identité et le rôle sexuel, l'orientation sexuelle, l'érotisme, le plaisir, l'intimité et la reproduction.
- Influencée par des **facteurs** biologiques, psychologiques, sociaux, économiques, politiques, culturels, éthiques, juridiques, historiques religieux et spirituels. »

ANATOMIE ET PHYSIOLOGIE

Pourquoi parler de santé sexuelle ?

Baromètre santé sexuelle 2016 (santé publique France):

- **16,5% des hommes (1/6) vs 6,9% des femmes (1/15)** ont eu leur premier rapport sexuel avant 15 ans
- Pour **1 fille sur 10**, ce premier rapport est accepté MAIS pas vraiment souhaité
- Presque **2%** déclare avoir été forcé contre **0,3%** chez les garçons
- Pour 9% soit 1 adolescent sur 11, ce rapport n'est pas protégé
- L'âge médian du premier rapport est de **17,6 ans pour les filles, 17 ans pour les garçons**
- De plus en plus de violences sont déclarées : chez les 15-17 ans **8% des jeunes femmes ont déjà été confronté à des rapports forcés vs 1% des jeunes hommes**

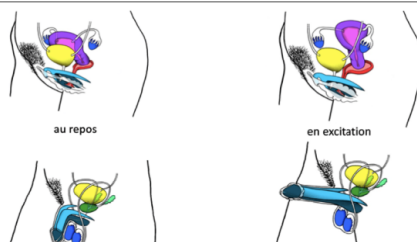
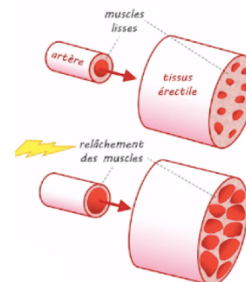
Anatomie des organes génitaux externes

Les corps érectiles

Tous les êtres humains sont dotés d'un appareil qui entre en érection lorsqu'ils sont excités sexuellement.

Ils ont la même structure anatomique et histologique.

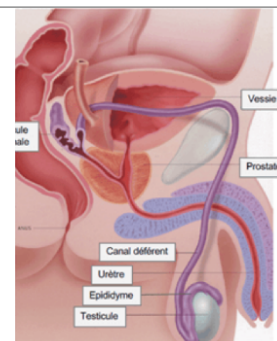
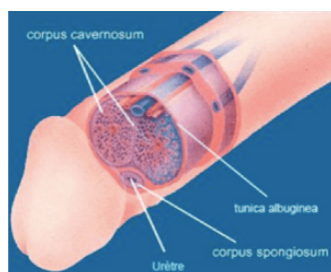
- Chez l'homme : le **pénis**, Deux corps caverneux et un corps spongieux.
- Chez la femme : le **clitoris** (seul le gland est visible). Deux corps caverneux qui forment le clitoris et deux corps caverneux qui forment les bulbes du vestibule.



Anatomie chez le garçon (1)

Les organes génitaux chez l'homme sont essentiellement externes.

- **A gauche:** pénis en coupe transversale. On observe que l'urètre est protégé par les corps spongieux
- **A droite:** organes internes



Anatomie chez le garçon (2)

Question de taille, de durée...

- **La taille c'est important ?** La taille du sexe varie avec l'âge, c'est seulement à la fin de la puberté que sa taille devient définitive.
- Il faut tenir longtemps comme dans les films pornos ?
 ▲ Modèles de la pornographie = mise en scène de la sexualité, ++ c'est interdit au moins de 18 ans !!

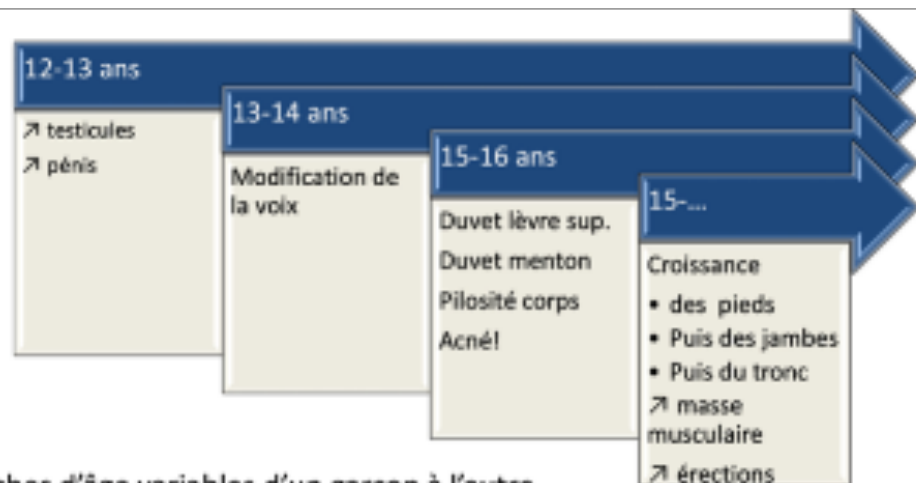
	La circoncision ou posthectomie : • Du latin <i>circumcisio</i> = signifiant « découper autour » • Circoncision = excision du prépuce (rôle protecteur des muqueuses) • Intervention brève • Motif religieux ou médical (cas de phimosis par exemple) • Pas de modification du plaisir
Anatomie chez la fille	Le clitoris • L'organe du plaisir féminin • Contrairement à l'homme, les organes érectiles sont cachés • Le gland du clitoris ne se redresse pas du fait de la fusion des petites lèvres qui l'immobilisent 
	L'hymen • Petite membrane perforée qui ferme partiellement l'entrée du vagin • Rupture +/- indolore • +/- vascularisé • Certaines filles n'ont pas d'hymen. • Très différent d'une fille à l'autre dans sa forme (rond, ovale, troué...) et plus ou moins souple • Si l'hymen est souple : pas nécessairement de saignement lors du 1er rapport ▲ <i>n'est pas lié à la virginité</i>
	La vulve • Etude British Journal of Obstetric and gynecology : mesure de la vulve sur une population de 650 femmes, 15-84ans) => Clitoris: moyenne de 6,9 mm; Petites lèvres: moyenne de 22,6mm. Avec écart type important. • Il n'existe pas de vulve modèle mais beaucoup de modèles de vulves. ▲ En informer les adolescentes, inquiètes de trouver leur anatomie génitale différente de celle montrée par la pornographie.
Bases physiologiques et idées reçues (1)	L'excision • Mutilation sexuelle féminine (MSF) • Les MSF regroupe toute intervention incluant l'ablation partielle ou totale des organes génitaux externes de la femme ainsi que toute lésion des appareils génitaux féminins pour des raisons culturelles ou religieuses (clitoridectomie, nymphectomie totale..) • Ces pratiques sont punies par le code pénal car considérées comme des violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente: 10 ans d'emprisonnement et 150 000€ d'amende • 2016: 200 millions de femmes ont subi une mutilation sexuelle (Egypte, Ethiopie, indonésie ++)
	• Nombreux aspects: sociaux, affectifs, culturels • Le désir sexuel prend sa source dans le cerveau il peut être réveillé par une stimulation mécanique des organes génitaux ou d'un autre endroit du corps, par une phrase, une pensée, une odeur, un son. • Le cerveau ne nous permet pas de choisir ce qui provoque le désir mais il peut réprimer ce désir même si ce n'est pas facile • Le désir peut aussi être inhibé par un processus involontaire • Si le désir n'est pas réprimé il y a activation du SNA qui va déclencher l'excitation sexuelle

Bases physiologiques et idées reçues (2)	Les hommes possèdent un pénis, alors que les femmes n'auraient pas d'organe équivalent. • 1ère idée reçue: Il serait donc normal que les femmes ne sachent pas ce qu'elles veulent, soient frigides, que le vagin soit le siège de leur plaisir sexuel, ne se masturbent pas... • 2ème idée reçue: il serait donc normal que chez les femmes le plaisir relève d'une construction mentale. Dépendant de l'existence de sentiments amoureux envers le partenaire, basée sur le masochisme: les femmes jouissant d'être dominées ou violentées, comme le laisse croire la pornographie ? → Asymétrie « naturelle dans le désir et le plaisir → Savoir dire non • Autres conséquences : - Les garçons auraient une obligation de « performance » fixée sur leur pénis ? - Les pratiques homosexuelles seraient « contre-nature », la sexualité se pratiquant naturellement entre personnes dotées d'organes complémentaires?..
La pornographie	• Ce n'est pas un modèle de sexualité ! • C'est une industrie qui produit des contenus sexuels adaptés au marché • Faits pour générer l'excitation sexuelle • Montre des images violentes, ne correspondent pas à la réalité et les insécurisent. Les jeunes n'ont pas la maturité nécessaire pour se défendre. • La diffusion de contenus pornographiques à destination des mineurs est interdite.

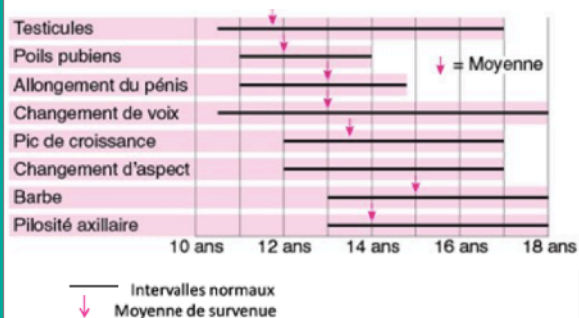
PHYSIOLOGIE DE LA REPRODUCTION

1. LE GARÇON

La puberté	• Maturation des caractères sexuels secondaires • Du latin « <i>pubere</i> » : se couvrir de poils • Tranches d'âge variables d'un garçon à l'autre • Entre 11 et 14 ans mais à chacun son rythme de développement • Développement des testicules - de façon non symétrique - le développement du tube séminifère est la première cause du développement des testicules - Jusqu'à 20 ans • 6 mois plus tard la pilosité pubienne: - scrotum se pigmente - Pénis grandit • L'apparition de la pilosité faciale est plus tardive - Duvet lèvre supérieure vers 15 ans - Sur les joues vers 16 ans puis sur le menton • Pilosité complète entre 25 et 35 ans • Apparition d'une gynécomastie est fréquent (70% des garçons entre 13 et 16 ans), elle régresse spontanément dans les 3 ans qui suivent mais persistent chez 30% des hommes adultes • Larynx se développe, les cordes vocales s'épaississent sous l'influence de la testostérone. La mue de la voix vers 13 ans et demi. • La poussée de croissance pubertaire est plus tardive chez le garçon que chez la fille, autour de 15 ans, dure de 3 à 6 ans avec des variations saisonnières (s'accélère au printemps). - 20-25 cm pendant la puberté soit environ 9 cm par an - Pied avant jambe et cuisse - Croissance du tronc est plus tardive (jusqu'à 25 ans) • La composition du corps évolue aussi. Avant la puberté, la masse grasse et la masse maigre a peu près équivalent dans les deux sexes. Après la puberté, la masse osseuse et la masse musculaire (2 fois plus) sont plus importantes chez le garçon. La fille a 2 fois plus de masse grasseuse.
------------	---



Tranches d'âge variables d'un garçon à l'autre
Entre 11 et 14 ans mais à chacun son rythme de développement !

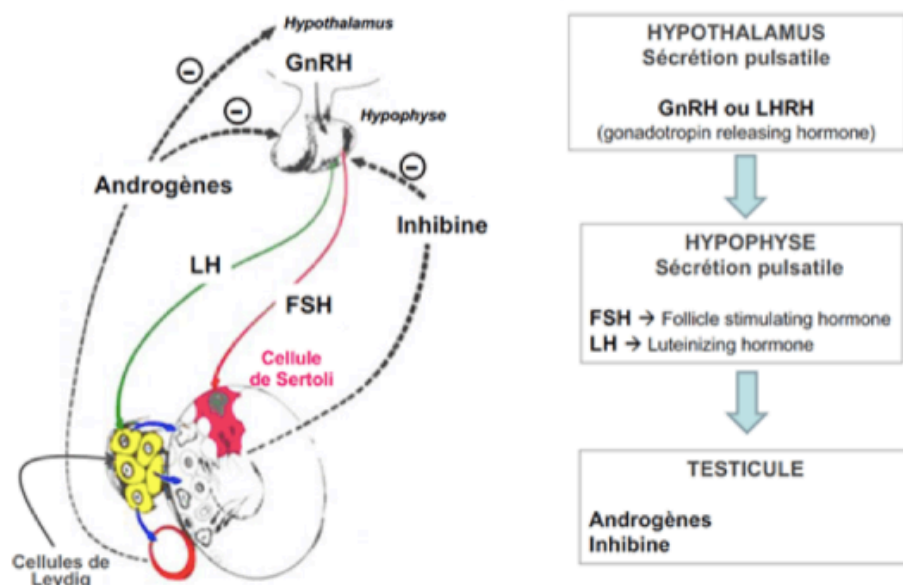


La maturation sexuelle chez le garçon

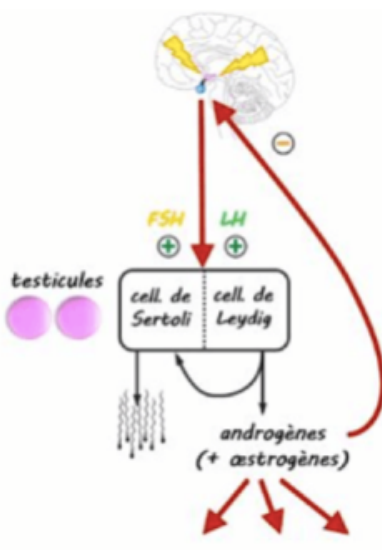
Classification de Tanner chez le garçon

Organes génitaux externes (G)	Age moyen	± 2 DS
G1 Testicule, scrotum et pénis de taille prépubère.		
G2 Croissance du scrotum et des testicules. Peau scrotale plus rouge, mince et rugueuse. Le pénis n'a pas grandi.	11,6	9,5-13,8
G3 Croissance du pénis en longueur. Allongement du scrotum et augmentation du volume testiculaire.	12,85	10,8-14,9
G4 Le pénis continue de grandir: le contour du gland devient visible. Pigmentation plus marquée du scrotum.	13,8	11,7-15,8
G5 Organes génitaux adultes. Le pénis arrive au niveau inférieur du scrotum.	14,9	12,7-17,1
Pilosité pubienne (PP)		
PP1 Absence de pilosité, duvet semblable à celle du reste de l'abdomen.		
PP2 Quelques poils légèrement pigmentés, droits, allongés, en général à la base du pénis, quelquefois sur le scrotum.	13,4	11,3-15,6
PP3 Poils pubiens bien visibles, pigmentés, bouclés, limités à une petite zone autour de la base du pénis.	13,9	11,8-16,0
PP4 Pilosité de type adulte, mais peu fournie, ne s'étendant pas au-delà des plis inguinaux.	14,4	12,2-16,5
PP5 Pilosité adulte s'étendant sur les cuisses, mais peu ou pas sur l'abdomen (sommet horizontal).	15,2	13,0-17,3
PP6 La pilosité s'étend sur la ligne médiane de l'abdomen (sommet en losange chez 80% des hommes adultes).		

5. Régulation neuro-endocrine de la spermatogenèse



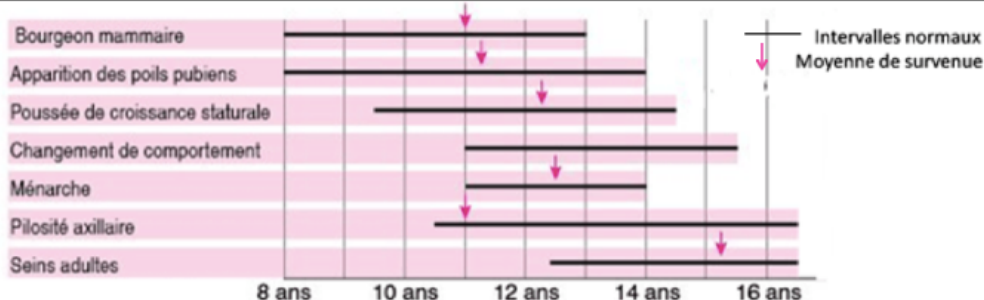
Rappels de la physiologie

Contrôle hormonal de la fonction de reproduction	• Sous l'action de FSH et LH - Stimulation des cellules de Sertoli : production en continu de spermatozoïdes, largués dans les tubes séminifères, - Stimulation des cellules de Leydig : production d'androgènes dont la testostérone, largués dans la circulation générale (une partie est ensuite convertis en oestrogène, - Rétrocontrôle négatif: maintien du taux de testostérone dans une certaine plage mais n'est pas constant, - Le taux de testostérone diminue progressivement à partir de 25-30 ans et dépend de plusieurs facteurs - Si adm de testostérone exogène → diminution production de spermatozoïdes (ex: principe de la contra masculine, ou d'androgènes anabolisants pour augmenter la masse musculaire)	
Conséquences de la physiologie masculine	1. Wet dream • Csq de la permatogénèse en continu • Plus importante à l'adolescence (plusieurs fois /semaine ou /nuit): - Elimination nécessaire l'excédent de spermatozoïdes = fonction naturelle - Réflexe éjaculatoire : déclenchement non contrôlé, plus fréquent au début de la puberté, plus fréquent avant les premiers rapports sexuels, durant les phases de sommeil paradoxal - La libido s'exprime à travers les rêves	
	2. Une grosse pomme • Proéminence laryngée • En lien avec la production de testostérone: - Croissance du larynx - Permet le développement des cordes vocales : fines = vibration rapide = voix aiguë; épaisses = vibration lente = vix grave - Période de mue entre 3 mois et 1 an ▲ La mue concerne les deux sexes, même si plus marquée chez les garçons que les filles.	
	3. Une virilité au poil • La virilité = un gros sexe + des gros poils + des gros muscles ? • Du latin <i>virilitas</i>: ensemble des caractéristiques physiques de l'homme adulte • Se sentir viril = un état d'esprit personnel et qui renvoie à la manière dont on se sent homme	
Questions fréquentes	Ejaculation précoce • Ejaculation avant ou juste après pénétration • Fréquent lorsdes premiers rapports sexuels • Souvent lorsqu'on n'est pas très sûr de soi, • Cela s'arrange avec le temps et avec l'aide de sa (ou son) partenaire, • +/- lié au stress → en parler avec personne de confiance ou médecin	
	Panne sexuelle • Impossibilité d'avoir une érection permettant la pénétration • La cause : manque de désir, ou le contraire (désir trop important) ! • Passager ou non → dédramatiser → en parler avec son partenaire	

2. LA FILLE

La puberté

- Maturation des caractères sexuels secondaires
- Du latin « *pubere* » : se couvrir de poils
- Tranches d'âge variables d'une fille à l'autre
- Entre **9 et 13 ans** mais à chacun son rythme de développement



- Chez la plupart des filles le **bourgeon mammaire** est le premier signe visible de la maturation sexuelle suivie de près par l'accélération de la **croissance**.
- Après les **pilosités** pubiennes et axillaires apparaissent
- Les premières règles, les **ménarches**, apparaissent généralement 2 ans après le début du développement mammaire alors que la croissance stature ralentit après avoir atteint son pic.
- La ménarche apparaît dans une large fourchette d'âge. Aux Etats-Unis par exemple les filles ont leur ménarche entre **12 et 13 ans**.
- Les stades du dvpt des caractères féminins sont détaillés dans la **méthode de Tanner** (ci-dessous, exemple du dvpt des seins et de la pilosité pubienne)

▲ On a aussi le tableau de la méthode Tanner pour les garçons mais elle n'en parle pas à l'oral.

Stades de Tanner

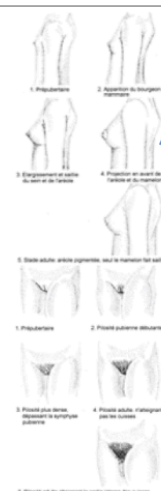
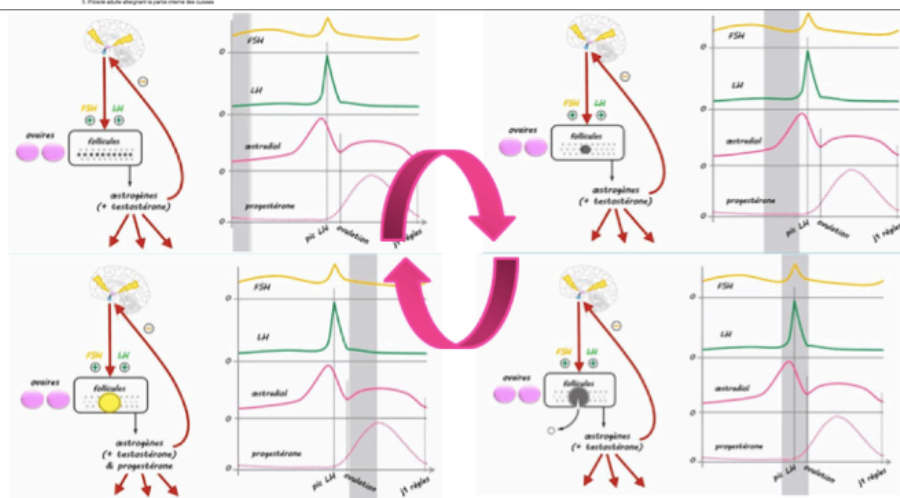


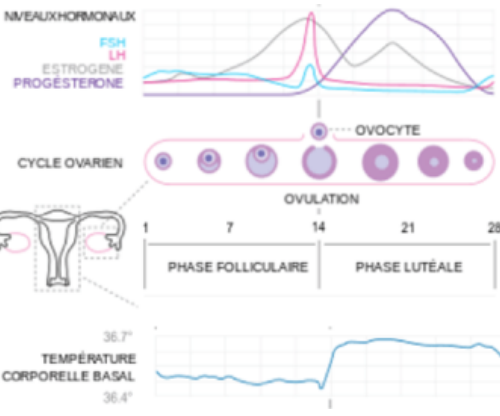
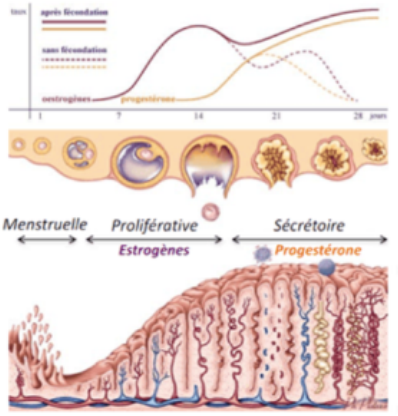
Tableau de la classification de Tanner chez la fille

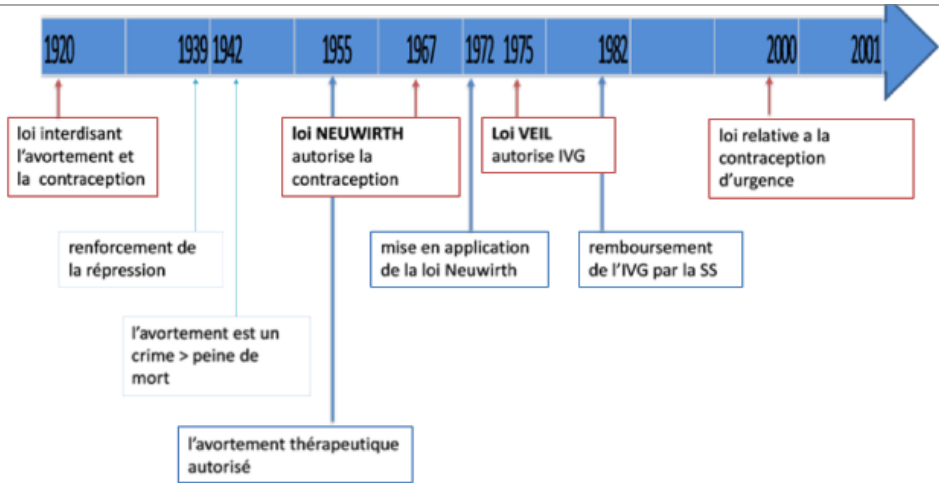
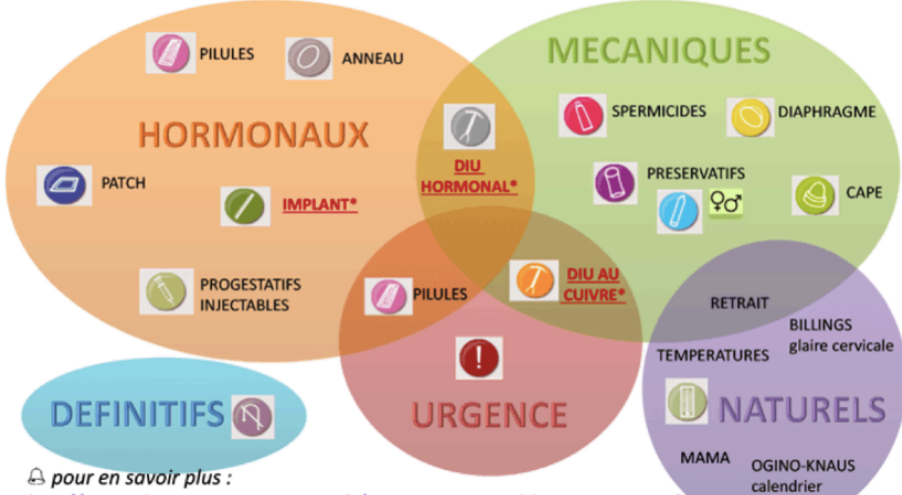
Seins (S)	Age moyen	± 2 DS
S1 Pas de seins, élévation éventuelle du mamelon.		
S2 Apparition du bourgeon mammaire.	11,5	8,9-13,25
S3 Apparition de la pigmentation du mamelon et de l'aréole. De profil, la saillie mammaire est bien visible.	12,5	10,0-14,3
S4 Projection antérieure de l'aréole et du mamelon.	13,1	10,8-15,3
S5 Anatomie de type adulte. Retour de l'aréole dans le plan de la surface du sein et sillon sous-mammaire distinct.	15,3	11,85-18,8
Pilosité pubienne (PP)		
PP1 Absence de pilosité pubienne.		
PP2 Quelques poils longs pigmentés, apparaissent sur le mont de Vénus, ou souvent d'abord sur le pourtour des grandes lèvres.	11,7	9,3-14,1
PP3 Pilosité plus dense, dépassant la symphyse pubienne.	12,4	10,2-14,6
PP4 Poils de type adulte, mais limités au mont de Vénus, ébauche de triangle pubien.	12,95	10,9-15,1
PP5 Pilosité de type adulte atteignant les cuisses.	14,4	12,2-16,65

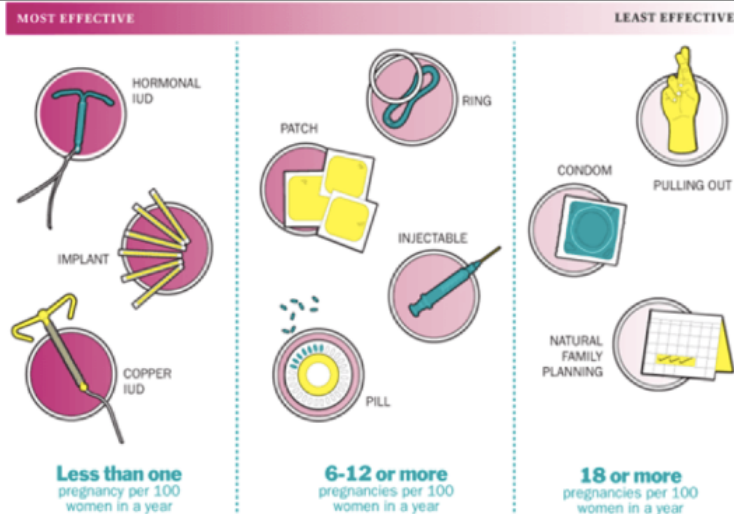
Rappels de la physiologie

(on voyait pas ce qui était écrit déjà sur le diapo - cours HBDD3)



	Régulations hormonales du cycle ovarien	Le cycle utérin
		
Conséquences de la physiologie féminine	1. Les règles Questions https://matilda.education/app/course/view.php?id=266 - La plupart des femmes utilisent des euphémismes pour parler de leur règles. Les publicités nous montrent du sang bleu. <i>Est ce un sujet tabou ? Pourquoi ? Est-ce sale ? Gênant ? Tampon, serviette, bios, lavables, cups ? Quelles protections ? Peut-on avoir des rapports pendant les règles ?</i> Enjeu d'égalité très important car les femmes perdent confiance en elles. - Tabous depuis la nuit des temps: le sang menstruel donnait la rage aux chiens, ternit les miroirs, fait mourir les aliments, moins noble que le sang perdu au combat par les soldats.. - Les tabous ont perduré car les femmes sont considérés comme impures lors de leur menstruation donc on ne parle pas de ce sujet. - Dans les religions monothéistes aussi. <i>Exemple de la Bible</i> : les femmes devaient sacrifier deux tourterelles pour redevenir pure après leurs règles. - Ce tabou maintient les femmes dans une situation de domination. - On n'en trouve pas des les endroits publics contrairement aux préservatifs. Ex: toilettes publiques, hôtels, toilettes collège, lycée.. - Débat sur la taxe appliquée aux produits d'hygiène.	
	2. Autres conséquences - Les cycles ne durent pas forcément 28 jours - Les règles peuvent être irrégulières (fréquent chez les adolescentes) - L'ovulation ne survient pas forcément au 14e jour - Le grossesse est possible lors du 1er rapport sexuel	
Lubrification	- En cas d'excitation sexuelle : lubrification de la vulve et du vagin par glandes de Skene + glandes de Bartholin - Facilite la pénétration et protège des irritations - Plus de risque que le préservatif craque si manque de lubrification Insuffisance de lubrification possible en cas de : rapport précipité, angoisse, stress, prise de médicaments → Savoir dire non	
3. CONSÉQUENCES		
Est-ce que je (tu, il, elle) suis normal(e) ?	- A chacun son rythme: la puberté se manifeste à des moments différents, selon les personnes. Autant de corps différents que d'individus: attention aux images. - Adolescence est un passage difficile. Moment d'explosion intense créatrice et émancipatrice. Perte de l'enfance. Tout change.	

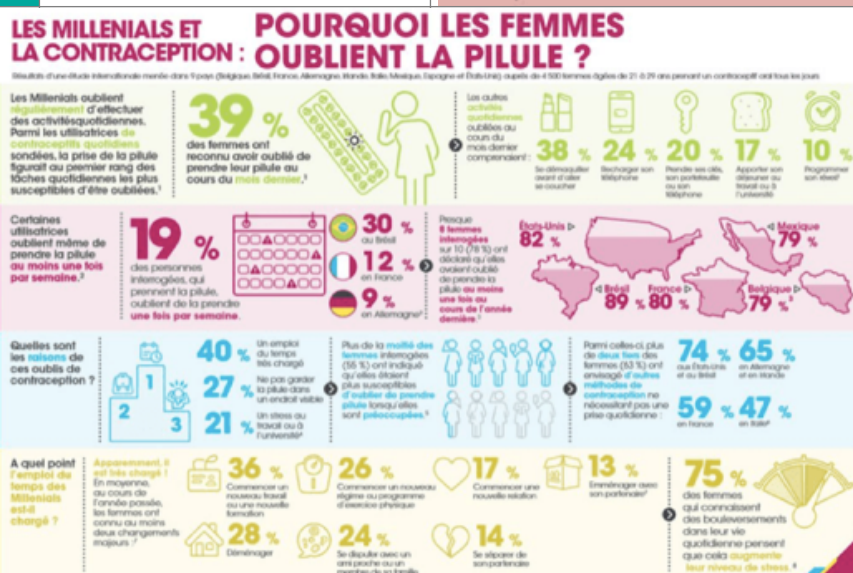
GENERALITES SUR LA CONTRACEPTION	
Définition	« Utilisation d'agents, de dispositifs, de méthodes ou de procédures pour diminuer la probabilité de conception ou l'éviter » (OMS) - L'ensemble des méthodes visant à éviter de façon temporaire ou définitive la grossesse.
Un peu d'histoire	Pratique ancestrale 1er préservatif (étui pénien) retrouvé 6000 avant JC 1er dispositif intra utérin (DIU) il y a 5000 ans - Beaucoup ont utilisé les plantes comme l'acacia, le miel et les huiles. Introduits dans le vagin pour limiter mécaniquement la remontée des spzs dans l'utérus. - Pratiques d'avortements aussi retrouvés.
Plus récemment en France	- Après la 1ère Guerre Mondiale, les femmes ont été poussé à rentrer chez elles pour faire des enfants et donc compenser la baisse démographique. - La loi VEIL était mise en place pour seulement 5 ans (1975-1979) mais a été reconduite. 1999 : suppression de l'autorité parentale pour l'IVG 2001 : mise en place de la pilule du lendemain + gratuite pour les mineures 
Mode d'action des contraceptifs	Peuvent agir à 3 niveaux Bloque l'ovulation : effet anti-gonadotrope des contraceptifs hormonaux. Ils empêchent la maturation et le relargage de l'ovocyte. Empêche la fécondation (rencontre Spz et ovule) : soit physiquement comme avec le préservatif soit en rendant la glaire cervicale moins favorable à la remontée des spermatozoïdes Empêche la nidation : en rendant la muqueuse utérine impropre à l'implantation de l'oeuf fécondé  pour en savoir plus : http://www.choisirsacontraception.fr/contraception_tableau_comparatif.htm

Efficacité des contraceptifs	• Indice de Pearl = nombre de grossesses observées pour 100 femmes utilisant la méthode contraceptive pendant 1 an. Ex: si indice de Pearl = 2 signifie que dans l'année, 2 femmes sur 100 ont débutée une grossesse en utilisant la méthode contraceptive • Utilisation optimale ≠ utilisation dans la vie courante : il faut prendre en compte les différents accidents possibles. Ex: oublis de pilule, décollement des patchs, déchirure des préservatifs... • On considère qu'une contraception est très efficace si l'indice de Pearl est < 1. → Implant, contraception chirurgicale ou stérilet. • Efficace si indice de Pearl entre 1 et 9. → Cas de la plupart des contraceptifs hormonaux. • Si indice de Pearl supérieur à 10, la contraception est modérément efficace. → Ensemble des contraceptions barrières et naturelles. ▲ Moins efficace si > 26. (pas dit à l'oral) 
Contraception lors du premier rapport	• Augmentation constante de l'utilisation du préservatif depuis les années 80 • Diminution du recours à la pilule depuis 2004 • Sans contraception : - Pour les filles = stables depuis 1995 - Diminution chez les garçon
Méthodes des contraceptions en France	• Augmentation de l'utilisation de la pilule en France depuis sa légalisation (années 70). Moyen de contraception le plus utilisé devant le préservatif et le stérilet. • Diminution de l'utilisation de la pilule depuis 2013 avec en contrepartie une augmentation de l'utilisation du stérilet et du préservatif. Ainsi qu'une faible augmentation de la contraception naturelle. • 40,8% des femmes utilisant la pilule en 2010 pour 33,2% en 2016. • 18,7% utilisaient des dispositifs intra-utérins en 2010 contre 25,6% en 2016 • La pilule reste le moyen de contraception le plus utilisé, particulièrement chez les moins de 25 ans • Chez les 30-34 ans : utilisation pilule = utilisation stérilet • Après 35 ans : DIU
A retenir	• Choix individuel • Réfléchi avec un médecin ou une sage-femme • Ne nécessite pas obligatoirement un examen gynécologique • La délivrance anonyme et gratuite dans les centres de planifications ou d'éducation familiale (CEPF) • La contraception protège de la grossesse mais pas des IST • Le pass contraception avec la carte M'ra : visite médicale et accès gratuit à la contraception. Il ne nécessite pas la présentation de la carte vitale aux professionnels de santé.

LA PILULE ET AUTRES CONTRACTIONS HOMONALES

Généralités	Rappel sur les chiffres d'utilisation de la pilule vu dans « Généralités de la contraception » • Rétrocontrôle sur l'axe hypothalamo-hypophysaire • Progestatifs +/- oestrogènes de synthèse • 3 verrous possibles: 1. Bloque l'ovulation : oestroprogestatives (OP) 2. Modifie la flore : micro progestatives (P) 3. Modifie l'endomètre empêchant la nidation : micro progestatives (P)
Différents types de pilules	Oestroprogestative (OP) • Discontinu 21 cp + une semaine d'arrêt • Continu 28 cp (placebo) • Oestrogène : éthynilestradiol. 15-40 µg. • Monophasique, si dosage identique tout au long du cycle. • Bi ou triphasique, si le dosage de progestérone ou d'oestrogènes évolue. Les plaquettes sont alors de différentes couleurs • Micropilules si dosage < 25 µg • Progestatifs : définissent les différentes générations de la pilule • Cas particuliers: - Oestrogène naturel : Qlaira® et Zoely® - Diane 35 : pas d'AMM pour la contraception = traitement acné
	Micro Progestatives (P) • Contenu 28 cp actifs (contenu) • 2 types de progestatifs
	Progestatifs normodosés • Dysménorrhée, ménorragie, THS de la ménopause • Effet contraceptif • <u>Prescription hors AMM</u>
Focus sur les pilules OP	• 2ème génération contenant du lévonorgestrel mais en première intention • Seules les COP 2ème génération sont remboursées • 3e et 4e générations augmentent le risque thromboembolique • IP* = 0,2 en utilisation optimale • IP = 8 en utilisation courante (erreur de prise) • ✗ CI : Tabc + âge > 35 ans, migraine avec aura ... • ✗ Interaction avec les inducteurs enzymatiques <i>*IP = Indice de Pearl (vu cours précédent)</i>
	Modalités de prise • 1er comprimé de la 1ère plaquette pris le 1er jour de règles • Tous jours à la même heure (décalage maximum de 12 heures) • Discontinu : arrêt 7 j est normalement supérieur à la durée des règles. • Reprise toujours le même jour de la semaine si on commence la 1ère tablette un jeudi on doit commencer la suivante un jeudi. • Continu : comprimés placebo • Méthode QUICK START : - Démarrage n'importe quel jour du cycle - S'assurer de l'absence de grossesse ++ - Protection nécessaire 7j (préservatif) - Risque de métrorragie sur la première plaquette - Même efficacité si précautions respectées - Pas de potentialisation de l'effet contraceptif

Focus sur les pilules P	• 2 progestatifs - Levonorgestrel 30 µg : pas d'action anti-ovulatoire. ✗ Prise régulière très importante : décalage <3h (Microval®) - Désogestrel 75 µg : <u>action anti ovulatoire</u> ✗ Décalage possible < 12h • Prescrit en cas de CI aux OP • EI : Métrorragie, aménorrhée, cycles irréguliers • IP = 8 en utilisation courant, comparable à celui des COP Modalités de prise • 1er comprimé de la 1ère plaquette pris le 1er jour de règles • Tous jours à la même heure (décalage maximum de 12 heures) • Prise continue
Prescription des pilules	• Prescription par : médecin, sage femme • Pas d'examen gynécologique systématique • Délivrées pour 3 mois • Renouvellement par IDE (infirmière) ou un pharmacien pour 6 mois max si prescription initiale <1 an • Délivrance anonyme et gratuite dans les centres de planification ou d'éducation familiale (CPEF) • Conduire à tenir en cas d'oubli • Contraception d'urgence
Cas particulier des adolescentes	• L'adolescente sera reçue de préférence sans ses parents • Le consentement des titulaires de l'autorité parentale n'est pas requis • Une prise en charge gratuite et confidentielle dans les CPEF • Info IST +++ • Vaccination HPV (rattrapage jusqu'à 19 ans)
Conduite à tenir en cas d'oubli	Si vous avez dépassé le délai indiqué sur la carte Pour retrouver une contraception efficace, il faut au moins 7 jours de comprimés actifs en continu après l'oubli. 1 Prenez immédiatement le dernier des comprimés oubliés et poursuivez la plaquette à l'heure habituelle. 2 Utilisez des préservatifs pendant 7 jours. 3 Si l'oubli concerne 1 des 7 derniers comprimés actifs, poursuivez la plaquette jusqu'à la fin des comprimés actifs, puis enchaînez avec la plaquette suivante (sans jour d'interruption ou sans prise de comprimé inactif). En cas de rapport sexuel dans les 5 jours précédant l'oubli, prenez la contraception d'urgence. Pour plus d'information ou pour être aidée, rendez-vous chez votre pharmacien, dans un centre de planification ou sur www.choisirsacontraception.fr



CAT en cas de vomissements	• Vomissements ou diarrhée • Délai <4h après la prise d'un comprimé actif • Reprendre un comprimé ✗ Si possible identique au précédent si la pilule comporte plusieurs dosages (bi ou triphasique).
Idées reçues sur la pilule	• Prise de poids : progestérone stimule l'appétit mais absence de preuve fiable entre la prise de poids et la pilule • Ça rend stérile : ovulation reprend directement après arrêt, il y a aussi des cas de grossesses sous pilules • Ça donne des boutons : résultats hétérogènes des études car les effets anti-androgéniques diffèrent selon les progestatifs. Certaines études montrent une réduction de l'acné sous OP. <i>Si apparition de l'acné sous une pilule de 2^{de} génération → changement de pilule (CNGOF).</i> Les pilules avec de l'acétate de cyprotérone ou de chlormadinone sont plus efficaces sur l'acné que celles contenant du lévonorgestrel. • Les hormones c'est pas bon pour la santé : Depuis 2012 crise sanitaire après la mort d'une jeune femme sous pilule OP ayant fait un AVC. Augmentation risque thromboembolique + cancer du sein + cancer du col de l'utérus mais diminution de ces risques après arrêt de la pilule. En revanche pilule OP sont associées à une diminution du cancer colorectal, de l'endomètre, de l'ovaire ainsi que des hémopathies malignes. • Il faut l'accord de mes parents : non systématique • Il faut aller chez le gynécologue : non systématique
Le patch contraceptif	• Un seul en France EVRA® • Progestatif de 3^{ème} génération : multiplie par deux le risque thromboembolique par rapport aux pilules de 2^{ème} génération • Non remboursé SS • 1 seul patch par semaine, pendant 3 semaines • 1 semaine d'arrêt durant lesquels les règles surviennent • Indice de Pearl comparable à celui des COP oraux, entre 0,3/8 (= utilisation correcte/utilisation courante, à retenir pour la suite) • Risque de décollement : 2-3% • Si décollement > 24h ou pas changé, dépassement délai de 48h : - nouveau patch + protection préservatifs 7j; - envisager contraception d'urgence si rapport à risque dans les 5j précédents. • On aura donc une modification du jour de pose. • Si oubli de reprise > 7j prévoir protection préservatif 7j ▲ Efficacité diminue si IMC augmente ▲ Ne pas retirer (douche, piscine, hammam) ▲ Sites de poses doivent changer toutes les semaines • Mêmes effets indésirables et contre indications que les COP oraux
L'anneau vaginal	• Progestatif de 3^{ème} génération (R = 2^{ème} G) • Non remboursé par la SS • En place pour 3 semaines • Discontinu : 1 semaine sans anneau qui provoquent les règles • Continu : changement toutes les 3 semaines, donc pas de règles • IP = celui des COP = 0,3/8 • Ne pas retirer pendant les rapports sexuels • Si retiré > 3h : - le rincer à l'eau froide et le remettre - Protection préservatifs pendant 7j - Envisager contraception d'urgence si rapport de risque < 5j précédents • Si laissé en place > 3 semaines : peu de risques mais protection préservatif • Si oubli de reprise > 7j : prévoir protection préservatifs 7j • Mêmes effets indésirables et contre-indications que les COP oraux
Autres	L'implant et le DIU (<i>ci autre cours</i>) sont des contraceptions à longue durée d'action.

LE PRESERVATIF ET AUTRES CONTRACEPTIONS MECANIQUES		
Généralités	Eviter la rencontre des Spz et de l'ovule Dispositifs barrières : - Préservatifs, cape, diaphragme ... - Evite la remontée des Spz dans les voies génitales - Risque de grossesse ++ car taux d'échec de 16 à 30% Dispositifs intra utérin (DIU): - Toxique pour les Spz - Epaisissent la glaire cervicale - Rend l'endomètre impropre à la nidation	
Le préservatif masculin	• Protège de la grossesse ET des IST (HIV) = LE SEUL • Evite la libération des spz dans les voirs génitales féminines • Usage unique • A mettre avant tout contact sexuel • A retirer avant la fin de l'érection • IP = 15 en utilisation courante, soit de faible efficacité	
	Idées reçues • Ça coupe le plaisir : modifie les sensations, mais n'empêche pas le plaisir qui ne se limite pas à des contacts génitaux. • J'ai pas ma taille : différentes tailles dans le commerce. • Il est trop petit, il va craquer : testé en laboratoire, matériaux extensibles. • On peut garder le même si on a plusieurs rapports successifs pour faire des économies. • Il faut mieux en mettre deux : majore le risque de mauvaise utilisation.	
	Raisons d'utilisation du préservatif pour les étudiants (étude de 2017) • 74% l'utilise avant tout pour éviter une grossesses • 70% l'utilise pour se protéger des IST	
Le préservatif féminin	• Tapisse les voies génitales et la vulve (Gaine en polyuréthane) • Pas très « sexy » avec anneau extériorisé (aussi anneau intérieur dans le fond du vagin) • Protège moins des IST que le préservatif masculin • Ne pas utiliser avec un préservatif masculin • Usage unique et coût ++ • Modifie les sensations mais pas le plaisir • IP = 21, soit peu fiable	
La cape et le diaphragme	• Obstrue le canal cervical • Mis en place avant le rapport sexuel • Réutilisable • Utilisation de spermicide recommandée (++) • En remettre si rapport à risque répétés sans retirer le dispositif • Ne pas retirer immédiatement après le rapport • Être à l'aise avec son corps ▲ Efficacité réduite chez les multipares	
	Le diaphragme • Disque souple silicone • 4 à 6h > max 24h • Différentes tailles, défini au préalable avec le gynécologue • IP = 16 en utilisation courante avec du spermicide (peu fiable)	La cape • Dé à coudre en silicone • En place pour 8h • 3 tailles • Peu utilisé en France • IP = 16 pour nullipare à 32 pour multipare
Les spermicides	• Favorise la destruction des spermatozoïdes • En complément des dispositifs barrières ou méthodes naturels • Si utilisation seuls, augmentation du taux échec qui est donc de 30%	

LES CONTRACEPTIFS A LONGUE DUREE D'ACTION	
Généralités	• Regroupe : - Les dispositifs intra utérin (cuivre ou lévonorgestrel) - Implant - Administration IM de progestatif • Durée de 3 mois à 10 ans • Efficacité contraceptive ++ (pas de problème d'observance) • Tous remboursés à 65% par SS Evolution des ventes de DIU et implant • Augmentation dans toutes les tranches d'âges avec une hausse importante chez les femmes âgées de moins de 40 ans • Augmentation de 16 % du DIU lévonorgestrel et implant • Augmentation de 45% du DIU en cuivre
Dispositifs Intra-Utérins	• 1ère contraception de longue durée d'action utilisée dans le monde • 2ème moyen de contraception en France après la pilule • 1ère contraception des femmes de plus de 35 ans • Beaucoup de préjugés liés au risque infectieux • Nécessite un examen gynécologique préalable • 80% du taux de continuation • Différentes tailles • <i>Contrairement aux idées reçues peut être utilisée chez les nullipare et adolescentes</i> Modalités de pose • Pose en début de cycle va diminuer le risque de grossesse • Par un médecin ou une sage-femme • Pas de dépistage IST systématique <u>sauf chez les moins de 25 ans</u> • Après mesure de la cavité utérine • Fils coupés à 2-3 cm • Pas d'écho de contrôle • Information sur les motifs de consultation • Noter la date de retrait ++
	DIU en cuivre • Action inflammatoire de l'endomètre • Action anti-nidation • Altération des spz • Pas de blocage de l'ovulation • Augmentation du flux menstruel • IP = 0,6/0,8 • Durée de 3 à 10 ans
	DIU au levonorgestrel • 3 dosages - Jaydess® 13,5mg pour 3 ans - Mirena® 52 mg pour 5 ans - Kyleena® 19,5 mg pour 5 ans • Action inflammatoire de l'endomètre • Action anti nidation • Action anti gonadotrope • Diminution du flux voir aménorrhée • Même effets que les PO • IP = 0,2/0,2

L'implant	• Bâtonnet de 4 cm de long et 2 mm de diamètre • Action anti-gonadotrope du progestatif (58mg) • IP = 0,05/0,05 (moyen de contraception le plus efficace) • Mêmes indications et CI que les P oraux • Troubles du cycle fréquents • Durée 3 ans Modalités de pose • Posé par un médecin ou une sage femme • Anesthésie locale de la peau • Radio opaque • N'est pas visible • Peu de risque de migration
Idées reçues sur l'implant et le stérilet	• On voit mon implant quand je suis en T shirt. Non il est positionné dans la gouttière entre deux muscles, il est palpable mais non visible. • On sent les fils lors des rapports sexuels. Possible mais pas de réel gêne d'après plusieurs études. • On ne peut pas mettre de stérilet avant d'avoir eu des enfants. Au contraire, bonne efficacité, peu de risques de complications et apparition de stérilet de petite taille. En revanche, il faut prendre en compte le risque infectieux des patientes ayant des partenaires multiples. • Ça rend stérile. Réversible immédiatement. • L'utilisation d'une coupe menstruelle favorise l'expulsion de mon stérilet. Certains cas ont été décrit.
Progestatifs Intra veineux	• IM trimestrielle : 150 mg de progestatifs • IP = 0,3/3 • Hypo oestrogénie relative • Mal toléré: - Aménorrhée (50% des patientes), - Métrorragie (10-15% avec atrophie de l'endomètre). • Augmentation du risque thromboembolique par rapport aux COP • Retour à des cycles ovulatoires différé et arrêt jusqu'à 6 mois • ▲ CI jeune fille car diminution densité osseuse → risque de fracture longtemps après
A retenir	• Efficacité ++ • Pas de problème d'observance • Effets secondaires des progestatifs mais assez bon taux de continuation • DIU nécessite un examen gynécologique préalable

LA CONTRACEPTION D'URGENCE

Généralités

- Contraception qui intervient **après** un rapport mal ou non protégé
- Méthode de rattrapage (**pas d'utilisation de façon régulière** car risque d'échec plus élevé que les contraceptions habituelles)
- Le plus tôt possible ++
- Augmentation du nombre de boîte de contraception d'urgence vendue en France depuis 2000

Deux méthodes en France

- **Contraception hormonale:** 2 pilules « du lendemain »
 - Lévonorgestrel 1,5 mg : **Norlevo®** et génériques
 - Ulipristal acétate 30 mg : **Ella One®**
- **Contraception mécanique:**
 - DIU en cuivre

- 40% des Françaises déclarent ne pas connaître le délai d'efficacité de la contraception d'urgence
- 90% de celles qui pensaient le connaître citent un délai erroné

Circonstances du dernier recours à la contraception d'urgence au cours des 12 mois précédant l'enquête en 2005

	15-19 ans n=75	20-24 ans n=58	25-34 ans n=84	35-54 ans n=47	15-54 ans N=264
Oubli de pilule	20,9	42,3	29,0	12,8	30,1
Problème avec le préservatif	40,0	22,4	29,4	27,7	30,7
Rapport sans contraception	22,3	18,0	23,5	29,8	22,7
Erreur dans les dates	3,3	9,9	4,5	14,9	6,3
Retrait du partenaire trop tard	2,2	6,9	10,3	8,5	6,7
Autre raisons ou raisons inconnues	3,4	0,7	3,2	6,4	3,5

Important :

- Rapport sans contraception est la première cause chez les plus de 35 ans et la 3ème chez les moins de 35ans.
- En lien avec contraceptions utilisées en fonction de l'âge (naturelles pour les plus de 35 ans).

Raisons du recours à le CU

- 20% n'ont pas pensé à la CU (1ère raison)
- Non reconnaissance du risque de grossesse est donc un élément déterminant.

Les différentes contraceptions d'urgence

	Délai d'utilisation après rapport sexuel non ou mal protégé	Modalités d'accès	Prise en charge
Lévonorgestrel (1,5 mg)	72 heures (3 jours) - idéalement le plus tôt possible	Prescription médicale facultative	Gratuite pour les mineures sans prescription. Remboursement à 65 % si prescription.
Ulipristal acétate (30 mg)	120 heures (5 jours) - idéalement le plus tôt possible		
Dispositif intra-utérin au cuivre	120 heures (5 jours) - idéalement le plus tôt possible	Sur prescription d'un médecin ou d'une sage-femme	Remboursement à 60 % sur prescription

LVG

- inhibe ou retarde ovulation

UA

- modérateur sélectif des R à la progestérone
- Inhibe ou retarde l'ovulation

DIU : utilisation moins fréquente car la pose nécessite un spécialiste

▲ Pas d'UA chez les femmes sous pilules.

▲ Utilisation répétée au cours d'un même cycle possible mais pas recommander

▲ Ne pas associer les 2 CU hormonales.

Efficacité	- Pas efficace à 100% - Efficacité diminue avec le délai de prise, chiffres pour lévonorgestrel: - 24h après le rapport : 95% - 24-48h : 85% - 48-72h : 58% - UA : meilleure efficacité en période péri-ovulatoire donc si pas de contraception hormonale à préférer										
Modalités de délivrance	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>Lévonorgestrel (LNG) per os (dose unique de 1,5 mg)</th><th>Ulipristal acétate (UPA) per os (dose unique de 30 mg)</th><th>Dispositifs intra-utérins (DIU) au cuivre</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Modalités d'accès</td><td colspan="2"> → Pharmacie • directement sans prescription médicale (gratuit et anonyme pour les mineures) • après prescription par un médecin ou une sage-femme (remboursement à 65%) → Centres de planification et d'éducation familiale : délivrance anonyme et gratuite pour les mineures et pour les majeures sans couverture sociale → Infirmeries scolaires : délivrance anonyme et gratuite pour les élèves des collèges et lycées (mineures ou majeures) → Services universitaires et interuniversitaires de médecine préventive et de promotion de la santé : délivrance anonyme et gratuite pour les étudiants </td><td> → Nécessité d'une prescription par un médecin ou une sage-femme pour la délivrance et le remboursement à 60 %¹ </td></tr> </tbody> </table>		Lévonorgestrel (LNG) per os (dose unique de 1,5 mg)	Ulipristal acétate (UPA) per os (dose unique de 30 mg)	Dispositifs intra-utérins (DIU) au cuivre	Modalités d'accès	→ Pharmacie • directement sans prescription médicale (gratuit et anonyme pour les mineures) • après prescription par un médecin ou une sage-femme (remboursement à 65%) → Centres de planification et d'éducation familiale : délivrance anonyme et gratuite pour les mineures et pour les majeures sans couverture sociale → Infirmeries scolaires : délivrance anonyme et gratuite pour les élèves des collèges et lycées (mineures ou majeures) → Services universitaires et interuniversitaires de médecine préventive et de promotion de la santé : délivrance anonyme et gratuite pour les étudiants		→ Nécessité d'une prescription par un médecin ou une sage-femme pour la délivrance et le remboursement à 60 %¹	▲ Remboursée pour les majeurs si prescription par médecin ou sage-femme.	
	Lévonorgestrel (LNG) per os (dose unique de 1,5 mg)	Ulipristal acétate (UPA) per os (dose unique de 30 mg)	Dispositifs intra-utérins (DIU) au cuivre								
Modalités d'accès	→ Pharmacie • directement sans prescription médicale (gratuit et anonyme pour les mineures) • après prescription par un médecin ou une sage-femme (remboursement à 65%) → Centres de planification et d'éducation familiale : délivrance anonyme et gratuite pour les mineures et pour les majeures sans couverture sociale → Infirmeries scolaires : délivrance anonyme et gratuite pour les élèves des collèges et lycées (mineures ou majeures) → Services universitaires et interuniversitaires de médecine préventive et de promotion de la santé : délivrance anonyme et gratuite pour les étudiants		→ Nécessité d'une prescription par un médecin ou une sage-femme pour la délivrance et le remboursement à 60 %¹								
Infos complémentaires	- Retard de règles possible Si retard > 7j : faire un test de grossesse - Envisager un dépistage des IST - Envisager et réévaluer la contraception										
A retenir	- Prise unique le plus rapidement possible - La reprendre si vomissement <2h/prise - Eviter l'association contraception hormonal et UA - Faire un test de grossesse en cas de doute										

L'INTERRUPTION VOLONTAIRE DE GROSSESSE	
Définition et contexte de l'IVG	• Autorisée en France depuis 1975 (loi Veil) • Elle est pratiquée à la demande exclusive d'une femme enceinte « qui ne veut pas poursuivre sa grossesse » • Médecin ou sage-femme • Centre de planification, centre de santé ou établissement hospitalier → IVG médicamenteuse jusqu'à la fin de la 7ème semaine de grossesse → IVG chirurgicale jusqu'à la fin de la 12ème semaine de grossesse Evolution du nombre d'IVG (depuis 1990) Absence d'évolution du nombre d'IVG alors que le nombre du recours à la contraception est croissant Evolution du nombre d'IVG chez les jeunes (depuis 1970) Nombre d'IVG stabilisé même si diminution nette des grossesses dans les années 80 Taux de recours à l'IVG par groupes d'âges (entre 1995 et 2015) - 20-30 ans qui ont en principalement recours - Taux comparable entre 1995 et 2015, même si on observe une légère augmentation
Déroulement de l'IVG	<pre> graph TD A[1er Cs INFORMATION] -- "Ø Délai réflexion" --> C[2ème Cs CONSENTEMENT CHOIX DE LA METHODE] B[CS PSYCHOSOCIALE (facultative sauf <18ans)] -- "Délai réflexion 48h" --> C C --> D[< 7 SG IVG MEDICAMENTEUSE] C --> E[CS PRE ANESTHESIE] E --> F[< 12 SG IVG CHIRURGICALE] D --> G[3ème Cs CONTRÔLE J14-J21] F --> G </pre> ▲ <i>Consentement doit être écrit.</i> ▲ <i>2ème consultation = temps d'échange (contraception, dépistage..).</i>
IVG médicamenteuse	• Jusqu'à la 5ème semaine de grossesse peut avoir lieu en ville • Entre la 5ème et la 7ème semaine de grossesse, préférable en établissement de santé • 1. Mifépristone : interrompt la grossesse - Blocage hormonal, favorise ouverture du col et les contractions utérines - Possible saignements +/- importants - Pris devant médecin - Délai de 36 à 48h avant le 2e médicament • 2ème Misoprostol : donne des CU - Augmente les contractions et provoque les contractions - A domicile ou lors d'une consultation - Saignement rapide après la prise (durent généralement une 15aine de jours) - Expulsion dans 4h (60% des cas) à 72h (40%) • Efficacité : 95%

IVG chirurgicale	• Hospitalisation ambulatoire quelques heures • Aspiration du contenu utérin • Au bloc opératoire • Sous anesthésie locale ou générale • Efficacité : 99,7%
Suites de l'IVG	• Débuter une contraception EFFICACE le jour même (pilule ou implant DIU) • Consultation à 14 jours obligatoire pour l'IVG médicamenteuse • Rendez-vous postop à 21 jours pour l'IVG chirurgicale • Surveiller : douleur, saignements importants, fièvre • Proposer un suivi d'accompagnement psychosocial
Cas particulier des mineures	• Possible sans consentement parental • PEC anonyme et gratuite • Délai de 48h avant consentement car consultation psychosocial • Accompagnement obligatoire par une personne majeure • <u>Consentement écrit du représentant légal ou attestation désignant l'adulte l'accompagnant</u>
A retenir	• S'informer rapidement +++ • Possible < 12 semaines de grossesse • Pas de consentement parental pour les mineurs mais 1 adulte accompagnant • Peu de complications • Contrôle post IVG +++

LES METHODES DE CONTRACEPTION NATURELLE	
Généralités	• Abstinence périodique • Connaître la période fertile • <u>Avoir des cycles réguliers +++</u> • Coopération des partenaires • Peut s'associer à d'autres méthodes barrières
Méthode OGINO-KNAUS	• Calcul des cycles • Pouvoir fécondant : - Spermatozoïdes 5j (dans les organes génitaux de la femme) - Ovule 24h • Eviter donc la période de fécondité: 4 jours avant le jour d'ovulation et un jour après • <u>Cycle très régulier obligatoire ++</u>
Méthode BILLINGS	• Observation de la glaire cervicale • Collante en début et fin de cycle • Filante en pré ovulatoire: favorise la remontée des spz dans l'utérus • Période à risque jusqu'à 3 jours après la modification de la glaire • Fort taux d'échec, IP = 24 • Faussée par les saignements et les rapports sexuels, infections vaginales..
Méthode des températures	• Mesure de la température - Phase folliculaire : T = 36,5-37 °C - Ovulation diminue la température - Phase lutéale : Augmentation de la température de 1°C = 37,5°C (progestérone) • <u>T° au 10ème de degré près !!</u> • T° avant le lever à l'heure fixe • Même thermomètre et même mode de prise (orale, vaginal ou rectal) • Faussée par les infections
Méthode du retrait	• 1ère méthode de régulation des naissances avant la contraception • Ejaculation hors des voies génitales • Difficile à contrôler car réflexe • <u>Spz dans le liquide pré jaculatoire !!</u> • Fort taux d'échec IP = 27
Efficacité	• Peu fiables • IP = 20-27 en utilisation courante • Doit faire accepter les risques de grossesse • Pas indiquées chez les jeunes filles: - Irrégularité des cycles - Hyper fertilité - Grand risque de grossesse non désirée
A retenir	• Taux d'échec élevé environ 25% • Contrainte observance +++ • Abstinence consentie par les 2 partenaires • Peu adaptée aux jeunes filles • Risque de grossesse ++

FORMATION D'EDUCATION A LA SEXUALITE	
1. Définition du concept de santé sexuelle	
Définition par OMS	« La santé sexuelle est un état de bien-être physique, émotionnel, mental et sociétal relié à la sexualité. Elle ne saurait être réduite à l'absence de maladies, de dysfonctions ou d'infirmités. La santé sexuelle exige une approche positive et respectueuse de la sexualité et des relations sexuelles, ainsi que la possibilité d'avoir des expériences sexuelles agréables et sécuritaires, sans coercition, ni discrimination et ni violence. Pour réaliser la santé sexuelle et la maintenir, il faut protéger les droits sexuels de chacun ». Définition OMS-2002 OMS 1975 : La santé sexuelle complète la définition de la santé en 1946 : facteur d'épanouissement personnel, relationnel, social ... En janvier 2016, la notion de santé sexuelle et reproductive est inscrite dans le code de la Santé publique.
Quelques chiffres (Salmona 2015)	• Violences conjugales : 123 femmes décèdent chaque année des violences de leur conjoint ou ex conjoints • Violences sexuelles : - 81% concernent des mineurs : 154 000 dont 124 000 sont des filles - La moitié ont lieu avant 11 ans - 96% des agresseurs sont des hommes - 94% des agresseurs sont des personnes de l'entourage
Qu'est ce que l'éducation sexuelle ?	Permet à tout à chacun de choisir une vie affective et sexuelle librement choisie, épanouie, responsable.
Histoire de l'éducation sexuelle	• Commencement à parler du sujet en mai 68 • Circulaire Fontanet 1973 introduit à l'école l'information et l'éducation sexuelle • LOI 1967 : Neuwirth légalise la contraception • LOI 1975 : Veil autorise l'IVG (<12 SA) • Loi 4/072001 : obligation de 3 séances par an dans tous les établissements dès le CP (▲ CELLE A RETENIR ▲) • Constats du rapport IGAS-inspection générale des affaires sociales 2009 : les séances d'Education sexuelle sont partiellement et inégalement appliquées • Rapport Poletti 2011 sur la contraception des mineures (en lien avec le constat d'un taux important des IVG dans cette population) (▲ CELLE A RETENIR ▲)
Rapport Poletti et mesures prises	• Les constats 1. Le tout pilule pour les jeunes Femmes 2. La dérobade contraceptive des jeunes Hommes 3. Le poids des milieux sociaux 4. Le rôle méconnu des professionnels de santé : possibilité de renouvellement d'une ordonnance de contraceptifs par pharmaciens et infirmiers • Retenir 1. L'implant contraceptif, le DIU peuvent être proposés 2. Responsabilité partagée dans le risque grossesse : aborder le sujet 3. Faire connaître les structures-ressource : CEPF 4. Une disposition pour éviter les arrêts intempestifs de contraception pour non renouvellement

Récemment	• Rapport relatif à l'éducation à la sexualité par Haut comité à l'Egalité (HCE) - 06/2016 - Répondre aux attentes des jeunes - Construire une société d'égalité femmes-hommes - « Il est temps de changer de paradigme et de parler d'une sexualité synonyme de plaisir et d'épanouissement personnel » - Le HCE appelle à la mobilisation de la société dans son ensemble = NOUS SOMMES ACTEURS DU CHANGEMENT • Stratégie Nationale de Santé Sexuelle 03/2017 : l'éducation sexuelle s'inscrit dans une mobilisation nationale sur cette thématique - Un programme qui s'inscrit dans la durée - Axe I : importance de l'éducation à la sexualité auprès des jeunes et de la formation en santé sexuelle de tous les professionnels impliqués dans le parcours éducatif - Axe III : 2 priorités sont énoncées pour améliorer la santé reproductive : réduire le nombre de grossesses non désirées, améliorer l'accès au choix de la contraception adaptée - Axe V : promouvoir la recherche dans le domaine de la santé sexuelle, documenter les phénomènes émergents dont la cybersexualité
2. Définition de l'éducation à la sexualité	
Définition du mot éduquer	• Que sous entend Eduquer ? Les 3P - Pourvoir aux besoins - Protéger - Permettre de grandir • La sexualité est un paramètre important de la construction identitaire • Le formateur : accompagner, étayer, baliser • Le formé : développer des compétences, estime/ confiance en soi, capacité de choix, de décision, goût de communication, sens de responsabilité • Pour une autonomie et un épanouissement à 3 niveaux : individuel, relationnel et social
Prérequis du formateur	• Nécessité d'une formation théorique et pratique • Comment ne pas ignorer les dimensions de la sexualité : complexité des affects, du désir, du plaisir sexuel ? • Comment être en capacité d'accompagner les jeunes sur ce chemin de découvertes, d'apprentissages, d'expériences ? • Comment être aidant dans cette recherche d'épanouissement et d'autonomie, dans cette socialisation ? Définition de la sexualité • Souvent réduite à la génialité et à l'aspect « technique », biologique • Être avec soi : un long parcours pour se construire dans son identité sexuée avec d'éventuels traumatismes (cf Salmona 2015) • Être avec l'autre : comment gérer la rencontre, la séduction, les émotions, la relation Circulaire publiée 12/09/2018 - Jean-Michel Blanquer Rappelle que 3 séances par an doivent être consacrées à l'éducation sexuelle dès le CP avec pour objectifs de « favoriser l'estimer de soi », « le respect de soi et d'autrui », « l'acceptation des différences », de concourir à l'égalité filles-garçons, de « développer leur réflexion et esprit critique », de prévenir les violences sexistes et les risques liés à la sexualité ...

L'éducation sexuelle

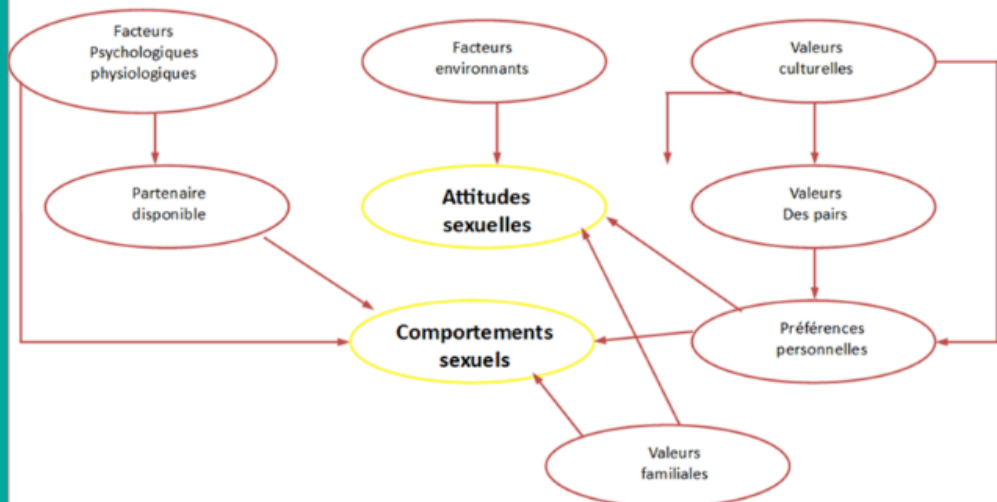
- Une obligation légale : loi du 4/07/2001
 - Une obligation sociale : URGENCE ! **Rappel fait par la circulaire du 12/09/2018**
 - se conçoit à moyen et long terme, à intégrer dans le programme éducatif global
 - Nécessite du **personnel** formé et des **moyens** matériels
 - Se **construit** en fonction de l'âge et du développement psychomoteur des jeunes ciblés sous forme de séquences (de plusieurs séances) ayant un thème, une méthodologie, des objectifs et une progression pédagogique (schéma de Wolpe), une évaluation.
- La théorie guide la pratique et la pratique réinterroge sans cesse la théorie : processus dynamique.**

Démarche de projet en santé publique



3. Comprendre les facteurs déterminant les attitudes et comportements sexuels

Schéma de Frieze (1978), remanié par Tremblay (1992)



Les sexualités adolescentes

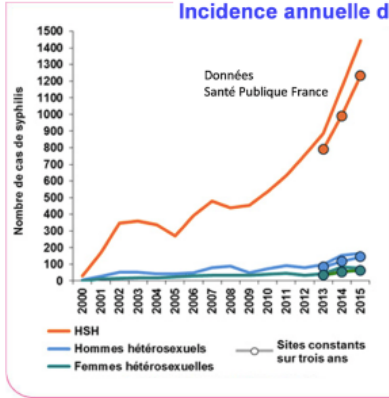
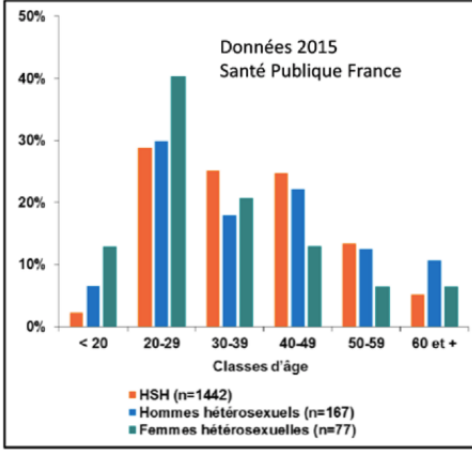
- Sont sous de **multiples influences**
 - Implications **psychologiques**
 - Interférences familiales (idées reçues, miroir de la société ou différentes..), sociales (principes moraux), culturelles (religieux)
 - Valeurs des **pairs** : rassurer les jeunes, partagent la musique ou la tenue vestimentaire. Le partage permet de ne pas se sentir isoler. On observe des groupes de pairs au sein des adolescents.
 - **Références** juridiques, éthiques, voire morales, religieuses
 - Événements **biologiques**
- Il faut aussi prendre en compte aussi les valeurs du partenaire !**

Particularités de ce sujet	• Sujet Tabou et complexe : ne pas chercher à simplifier mais plutôt à l'expliquer • Poids des valeurs culturelles, familiales • Importance des rôles sociaux et sexuels • Obstacles : les idées reçues, les représentations négatives, les stéréotypes... et quelquefois l'insuffisance de formation sur cette thématique des professionnels qui côtoient les jeunes...
Constat de D. Dumas (psychanalyste)	• Un sujet encore tabou • « Une chose dont on ne peut pas parler n'existe qu'à moitié... » • Si les parents n'en parlent jamais, la sexualité est ou moins vécue comme anormale. • Il faut commencer à en parler à 3/4 ans • Tout ce qui n'est pas visible doit être nommé. Ex : le vagin, la fonction des testicules. Connaitre son corps (anatomie et physiologie) est essentiel !
Comprendre la sexualité comme	• Un besoin, un désir, un droit, un espace d'intimité, un moyen de communiquer et aussi <u>un langage d'où la nécessité d'un apprentissage</u> • La sexualité a 2 fonctions : - Reproduction - Plaisir = plaisir de donner, de recevoir : c'est le moteur de ce langage « Si vous voulez bien faire l'amour, apprenez à vous parler » F. DOLTO
Adultes et adolescents	• Adultes ne sont pas toujours présents dans leur rôle d'étayage, d'accompagnement des adolescents (être en transition). <i>Ex : on continue à ne pas parler de sexualité mais les jeunes sont exposés à du porno, échangent des sexto.</i> • Adolescents se « construisent » dans la différence des sexes et des générations d'où l'importance de les aider à comprendre leur propre histoire, de lui donner du sens en la réintégrant dans une histoire familiale, socio-culturelle
4. Spécificité de l'adolescence	
Qui sont les adolescents ?	Le diagramme illustre la spécificité de l'adolescence en montrant divers défis auxquels ils sont confrontés. Au centre se trouve un cercle bleu clair intitulé 'L'ADOLESCENT'. Dix autres cercles de couleurs variées sont connectés à ce centre par des lignes noires. Ces cercles contiennent les termes suivants : 'Conduites à risques: agressivité, fugues, rapports non protégés' (orange), 'Difficultés scolaires' (vert), 'Addictions: alcool, drogue, jeux' (violet), 'Dépression et tentatives de suicide' (bleu), 'Troubles du sommeil' (jaune), 'Orientation scolaire et préparation aux examens' (vert foncé), 'Eveil de la sexualité' (orange clair), 'Difficultés relationnelles avec les parents, les enseignants' (rose), 'Post traumatisme: agression, racket' (violet clair), et 'Anorexie, boulimie' (jaune clair). En bas à gauche du diagramme, la date '12/01/18' est inscrite, et en bas à droite, le chiffre '25'. Jeunes en transition qui se construisent selon les sexes opposés et aussi leur génération (comprendre leur histoire).

Problématiques des adolescents	• Pouvoir se différencier de ses parents • Se reconnaître soi-même, se sentir reconnu : les vêtements ceux dans lesquels on se sent bien et que l'on a choisis, les territoires comme la chambre, la temporalité avec le temps libre, les loisirs • Gérer la relation à l'autre : source de tensions, d'attractions, de confrontations, circulations d'affects, de représentations.. → <i>Long chemin de découvertes</i>
Généralités sur le processus psychologique	• L'adolescent a une vulnérabilité narcissique : important d'aller chercher A réestime de soi • Quête identitaire « Il importe que les parents « survivent » : résister à l'agressivité temporaire.. sans adopter l'une ou l'autre des positions extrêmes, l'acceptation soumise ou le rejet ». Winnicott l'a symbolisé par « Le mur en caoutchouc » • La maturité psychologique : on est adulte quand on a acquis la capacité d'intégrer le manque, l'inachèvement sans être obligé de se bloquer dans des systèmes de défense → <i>Attention lors des interventions à vos mots, mimiques, à ne pas porter de jugement.</i>
6. Cadre juridique de la sexualité des mineurs	
Loi et sexualité des mineurs	• Rapports sexuels entre 2 mineurs : non répréhensibles si consentis • La majorité sexuelle à 15 ans. Ce n'est pas précisé dans la loi ! • Débat actuel : âge en dessous duquel le consentement ne pourra être retenu
Rapport sexuel entre un mineur et un majeur	• Entre < 15 ans et majeur : la minorité < 15 ans est constitutive de l'atteinte sexuelle (délict) même si rapport sexuel consenti (article du Code Pénal). Délai de prescription de 10 ans à la majorité. • Entre > 15 ans et majeur : constitutive d'une atteinte sexuelle même si rapport sexuel consenti quand le majeur est un ascendant ou personne ayant autorité de droit ou de fait, ou abus de confiance (art du code Pénal). <i>Ex: un professeur, un animateur.</i> Toutefois, les parents du mineur peuvent s'y opposer et saisir le Juge des Affaires Familiales, c'est lui qui tranche
Violences sexuelles	• Correspond à un rapport sexuel non consenti, 1 victime et un ou des agresseurs 1. Viol (crime) = tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature que ce soit, commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur par violence, menace, surprise ou contrainte (article Code Pénal). Délai de prescription à 30 ans à partir de la majorité. 2. Agressions sexuelles (pas de pénétrations) par violence, contrainte, menace ou surprise. Délai de prescription de 20 à partir de la majorité (6ans à compter des faits si la victime est majeure).
Autres délits	• La corruption des mineurs (art CP) : EX : participation à des ébats avec majeur ou projection de films à caractère porno. Circonstances aggravantes : <i>pratique en bande organisée ou sur mineur < 15 ans.</i> • Enregistrement ou Transmission de l'image pédopornographique d'un mineur (art CP) mais aussi son acquisition, sa détention et sa diffusion. Circonstances aggravantes : <i>diffusion par réseau de communication électronique.</i> • Fixation, enregistrement ou transmission de l'image ou des paroles privées à caractère sexuel d'une personne prise dans un lieu public ou privé (art CP) • Loi du 7/10/2016 sur le revenge porn

Objectifs de l'éducation sexuelle	• Proposer une approche positive et respectueuse de la sexualité afin d'accompagner la réflexion personnelle • Développer la qualité de la communication, de la relation • Accompagner le choix et la réalisation des projets pour un bien être individuel, relationnel, social • Nécessité d'une formation pour les intervenants : - Attitude (ensemble verbal, non verbal) - Créer la confiance, favorise le dialogue : attitude chaleureuse - S'accompagne d'une sensation d'encouragement à mettre en mots : attitude permissive « tout peut se dire »
Les attitudes de l'éducateur Becker 1964	
Etapas d'apprentissage et d'intégration de la formation	• Niveau 1 - l'inconscient démuni « Je ne connais pas les procédés pour mieux communiquer » « Je ne me rends pas compte que mes modes communication et ceux des autres sont parfois nuisibles » • Niveau 2 - Le conscient démuni « Je prends conscience de mes limites, de mes lacunes, de mon manque de formation » « Je découvre les effets destructeurs des obstacles à la communication » • Niveau 3 - le conscient outillé « Je me forme, j'utilise les outils mais c'est difficile, je ne me sens pas toujours à l'aise » • Niveau 4 - l'inconscient outillé « J'ai intégré les procédés de communication et de pratique d'entretien d'aide »

LA CIBERSEXUALITE	
Généralités	Enquête IFOP, 1021 jeunes de 15 à 24 ans • A 15 ans, 55% des jeunes ont déjà vu un film X (multiplication des écrans à la maison) : - Impression d'une sexualité réduite à la génitalité - Femmes réifiées (= femmes objets du désir masculin) • 1 jeune sur 6 a eu un rapport sexuel avec une personne rencontrée sur internet • Séance de gym, performance physique
	Première expérience de vidéos pornographiques • 2/3 des garçons l'ont vu seuls, la majorité des filles avec quelqu'un • Plus d'un ado sur 2 considère qu'il a vu son 1er film X « trop jeune » • Âge moyen : 14 ans et 5 mois en 2017
	Ressenti des jeunes sur films porno Thèse J.RIED Caen
Le sexting	Etudes prospectives de Strassberg en 2008 et 2013 • 20% des adolescentes ont déjà pratiqué le sexting aux USA • A diminué de 2008 à 2013
Thèse Marion Rousseau	• But d'étudier les facteurs de vulnérabilité pouvant conduire à une pratique de la cybersexualité active pour adapter les actions de prévention • Quelques chiffres: - 97,5% des 15-17 ans ont un smartphone - Prévalence de la sexualité active = 66% - 98,1% utilisent les réseaux sociaux - 5% parlent souvent à des inconnus - 9,3% regardent des films pornos tous les jours ou presque - Ils passent 5h en moyenne par jour sur internet <i>Elle va sûrement intervenir dans cette UE cette année ou l'année pro. Je pense pas qu'il faut retenir les chiffres parce qu'elle en parle pas à l'oral et la diapo dure 20 sec mais au cas où je mets les chiffres.</i>
Ado et culture numérique	• Les nouvelles technologies de communication sur les comportements des jeunes avec l'émergence d'une nouvelle culture, celle des écrans → bouleversement des rapports • « Des relations virtuelles se juxtaposent aux relations réelles un vaste emarché d'identités en quête de validation tout par une rencontre: sur Internet, une fausse rencontre. Rien n'y met notre corps en éveil et en appétit. » « Virtuel, mon amour » Serge Tisseron • « Nous sommes de plus en plus communicants, de moins en moins rencontrants. » « Le pouce et la souris », P. Lardellier • Comment passer de cette communication technique (corps absents) à la communication humaine ?

INFECTIONS SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES (HORS VIH)	
Généralités	On parle d'infections sexuellement transmissibles et non de maladies car on considère u'il y a de façon non rare des infections non/peu symptomatiques
	Un ensemble de maladies hétérogènes - Parfois mortelle : VIH - Parfois potentiellement grave : hépatite B (peut être associé à une cirrhose du foie ou à un cancer hépato cellulaire) - Parfois avec des conséquences fonctionnelles potentielles importantes : Chlamydia chez la femme (peut déboucher sur une stérilité) - Parfois présentes chez tous ceux qui ont une vie sexuelle : infection à Papillomavirus Gonocoque : complications rares Syphilis : pas un réel problème de santé publique <u>sauf en cas d'infection de la femme enceinte (transmissions materno-foetales)</u>
	Expression surtout anale ou génitale Ulcérations : Syphilis (à phase primaire), Herpès Urétrites et écoulements: Gonocoque, Chamydia trachomatis, Mycoplasme genitaliura Rectites : lymphogranulomatose vénérienne (chlamydia) Condylome (verruves génitales) et carcinomes muqueux : <u>ce sont aussi des IST</u>
	Autres IST ont des manifestations non génitales - Infection par le VIH - Hépatite B - Hépatite A
	Quelques traits communs Epidémiologie en hausse Syphilis et gonocoque : chez les HSH* Chlamydia : chez les jeunes filles de moins de 25 ans VIH : chez les HSH Hépatite A : épidémie européenne en cours depuis 1 an Prévention vaccinale possible pour certaines (Hépatite B et A, HPV) Efficacité du préservatif : <u>sauf pour papillomavirus et herpès</u> * HSH: Hommes ayant des relations sexuelles avec les hommes : gays, bisexuels, « hétérosexuels flexibles»..
	IST concernent plusieurs muqueuses - Vagin et gland, anus, bouche - Elles peuvent parfois se transmettre lors des rapports buccaux-génitaux. Ex: Syphilis
Ulcérations	Syphilis  Incidence annuelle de la syphilis Données Santé Publique France — HSH — Hommes hétérosexuels — Femmes hétérosexuelles ○ Sites constants sur trois ans  Données 2015 Santé Publique France ■ HSH (n=1442) ■ Hommes hétérosexuels (n=167) ■ Femmes hétérosexuelles (n=77)

3 phases• **Phase primaire : chancre**

- Lésion indolore de la muqueuse génitale, anale ou buccale
- Guérit tout seul en quelques semaines mais la syphilis elle même peut ne pas être guérie

• **Phase secondaire : expression polymorphe**

- Quelques semaines après le chancre
- Eruptions cutanées diverses
- Rarement grave
- Peu fréquemment : atteinte oculaire ou neurologique

• **Syphilis latente (contrôle de l'infection sans forcément l'éliminer)**• **Phase tertiaire**

- très rare actuellement
- Lésions chroniques vasculaires, osseuses, du SNC
- Plusieurs années après le chancre

Quel est le principal problème posé par la syphilis en santé publique ?

- La Syphilis est rarement grave, le principal problème est **la syphilis congénitale**:
- Par transmission maternofoetale
- Du fait d'une infection latente chez la femme
- **18 à 38% des enfants de mère séropositive pour la syphilis**
- **13,9 à 54% d'entre eux sont mort-nés**
- Révélation possible in utero ou dans la 1ère année de vie

Diagnostic

- Sérologie (prise de sang qui est assez performante)

•

Traitement en 1ère intention

- **Pénicilline G** injectable sous forme retard : **soit une injection unique en phases I et II soit 3 injections en 2 semaines si syphilis latente pus stade plus avancé.**
- Ou éventuellement **doxycycline** per os

Herpès• **Herpes Simplex Virus (HSV-2) dans 80% des cas**• **Primo-infection**

- **Incubation en moyenne 7 jours**
- **50-90% des cas : symptomatique**
- Quand symptomatique: vésicules s'ulcérant, douloureuses (contrairement à la syphilis)

- On reste porteur toute sa vie du HSV, situations de récurrences ou non

• **Récurrence :**

- Prévalence difficile à chiffrer

- **20-50% des cas ?**• **Très rarement grave**

- Situation préoccupante : primo-infection maternelle en fin de grossesse car risque de primo-infection du nouveau né

Transmission de l'herpès génital

- Pendant la primo-infection
- Ou pendant les récurrences
- Ou peut être contagieux même en l'absence de symptômes : excrétion virale

Diagnostic

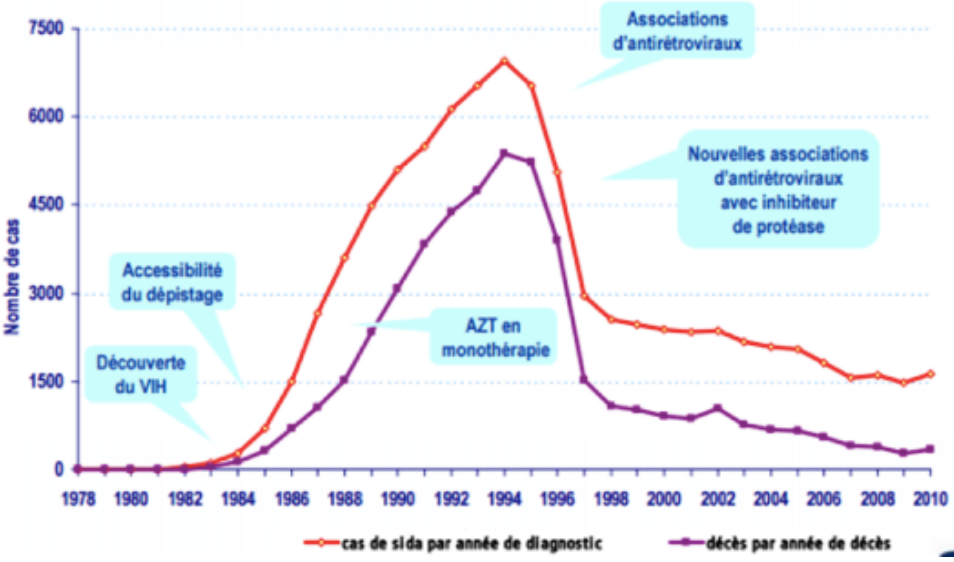
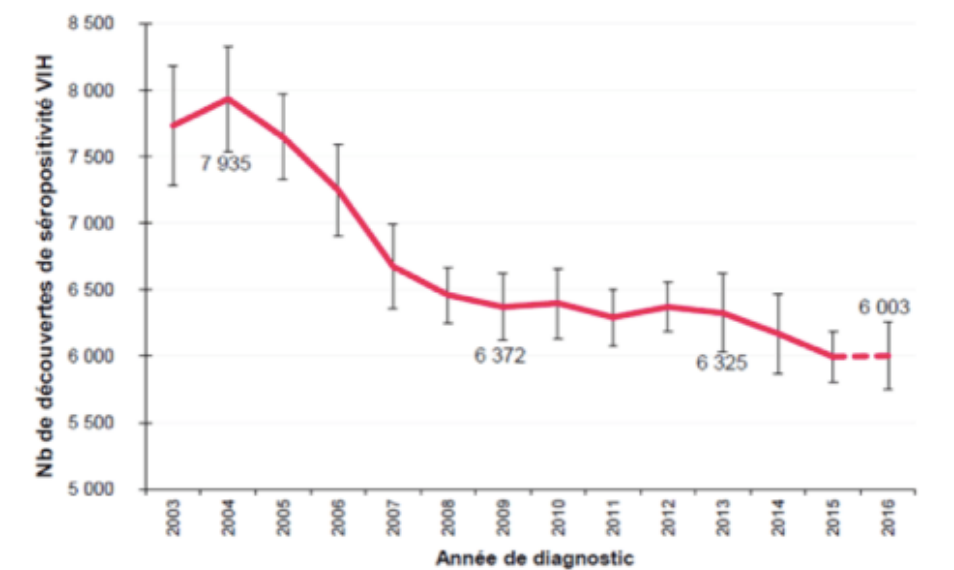
- Clinique en général
- PCR sur ulcération si nécessaire

Traitement

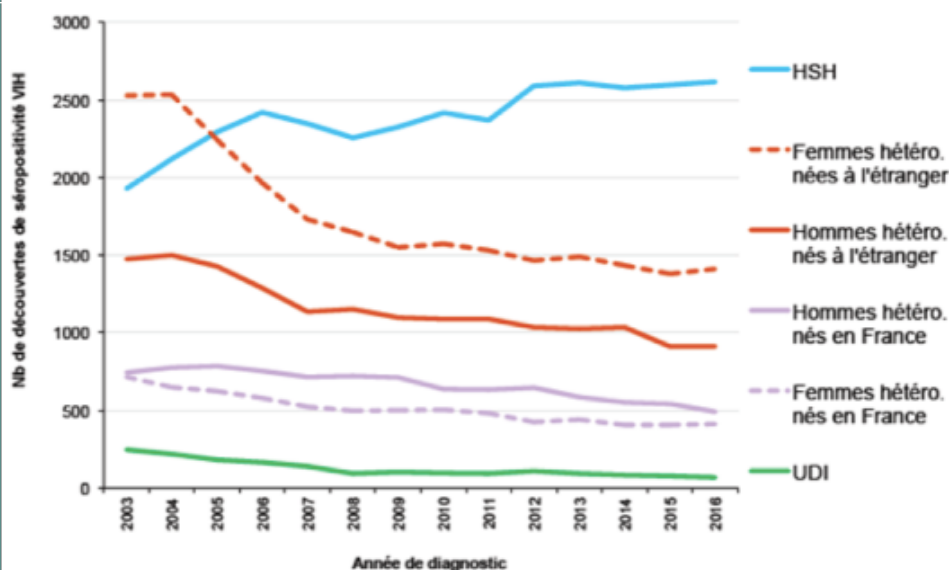
- Antiviraux per os si primo-infection ou poussée bruyante
- Possibilité d'un traitement préventif si poussées fréquentes

Uréthrites et ulcérations	La forme la plus impressionnante est l'urétrite masculine : écoulement plus ou moins purulent au niveau du méat urinaire • Gonocoque (Neisseria gonorrhea) • Chlamydia trachomatis • Différencier cliniquement les 2: difficiles • (Plus rarement : Mycoplasma hominis, Trichomonas vaginalis) Comme la syphilis, les gonococcies : • L'incidence augmente surtout chez les HSH, • Tous les âges peuvent être concernés mais pic à 20-30 ans (20-40 pour la syphilis) Incidence des chlamydioses • Concerne surtout les femmes • Les jeunes filles <25 ans ++ : épidémie augmente Diagnostic Gonocoque ou Chlamydia: • Prélèvement du pus urétral ou des urines pour les hommes • Auto-prélèvement vaginal pour les femmes Traitement • Une injection unique de ceftriaxone pour le gonocoque • Une antibiothérapie per os pour le Chlamydia - Dose unique d'azithromycine; ou 7 jours de doxycycline
A retenir	• IST sont en recrudescence • Tous les âges sont touchés • Certaines touchent plus les HSH, d'autres plus les jeunes filles • Certaines ont une prévention vaccinale • Le préservatif est un outil efficace • Le dépistage et le traitement sont simples

INFECTION PAR LE VIH	
Une infection particulière	• Origine : souches de virus du chimpanzé et du gorille (zoonose). Passées chez l'homme il y a 80 à 100 ans. • Décelée en 1981, caractérisée en 1983. • Une infection mondiale avec une épidémiologie très différente selon les pays • D'énormes progrès depuis 30 ans - Diagnostiques puis thérapeutiques - <u>Mais toujours ni vaccin, ni traitement éradicateur</u>
Physiopathologie de l'infection	• Contamination par voie muqueuse ou IV • Le virus dissémine en 1-3 semaines dans tout l'organisme; la réponse immunitaire est inapte à l'éliminer ou le contrôler • Il entraîne deux phénomènes: - Destruction des lymphocytes TCD4+ : aboutit en 10 ans (médiane) au Syndrome d'immuno-déficience Acquise : SIDA. Décès alors en 2 ans par maladies opportunistes (pneumocystose, toxoplasmose, tuberculose, lymphome) - Inflammation chronique : aboutit à des lésions progressives des vaisseaux, du cerveau, du foie, des reins..
Taux de CD4	Le graphique illustre l'évolution du taux de CD4 et de la charge virale au cours de l'infection par le VIH. L'axe des ordonnées représente le taux de CD4 (de 200 à 1000) et l'axe des abscisses le temps (de 1 à 6 mois à 3 à 15 ans). La courbe de la charge virale (grise) montre une forte augmentation lors de la primo-infection, suivie d'une baisse et d'une stabilisation à un niveau bas. La courbe du taux de CD4 (rouge) montre une baisse initiale, suivie d'une récupération partielle, puis d'une chute progressive au fil du temps. Des lignes horizontales indiquent les seuils de risque pour diverses maladies opportunistes : Candidoses buccales, leucoplasie de la langue... (au-dessus de 200), PNEUMOCYTOSE (à 200), CANDIDOSE ŒSOPHYGIENNE (entre 200 et 100), TOXOPLASMOSE CÉRÉBRALE (entre 100 et 50), CYTOMÉGALOVIRUS (entre 50 et 20), et MYCOBACTÉRIES (en dessous de 20).
Contagiosité du VIH	• Relativement faible (<0,5% pour un rapport sexuel) par rapport à d'autres virus • Virus de l'hépatite B : 50% • Par pénétration : vaginale ou anale • Par fellation : - se faire faire une fellation = aucun risque - Faire une fellation = risque faible et essentiellement si éjaculation dans le bouche • Par partage de matériel d'injection ou de « snif » de substances récréatives • Par transmission de la mère à l'enfant : surtout pendant l'accouchement mais également in utero et pas allaitement Aucun signe ou presque ne permet de dire si quelqu'un est infecté par le VIH ! On peut pas se fier à tel ou tels signes pour ne pas utiliser le préservatif avec un(e) partenaire occasionnel(le).

Epidémiologie mondiale du VIH	• 35 millions de mort depuis le début de l'épidémie, 1 million en 2016 • 36,7 millions de séropositifs en 2016, la moitié l'ignorent • 5-6000 contaminations par jour, la moitié dans les pays à faible niveau de développement → Afrique très touchée
Evolution récente et mondiale	• Nombre de nouvelles infections diminuent depuis la fin des années 90 • Nombre de personnes vivant avec augmente • Les morts liés au SIDA sont en baisse (divisées par deux en 10 ans) • Depuis 10 ans: effort au niveau de l'accès au traitement. On passe de 7.5 millions de patients traités à 18.2 millions en 2016. → Le nombre de patients traités reste toujours la moitié de patient contaminés ! Il reste des efforts à faire.
En France	• 120 - 150 000 séropositifs dont 28 000 qui l'ignorent (estimation) • 600 nouvelles contaminations annuelles • 750 décès de séropositifs en 2010. Beaucoup moins qu'a dans les années 1981-1995. Les associations d'antirétroviraux ont permis de faire chuter le nombre de cas ainsi que la mortalité.  On a découvert 6000 infections en 2016 en France. On peut donc dire qu'il y a eu diminution mais que nous stagnons aussi. 

- Les HSH sont considérés comme la population la plus à risque en France sur le plan des nouvelles infections : les HSH → augmentation des cas.
- Il y a 200 fois plus de risque pour un HSH qu'un homme hétérosexuel.



1996 : des trithérapies efficaces sont disponibles:

- Découverte de nouvelles molécules
- Beaucoup plus simples à prendre
- Beaucoup moins d'effets indésirables

Les traitements antirétroviraux

- **Efficacité très élevée**
 - Pas d'éradication du virus
 - Mais **contrôle presque total de la réplication**
 - Permettant d'éviter toutes les complications (en particulier le SIDA) entraînées par le virus : les personnes restent en bonne santé
 - Et permettant de supprimer la contagiosité
- **Tolérance très élevée**
 - **Traitement souvent en 1 cp par jour**
 - Et avec peu d'effets indésirables

Trithérapie

« Philosophie » du traitement antirétroviral

- **Traiter pour éviter la maladie**
 - SIDA et infection opportunistes
 - Cancers multifactoriels
 - Troubles cardiaques, neurologiques, rénaux ... liés à l'inflammation chronique
 - **Traiter pour baisser la contagiosité**
 - **TasP**: treatment as prevention
 - Une personne dont la charge virale est indétectable n'est pas contagieuse
- **Traitement de toutes les personnes vivant avec le VIH (politique de plusieurs pays)**

Aujourd'hui, une personne vivant avec le VIH sous traitement peut ...

- Avoir une **espérance de vie identique** à celle du reste de la population
 - Faire tous les métiers
 - Avoir la **même vie sexuelle que les autres**
 - Avoir des **enfants** (sous traitement : risque est nul)
 - Voyager
 - Recevoir une greffe
 - Recevoir tous les traitements (chimiothérapie)
- « La maladie n'a pas changé, mais les traitements ont beaucoup changé. » : il est toujours nécessaire de se protéger. ▲

	But avec ces traitements : Mettre fin au SIDA → 2012 - <i>Décider durant une conférence à Washington « Together we Will end AIDS. »</i> → 2016 - <i>Décision d'aller vers une génération sans SIDA par l'ONU SIDA</i>
Quel outils ?	• « Prévention combinée » • Dépistage le plus large possible • Traitement le plus large possible <i>En attendant le vaccin ... qui n'est pas pour demain !!</i>
	Prévention combinée • Préservatifs masculin et féminin : efficaces, à recommander pour tous • Traitement post-exposition • PrEP : traitement pré-exposition • TAsP : treatment as prevention (traiter les personnes infectées les rend absolument non contagieuses et donc participe à la prévention.
	PrEP • Bithérapie antirétrovirale • Proposée en prophylaxie anti-VIH chez les personnes à risque • Prise quotidienne en continu • Ou prise encadrant une prise de risque - Au moins 2h avant - Puis le lendemain et le surlendemain • Très haute efficacité chez l'homme ... <u>chez la femme également mais plus dépendant de l'observance ▲</u> • Pour l'instant non prescrite chez les mineurs - Le préservatif reste le meilleur outils
	Traitement post-exposition • Prendre une trithérapie en urgence en cas de risque : rapport non protégé, préservatif qui craque... • A débuter dans les 48 heures après le risque (et le plus tôt possible), pour 28 jours • Où l'obtenir ? En journée : à l'hôpital en infectiologie, la nuit et le WE aux urgences • Extrêmement efficace, bien toléré et simple à prendre (1 cp/j) • Jamais d'échec constaté
	Le dépistage • Sérologie au laboratoire : fiable à 100% à 6 semaines d'un risque • Test rapide par un soignant ou une association (TROD) : réponse à 15min, fiable à 100% à 12 semaines d'un risque • Autotest sanguin en vente libre sans ordonnance en pharmacie : réponse à 15 min, fiable à 100% à 12 semaine d'un risque • Bientôt : auto test salivaire en vente libre sans ordonnance en pharmacie : réponse à 15min, fiable à 100% à 12 semaines d'un risque.
Situation au niveau régional : Arc Alpin	Décision d'aller vers un dépistage sans SIDA • Prévention combinée : déploiement de moyens pour financer préservatifs, PrEP, Traitement d'urgence.. • Augmentation de l'activité de dépistage • Lutte contre la discrimination entre les PVVIH

SESA - Intro : l'histoire et les différents vaccins | R.Germi

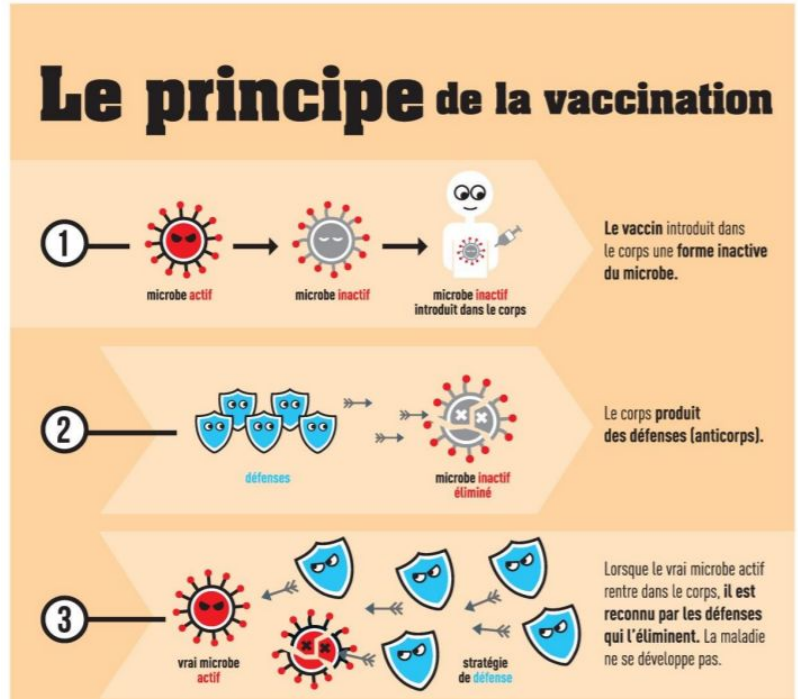
◆ **Principe de la vaccination**

Consiste à reproduire de façon **artificielle** un processus de défense contre un micro-organisme (MO) en stimulant l'**immunité humorale** avec ou sans l'immunité cellulaire, c'est à dire les réponses immunitaires **adaptatives** d'un individu.

Vaccination anti-infectieuse : introduire dans un individu une préparation **antigénique** dérivée de l'agent infectieux ou similaire à l'agent infectieux de manière à **lui faire produire une réponse immunitaire capable de la protéger**.

Les réponses immunitaires ainsi exercées seront très efficaces et performantes lorsque l'individu rencontre le véritable agent pathogène.

Cette efficacité des défenses prévient donc l'infection ou/et l'apparition de symptômes ou des complications.



L'application de la vaccination anti-infectieuse à une population ou à un groupe = moyen de prévention très utile en santé publique **pour l'individu** lui même, mais aussi **pour la population** puisqu'en limitant l'infection on limite la transmission et la propagation de l'agent infectieux.

◆ **Histoire**

→ Première **vaccination** : **Edward Jenner 1796 (médecin anglais)**

A remarqué que les éleveurs de bovins étaient épargnés de la **variole** humaine. Inoculation de matériel provenant de pustule provoquée par la vaccine (**poxvirus** des vaches) = protection contre la variole.

Hypothèse confirmée par la vaccination de James Phipps → de là que provient le terme "vaccination"

→ Première **atténuation** : **Pasteur 1885**

Joseph Meister mordu par un chien → Traitement anti-rabique en post-exposition d'une souche atténuée au laboratoire

Ce traitement a déjà été testé sur des chiens : inoculation souche atténuée du virus de la rage cultivée sur moelle de lapin.

= ère de la vaccination qui débute

Eradication de la variole en 1977 grâce à une campagne de 10 ans dirigée par **l'OMS**.

De nombreux vaccins ont vu le jour à la fin du 19e et début 20e

Surtout **vaccins anti-bactériens entiers tués**, **vivants** ou même à **anatoxine**, plus tard →

Dates	Vaccins	Découvreurs
1892	Vaccin anticholérique	Haffkin
1896	Vaccin tué antityphoïdique	Wright
1900-1921	BCG	Calmette et Guérin
1923	Vaccin anti-coquelucheux	Madsen
1923	Anatoxine diphtérique	Ramon / Gleeny
1927	Anatoxine tétanique	Ramon / Zoeller

Dates	Vaccins	Découvreur
1937	Vaccin grippal inactivé	Salk
1937	Vaccin anti-amaril	Theiler
1949(-54)	MISE AU POINT DE LA CULTURE DES VIRUS (polio)	
1955	Vaccin inactivé anti-polio	Salk
1957	Vaccin oral anti-polio	Sabin
1960	Vaccin atténué contre la rougeole	Enders
Années 60	Vaccin contre la rubéole, les oreillons	
Années 70	Vaccins contre la varicelle, l'hépatite B	

→ Puis au 20e siècle, les **vaccins anti-viraux** :
L'essor de ces vaccins arrive seulement dans la 2e partie du 20e siècle, à partir de la mise au point de la **culture** sur des **cellules eucaryotes** qui vont permettre de cultiver les virus

Les **vaccins antibactériens polysaccharidiques** (1970-80) ↓

- 1980 *Haemophilus influenzae* type b
- Années 90 Méningocoque
- Pneumocoque

Autres vaccins :

- 1992 Encéphalite japonaise
- 1995 Varicelle, hépatite A
- 1998 Rotavirus
- 2005 Zona
- 2006-7 Papillomavirus

Epidémiologie des maladies pour lesquelles il existe une vaccination, avant l'introduction de la vaccination :

Morbidité et mortalité annuelles aux États-Unis avant l'introduction d'une vaccination spécifique

Maladie	Cas cliniques	Séquelles	Décès
Rougeole	900 000	300	200-400
Coqueluche	600 000	40	200-300
Rubéole	300 000	750	10-15
Oreillons	75 000	5	3-5
Hépatite B	25 000	7 000	1 000-1 500
Poliomyélite	14 000	4 500	100-400
<i>Haemophilus b</i>	5 000	1 500	300-600

Permet de rappeler l'importance du nombre de cas, séquelles et décès liées à ces maladies avant l'introduction des vaccins.

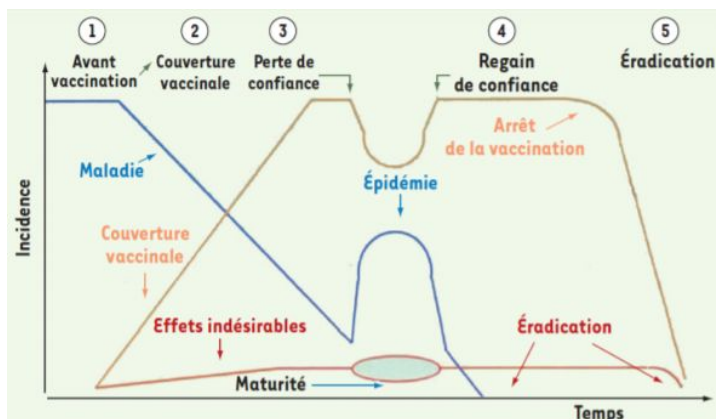
Impact de la vaccination aux USA (CSC, 1999)

Régression du nombre de cas entre la période l'incidence maximale et après l'introduction des vaccins.

Pour la plupart le % de diminution est au delà de 99%.

Difficile de comprendre la **méfiance** de la population à l'égard des vaccins. Cela peut être expliqué par le schéma du cycle de la confiance :

Maladie	Incid. max. (année)	N en 1999 %	Diminution
Diphtérie	206'939 (1921)	1	99.9
Coqueluche	265'269 (1934)	7288	97.2
Tétanos	1'314 (1922-1926)	40	96.9
Poliomyélite	21'269 (1952)	0	100
Rougeole	894'134 (1941)	100	99.9
Oreillons	152'209 (1968)	387	99.7
Rubéole	57'686 (1969)	267	99.5
Rubéole cong.	20'000 (1964-1965)	9	99.9
<i>H. influenzae</i>	20'000 (<1987)	261	98.7
Hépatite B	21'102 (1990)	7694	63.5



→ Le cycle de la confiance en la vaccination

Lorsque la maladie est présente et tue des gens :
vaccination plébiscité

Grande époque de Pasteur, les gens qui viennent des États-Unis pour se faire vacciner contre la rage.
= niveau de confiance élevé même si les EI pourraient être importants.

Puis la maladie est **éliminée** dans la zone concernée.

De quelques **EI graves** ⇒ **polémiques** sur la vaccination

La **confiance** de la population en la vaccination et le **nombre de personnes vaccinées diminue**.

L'hôte du MO pathogène est à nouveau disponible et le MO **se remet à circuler** dans la zone. Les épidémies réapparaissent (rougeole en 2009)

Regain de confiance en la vaccination.

L'élimination n'aboutit à **l'éradication** que si la vaccination est **maintenue même en l'absence** de la maladie.

Tant qu'il existe une **circulation** quelque part dans le monde, la pression vaccinale **doit être maintenue** pour éviter la réintroduction de la maladie à partir des zones où la maladie n'est pas éliminée.

Les objectifs de la vaccination (Europe) :

Beaucoup des objectifs n'ont **pas** été atteints.

- **Eradication** : Elimination **mondiale** → plus de prophylaxie nécessaire
- **Élimination** : liée à une **zone géographique** → maintien de la prophylaxie = éviter la réimplantation à partir d'autres zones
- **Contrôle** : réduction proche de l'élimination → maintien de la prophylaxie

Objectifs de maîtrise des maladies évitables par vaccination pour la Région européenne de l'OMS revus en 2005

Maladie	Objectif	Echéance
Poliomyélite	Élimination	2000
Tétanos néonatal	Élimination	2005
Coqueluche	Réduction de l'incidence à moins de 1 cas/100 000 habitants	2010
Diphtérie	Réduction de l'incidence à moins de 0,1 cas/100 000 habitants	2010
<i>Haemophilus influenzae</i> type b (infections invasives)	Réduction de l'incidence à moins de 1 cas/100 000 habitants	2010
Hépatite B	Réduction de l'incidence des nouveaux porteurs chroniques de 80 %	2010
Oreillons	Réduction de l'incidence à moins de 1 cas/100 000 habitants	2010
Rougeole	Élimination de la rougeole endémique	2010
Rubéole	Élimination de la rubéole endémique et réduction de l'incidence des infections rubéoleuses congénitales à moins de 1 cas/100 000 naissances vivantes	2010

Les objectifs de la vaccination (monde) :

En 2016 les objectifs n'ont **pas** été atteints non plus.

- **Diphtérie, tétanos et coqueluche**: retard pour **65 pays** pour l'objectif 90% de la population vaccinée
- En retard de 15% pour le 0 mortalité **rougeole** dans au moins **4 régions**
- **Rubéole** éliminée dans **1 seule** des 2 région prévues
- **21 pays** de retard pour l'élimination du **tétanos maternel et néonatal**
- **Polio** toujours **pas éradiquée**.



♦ Les différents types de vaccins

Type de vaccin	Caractéristiques	Exemples
Vivant atténué	Le micro-organisme est atténué, il ne cause pas la maladie Il se réplique Il induit une réponse immune	Rougeole, oreillons, rubéole BCG Polio (oral) Fièvre jaune Varicelle
Entier inactivé <i>que peu utilisés</i> → E/ ++	Le micro-organisme est inactivé Il ne peut pas se répliquer Il induit une réponse immune	Coqueluche (1ère génération) Choléra (1ère génération) Fièvre typhoïde (1ère génération)
Sous-unité / fractions	Composants du micro-organisme (protéines, polysaccharides, etc.).	HiB, coqueluche (2ème gén.), pneumocoques, méningocoques, grippe
	Protéines du micro-organisme produites par génie génétique	Hépatite B, papillomavirus
Antitoxines	Toxines sécrétés par les bactéries et détoxifiées = anatoxines	Diphtérie, tétanos

a) Les vaccins vivants

Presque tous des vaccins antiviraux (sauf contre la **tuberculose : bactérien**)

⇒ **BCG Rougeole, oreillons, rubéole, Fièvre jaune, Varicelle, Polio buvable** ⇐

Le MO est atténué de façon à ne **pas causer** la maladie clinique mais qu'il se **réplique** néanmoins suffisamment pour **induire** une réponse immune.

Les souches atténuées utilisées pour fabriquer les vaccins vivants peuvent être :

- des **souches naturelles** (spontanément avirulentes)
Ex : Virus bovin de la vaccine (variole éradiquée : ce vaccin n'est plus utilisé)
- des **souches vivantes atténuées** (mutées)
 - **mutations au hasard** de la culture : Procédé long et aléatoire
Ex : BCG (Bacille de Calmette et Guérin). Souche bovine Mycobacterium tuberculosis cultivée in vitro pendant 13 ans. Le BCG a perdu sa virulence et conserve des effets protecteurs contre la tuberculose
 - **Génie Génétique** : Mutagénèse dirigée / gènes de pathogénicité
Pas encore utilisés en médecine humaine

AVANTAGES	INCONVÉNIENTS
• Plus proche de l'immunisation naturelle (ils l'imitent) • Immunité humorale et cellulaire • Protection rapide après une seule dose habituellement • Longue durée d'efficacité	• Contre-indiqué chez les patients immunodéprimés (par impossible qu'en l'absence de réponse immunitaire adéquate le virus puisse se répliquer massivement) et la femme enceinte (passage transplacentaire pas exclu) • Conservation au froid et ½ vie limitée (vivant)

ROR : 2nd dose qui n'est pas un rappel mais un **rattrapage** : pour immuniser les patients qui n'auraient pas répondu à la première dose.

Du fait du faible nombre de dose administrée : **pas conseillé de vacciner un enfant avant 12 mois** pour qui la réponse au vaccin peut n'être que **partielle**.

En cas d'**épidémie**, un enfant ne peut recevoir un vaccin vivant **qu'à partir de 6 mois**. Dans ce cas il devra recevoir les 2 doses supplémentaires prévues au calendrier vaccinal.

b) Les vaccins inertes

Vaccins **entiers** tués ou inactivés : suspension de virus ou bactérie inactivé (tué)

Ex : Polio (injectable)

Fractions **antigéniques** ou sous-unités vaccinales : amélioration des techniques et des connaissances sur les agents pathogènes

• **Antigènes purifiés** à partir de l'agent pathogène = AG protéiques ou des sucres qui composent la capsule, paroi ou enveloppe des MO :

- Ag Capsulaires, *ex : Pneumocoque ou Méningocoque*
- Particules virales fractionnées et purifiées, *ex : Vaccin contre la grippe*
- Toxines bactériennes détoxifiées = anatoxines, *ex : Anatoxines tétaniques, diphtériques*

Cette approche permet de limiter la part de protéines non nécessaire dans un vaccin et peut **limiter le nombre de réactions indésirables**.

• **Protéines** produites par **techniques de synthèse ou génie génétique**

Ex : vaccin anti-VHB, anti-HPV (expression d'un AG dans des cellules de mammifère ou de levures)

Vaccins inactivés entier ou sous-unités :

Principe de l'**inactivation**, par exposition de l'agent pathogène à

- des **agents physiques** : chaleur, rayonnements ultraviolets
- des **agents chimiques** : formol, bêta-propiolactone, éthylène imine → **traces possibles** : ces agents chimiques sont éliminés lors de la purification de l'agent pathogène mais peuvent se retrouver en traces infinitésimales dans les préparations. Il faut le préciser dans la notice (**législation**)

Ces traitements entraînent une **perte totale d'infectivité sans dénaturer le pouvoir immunogène**.

Efficacité < vaccin vivant

Quantités importantes de MO ou d'AG nécessaires : il ne se réplique pas

La masse antigénique doit être d'autant plus importante que la sous unité immunisante est petite. Ceci explique qu'il est parfois nécessaire d'utiliser des **adjuvants** pour **booster la réponse immune**.

- Cas pour la **diphtérie** et le **tétanos** = on souhaite une protection de longue durée : on met des **adjuvants**
- Pour la **grippe** (refait chaque année) : **pas** d'adjuvant

AVANTAGES	INCONVÉNIENTS
• Utilisable chez la femme enceinte et l'immunodéprimé (ne se répliquent pas) • Bonne conservation et ½ vie satisfaisante	• Immunité surtout humorale donc moins bonne • Primovaccination = plusieurs doses car efficacité plus faible • Faible durée de protection : rappels • Procédés de fabrication

SESA - Vaccination : efficacité, politique vaccinale | O.Epaulard

♦ À propos de l'efficacité de quelques vaccins

Généralités :

- L'efficacité des vaccins est **hétérogène**
- Certains ont une **efficacité très élevée** : **Tétanos, diphtérie, hépatite A, hépatite B, rougeole...**
- Certains ont une **efficacité très intéressante mais moindre** : **Coqueluche** (protection moins durable), **pneumocoque** (protection contre les principaux sérotypes, mais le vaccin ne contient pas pas tous les sérotypes), **grippe** (efficacité plus ou moins élevée selon les années, parfois **faible <20%** → *dépend de la concordance entre souches vaccinales et souches circulantes pendant l'épidémie*)

⇒ Tous les vaccins recommandés en France ont une **efficacité suffisante** pour motiver leur utilisation. Ce d'autant que les effets indésirables notables sont rarissimes

► **Poliomyélite**

Une infection virale liée à la contamination des eaux et aliments par des déjections humaines.

Asymptomatique dans 90% des cas, et des symptômes **digestifs** dans 9%. Un tableau **neurologique** dans 1% des cas :

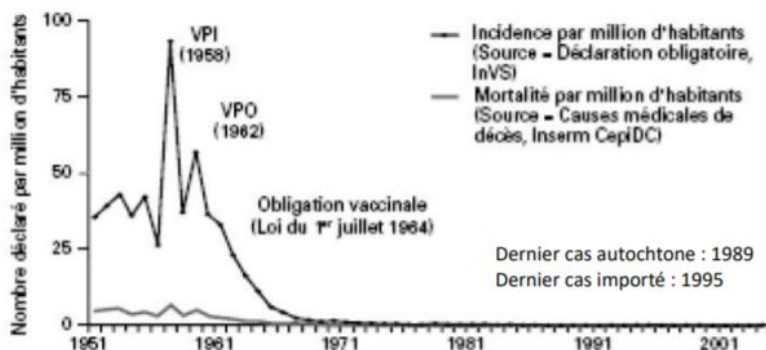
- Par atteinte de la corne antérieure de la moelle épinière
- Responsable en aigu de paralysie (dont parfois les muscles respiratoires)
- Responsable ensuite de séquelles motrices

Séquelles déjà représentées il y a 34 siècles, poliomyélite : présente chez Homo sapiens depuis des millénaires

→ **atteinte des muscles respiratoires** : quand il n'y avait pas de vaccin, la paralysie respiratoire était crainte ++ : respiration par poumon d'acier lors d'une épidémie de poliomyélite, années 50

→ **séquelles motrices aux membres inférieurs** : qui peuvent **définitivement** empêcher les sujets de **marcher** après une atteinte dans l'enfance

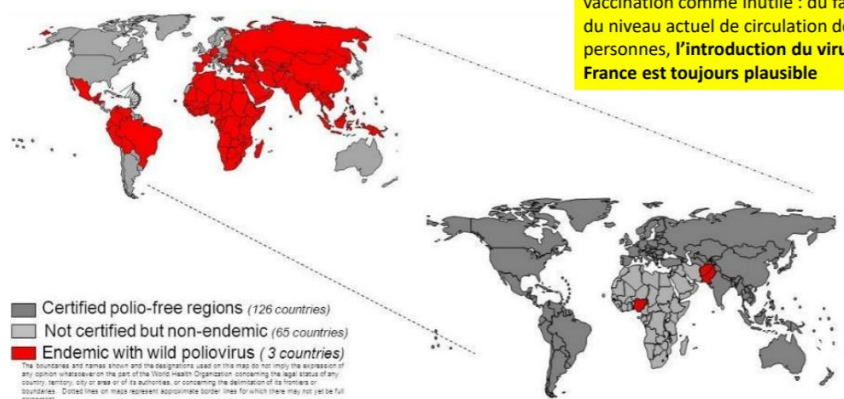
Mais on a un **vaccin très efficace**, la plupart des pays se sont dotés d'une politique vaccinale intense, et ont réussi à éradiquer la polio.



→ Poliomyélite neurologique : épidémiologie française avant et après l'introduction des vaccins

La poliomyélite dans le monde, 1988-2014 → l'éradication est en voie... mais pas terminée

→ *pour les années 70 : éradication mondiale pour la variole mais pas encore pour la polio, quelques pays restent encore*



La persistance de foyers épidémiques ne permet pas de considérer la vaccination comme inutile : du fait du niveau actuel de circulation des personnes, l'introduction du virus en France est toujours plausible

► Diphtérie

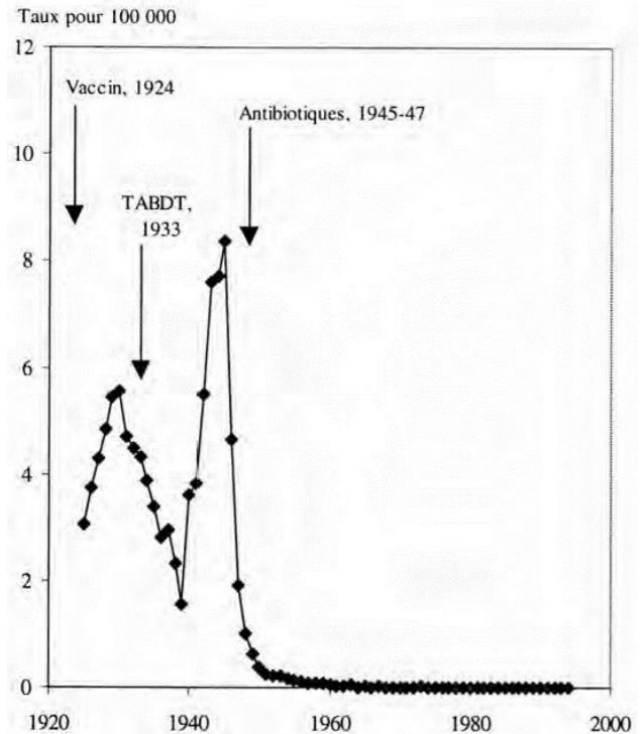
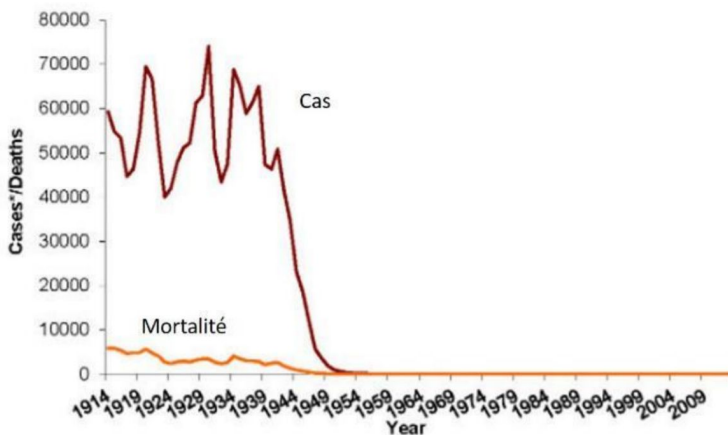
Maladie très **contagieuse**, gravité liée à plusieurs éléments :

- l'**angine à fausse membrane** (*croup*), à l'origine d'asphyxie
- des syndromes retardés **neurologiques et cardiaques** liés à des **toxines** (virulence liée ++ prod toxines)

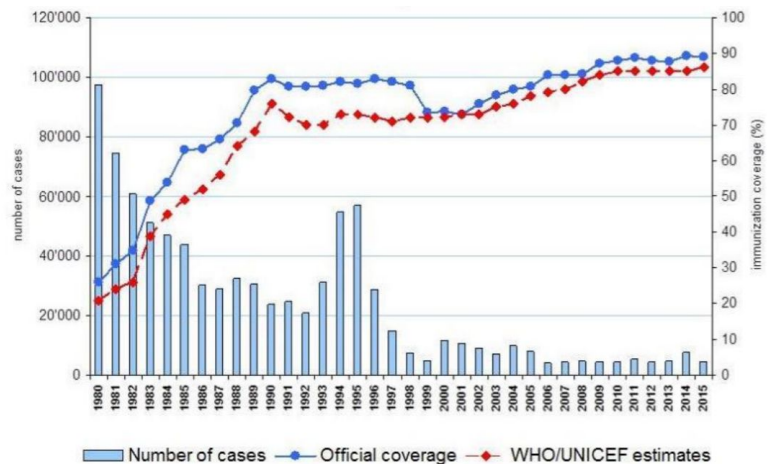
Mortalité par diphtérie en France →
La dernière épidémie, survenue à la fin de la 2ème guerre mondiale, a été jugulée par plusieurs actions, au 1er rang desquelles le vaccin et autres mesures d'hygiène
⇒ on a fait disparaître presque complètement la diphtérie en France

TABDT : vaccin typhoïde, diphtérie et tétanos

Cas de diphtérie et décès, Angleterre et Pays de Galles, 1914-2013 le vaccin a été introduit en 1940 : à partir de ce moment, l'infection a été complètement maîtrisée ↘



Cas de diphtérie et couverture vaccinale (3 injections) dans le monde :



Il y a longtemps eu une **sous-vaccination** dans les pays en voie de développement.

Mais effort ++ par l'ONU, l'énorme effort au niveau mondial aboutit à une haute couverture vaccinale (**90% des enfants dans le monde**), et à une diminution des cas. Mis à part l'eau potable, aucune autre mesure de santé publique qui dépasse la vaccination.

La diphtérie en France depuis 2005, grâce à la haute couverture vaccinale, les cas sont très rares :

- **Cas liés à la souche bactérienne historique**
 - Environ 2 cas par an
 - Presque tous à Mayotte ou importés
- **Cas liés à une souche bactérienne émergente**
 - Origine animale
 - 2 à 4 cas par an

→ Sujets en général **non vaccinés**, ou dont la dernière vaccination remonte à plus de 30 ans

Mais reste une maladie infectieuse jamais très loin de l'homme : des cas de diphtérie sont **toujours signalés en Europe chez des enfants** : en Espagne, un enfant de 6 ans, non vacciné (2015), en Belgique (2016), en Italie (2016)...

► Coqueluche

- Maladie généralement bénigne chez l'adulte (quoique des complications soient décrites chez le sujet âgé ou les sujets avec des difficultés respiratoires ou pulmonaires)
- Maladie potentiellement grave chez le **nourrisson** : risque asphyxique lors des quintes

- 15-30% d'hospitalisation en soins intensifs
- **1 des premières cause de mortalité du nourrisson d'origine infectieuse**

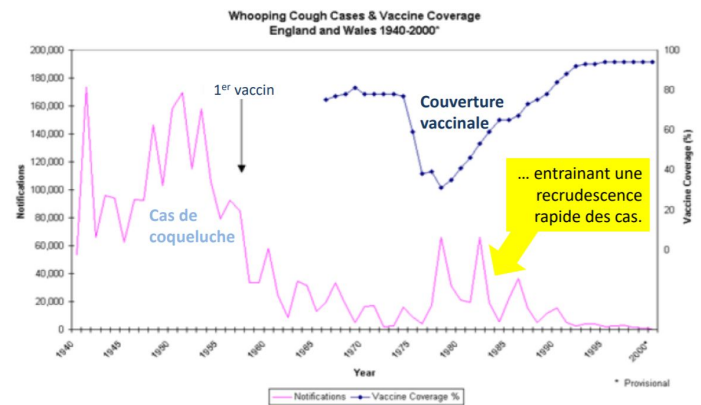
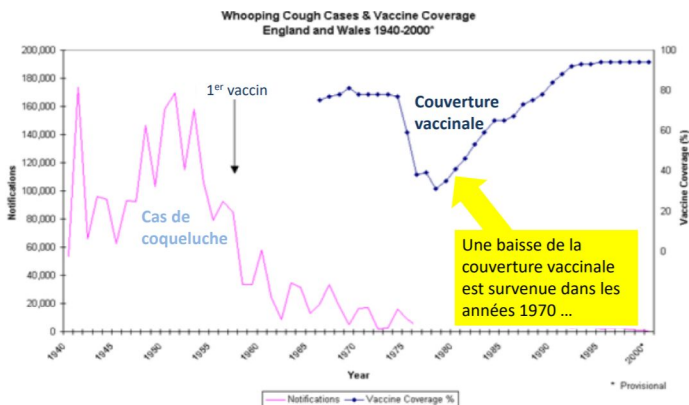
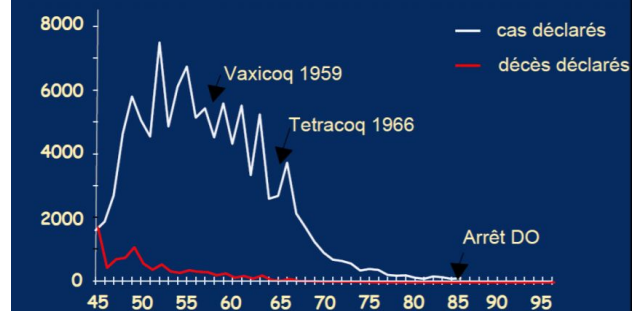
⇒ **Stratégie du cocooning** : ne **pas** vacciner **que** les nourrissons, mais également les personnes de leur **entourage** qui pourraient leur transmettre (fratrie, parents ...)

Recommandation de vaccination de toute la population Française : a diminué ++ le nombre de décès et de cas

Mais maladie infectieuse, jamais loin de l'homme → ne jamais baisser la garde !

→ Couverture vaccinale et cas de coqueluche : l'expérience au Royaume-Uni :

Impact de la vaccination sur l'épidémiologie de la coqueluche en France (1945 – 1986)

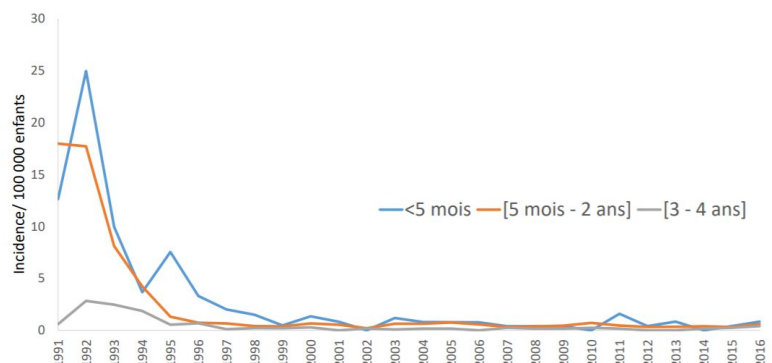


Recrudescence des cas : surtout pédiatriques

Autre grand succès de la vaccination : **méningite à *H.influenza* de type B**

Infections invasives à *Haemophilus influenza* chez les enfants < 5 ans : une quasi-disparition depuis l'introduction de la vaccination :

Depuis la vaccination systématique des nourrissons à partir de 2-3 mois



La disparition presque complète (**poliomyélite**, **diphtérie**) ou la raréfaction (**coqueluche**, **infection à *Haemophilus influenza***) de plusieurs des infections prévenues par le **vaccin hexavalent** ne doit pas inciter à **diminuer** la couverture vaccinale.

⇒ C'est parce que la **couverture vaccinale** reste **haute** que ces maladies restent **exceptionnelles**

► Rougeole

- Une **réputation** indue de maladie toujours bénigne, la plupart des cas de l'enfant se déroulent sans complications
- Celles-ci peuvent cependant survenir :
 - **Otite** (8%)
 - **Pneumonie** (5%) (mortalité : 5-30%)
 - **Encéphalite aiguë** (0,1%) (mortalité : 10%)
 - **Panencéphalite sclérosante subaiguë** (1/600 à 1/5000) (**mortalité : 100%**) : troubles neuro d'aggravations + ou - rapides quelques années après la rougeole

La rougeole dans le monde :

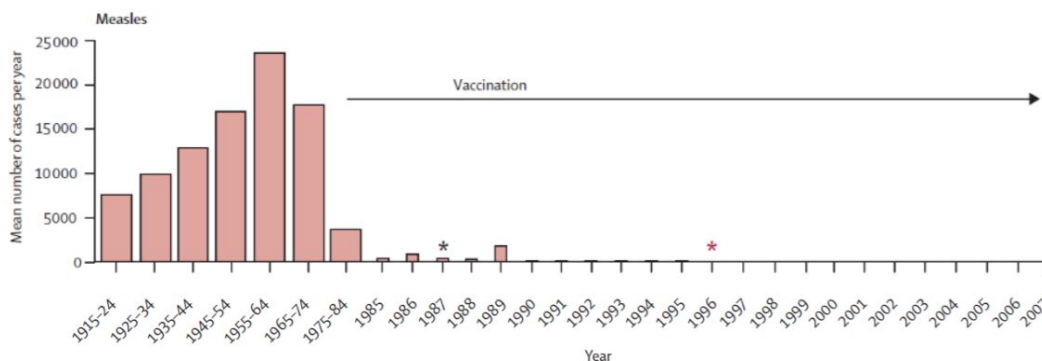
Une des causes importantes de **décès** du **jeune enfant**, et donc l'objet d'un **plan majeur de vaccination par l'OMS**

- En 2016, on a recensé 89 780 décès par rougeole dans le monde – C'est la première fois que ce nombre est inférieur à 100 000 par an
- entre 2000 et 2016, grâce à la vaccination antirougeoleuse, les décès par rougeole dans le monde ont **chuté de 84%**. On a réussi à augmenter la couverture vaccinale des enfants dans cette période.
- En 2016, environ 85% des enfants dans le monde (contre 72% en 2000) ont reçu une dose de vaccin antirougeoleux avant l'âge de un an
- Entre 2000 et 2016, on estime que la vaccination antirougeoleuse a **évitée 20,4 millions de décès**

Une estimation est faite en France pour mesurer l'impact de la vaccination → chaque année, le vaccin anti-rougeole évite des complications en France :

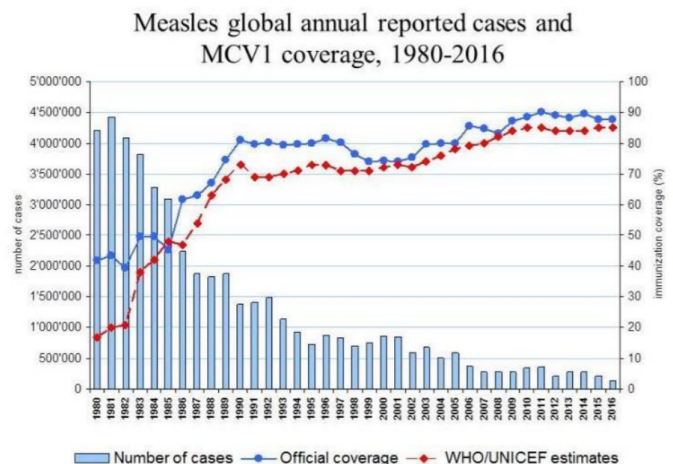
- 40 000 otites
- 17 000 pneumonies
- 500 encéphalites aiguës
- et 140 cas avec séquelles neurologiques
- 5 PESS
- 330 décès

Un exemple d'effet **rapide** de la vaccination : l'incidence de la rougeole en Finlande :



Couverture vaccinale mondiale de la rougeole et incidence :

vaccination de près de 90% des enfants : diminution spectaculaire du nombre de cas



Une conséquence de la couverture vaccinale insuffisante en France : l'épidémie actuelle de rougeole :

Défiance de la population envers le vaccin qui ne repose sur rien de rationnel.

Grosse épidémie de **25 000 cas en France en 2010-2011**, et qu'on observe toujours actuellement quelques petites épidémies qui apparaissent. Garder une couverture vaccinale élevée !!

vaccin ROR = obligatoire pour tous les nourrissons à partir de 2018.

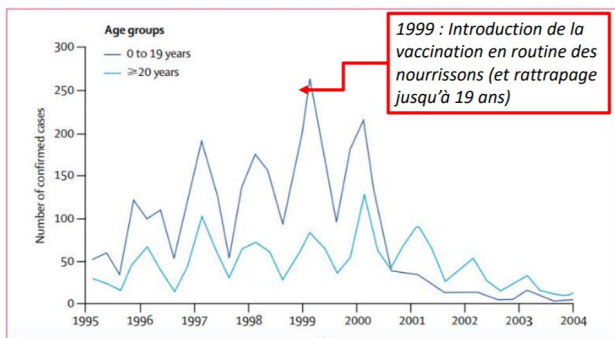
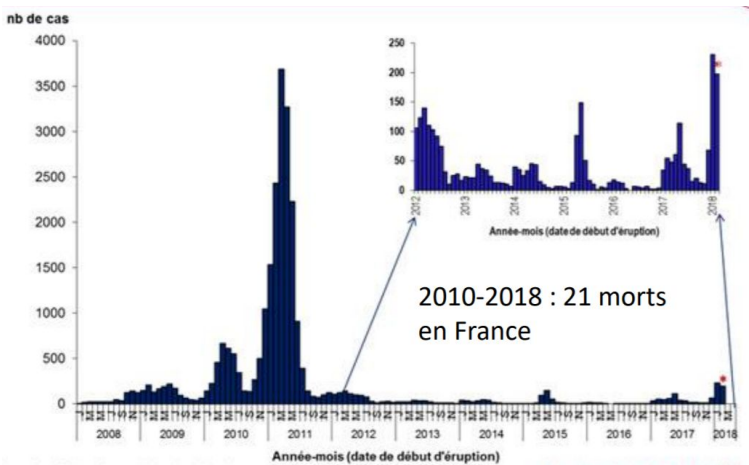
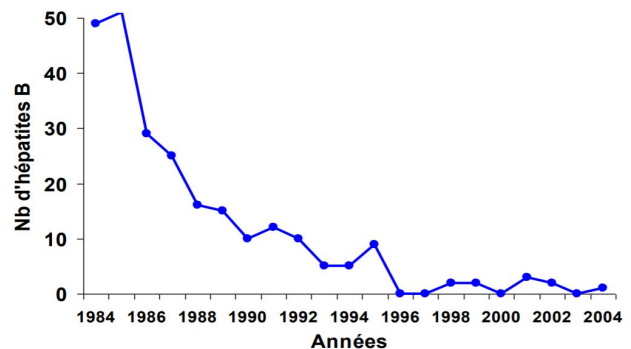


Figure: Cases of laboratory-confirmed meningococcal serogroup C disease by age group and quarter, 1995-2004

D'autres exemples...

La méningite (et autres infections invasives) à méningocoque C en Angleterre :



Autre exemple du **succès** de la vaccination : **Hépatite B** → Vaccination Hépatite B **obligatoire chez tous les soignants** en France

Impact de la vaccination nombre d'hépatites B professionnelles :

Comme l'Hépatite B peut considérer la plupart des personnes de la population générale → vaccination obligatoire pour les **nourrissons** aussi depuis 2018, on a pu éviter beaucoup de cas d'hépatites aiguës, chroniques et fulminantes.

Estimation de l'impact de la vaccination des adolescents de 11-16 ans entre 1994 et 2007

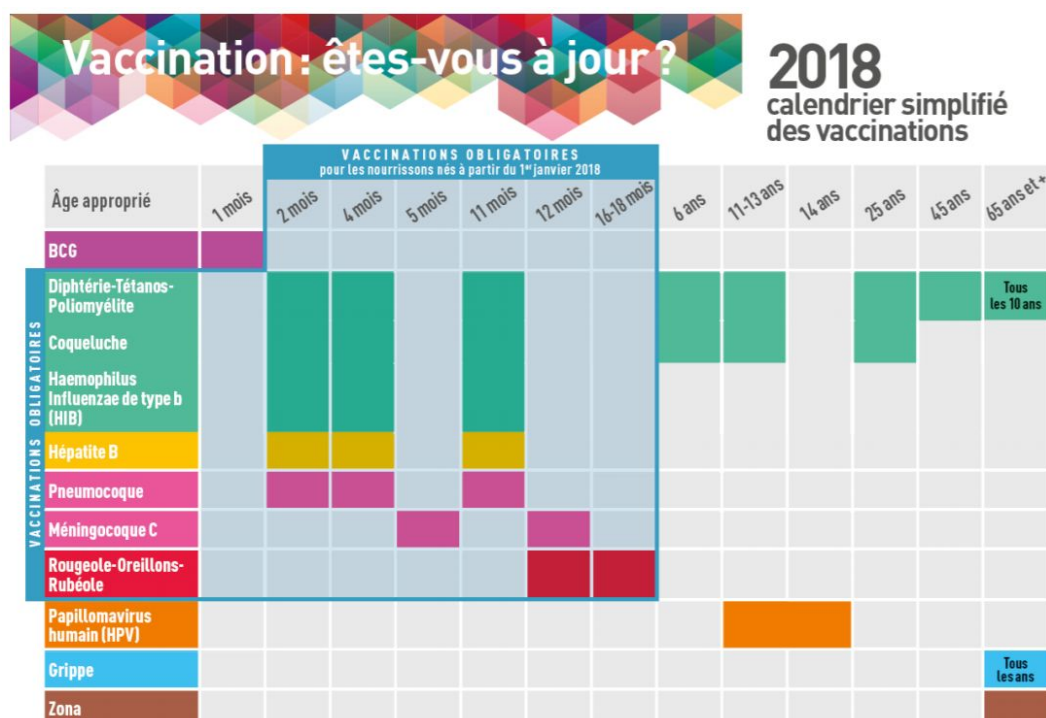
- Sont évitées annuellement :
 - + de 1000 hépatites aiguës
 - près de 3000 infections
 - + de 100 à 300 infections chroniques
 - environ 5 hépatites fulminantes
- Ont été évitées depuis entre 1994 et 2007 environ :
 - 8000 hépatites aiguës
 - 20 000 infections
 - 1000 à 2000 infections chroniques
 - 40 hépatites fulminantes
- Potentiel de **doublement de l'impact** de la vaccination par une augmentation de la couverture

♦ **La politique vaccinale**

Politique vaccinale = déterminée par chaque pays. Repose sur à la fois l'épidémiologie des maladies et sur l'efficacité des vaccins.

Les **OBJECTIFS** de la vaccination :

- Éviter à la personne vaccinée une infection **aiguë** et ses conséquences parfois graves : *Grippe, méningite, hépatite A, rougeole...*



SESA - Lutte contre les idées reçues concernant les vaccins | R.Germi

⇒ Avec tous ces vaccins...on va affaiblir notre système immunitaire

Pas hésiter à rappeler le **principe** de la vaccination, avec des mots simples (*voir les 1er cours*) au contraire ça renforce et stimule le système immunitaire = + on s'entraîne meilleur on est sport, musique... vaccination

- **mémoire immunitaire** ≈ **mémoire photographique** → reconnaissance plus rapide + armes adaptées
- On rencontre des milliers de micro organismes par jour par voie orale, cutanée/muqueuse, sanguine (blessures, coupures), voie digestive... à chaque contact on développe une immunité contre ces micro organismes
- Capacité immune d'un nourrisson : **peut répondre à 10 000 vaccins simultanément**
- Les **11** vaccins obligatoires n'occupent que **0,1%** de ses lymphocytes

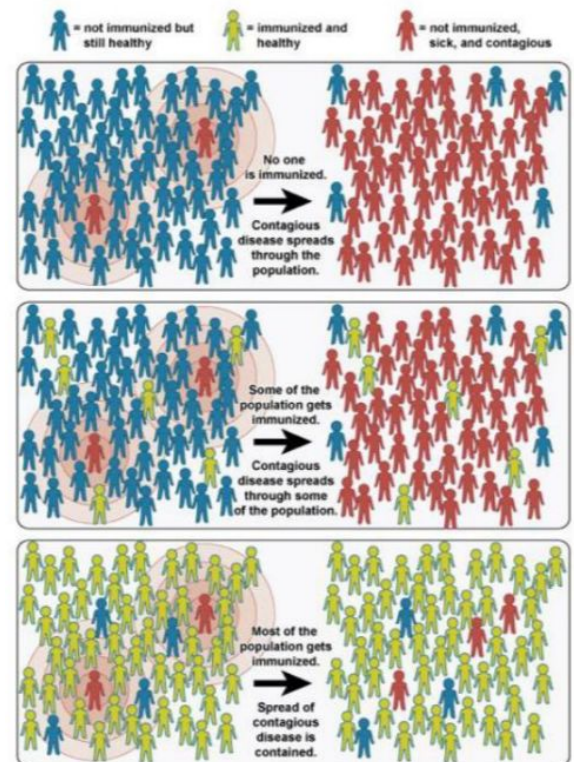
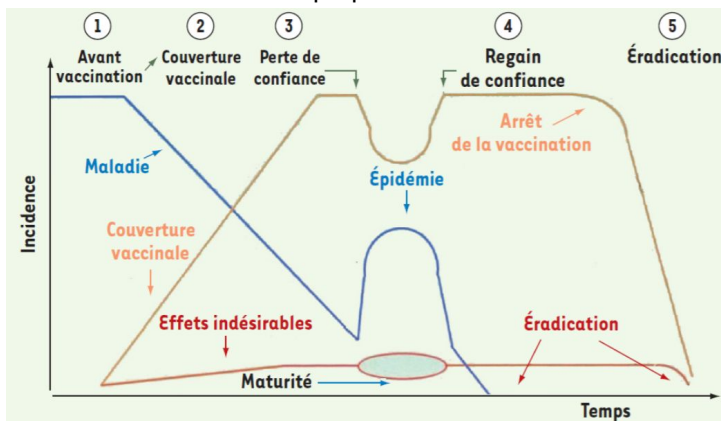
⇒ Je ne veux pas vacciner mes enfants contre des maladies qui ont disparues !!

Seule maladie infectieuse **éradiquée** = **variole** → vaccination levée
Les autres ont disparues dans certains pays mais existent encore !
Maladie non éradiquée : arrêt de la vaccination provoque la **réapparition** de la maladie (*Ex : rougeole 2009 2018*)

Notion de **protection collective** "concept of herd immunity" →

Mener une action de prévention c'est subir des contraintes pour qu'il ne se passe rien !

« le vaccin victime de son propre succès » :



⇒ Je préfère acquérir mon immunité naturellement sans utiliser les vaccins.

Maladie parfois moins immunisante que vaccin (ex : **tétanos**)

Voici les risques encourus pour une immunité naturelle : beaucoup plus importants que les risques encourus par la vaccination

Séquelles et décès = 1 pour 2,5 à 1 pour 9000

A rapporter au seul événement indésirable grave qu'est l'**anaphylaxie** : fréquence de survenue 1/ pour 100 000 à 1 000 000

Morbidité et mortalité annuelles aux États-Unis avant l'introduction d'une vaccination spécifique

Maladie	Cas cliniques	Séquelles	Décès
Rougeole	900 000	300	200-400
Coqueluche	600 000	40	200-300
Rubéole	300 000	750	10-15
Oreillons	75 000	5	3-5
Hépatite B	25 000	7 000	1 000-1 500
Poliomyélite	14 000	4 500	100-400
Haemophilus b	5 000	1 500	300-600

Source : Centers for Disease Control, États-Unis.

⇒ **Mon enfant est trop jeune pour se faire vacciner... je ferai ses vaccins plus tard !**

Ici, 2 réponses à apporter :

1. Les bébés sont trop **fragiles** et leur système immunitaire n'est pas assez mature ??

L'enfant est exposé à une avalanche de microbes dès sa naissance. Son système immunitaire est **ultra stimulé**. Baisers d'une maman → exposition du bébé à de très nombreux AG, bien plus que dans les vaccins qu'il reçoit : chaque millilitre de salive contient + de 100 millions de bactéries.

2. Système immunitaire n'est **pas assez mature** et vaccin **inefficace** ??

Vaccins de la petite enfance et calendrier vaccinal = **adaptés** à l'âge et à la capacité de réponse d'un bébé

Les vaccins peuvent être **efficaces dès la naissance** : vaccination contre **hépatite B** : possible dès la naissance si risque (mère infectée)

Vaccin ROR = 1ère injection qu'à **12 mois** → car non adapté aux petits, sont plus efficaces à partir de 12 mois

Pourquoi réaliser les vaccinations au plus tôt ? C'est l'âge où :

- Ils sont les **plus exposés** : vie en communauté en crèche, nounous... échanges de salives, et les bébés excrètent plus de micro organismes...
- les maladies sont les plus **graves** et les plus **mortelles**

Cette remarque = « Mon enfant est trop petit et a les côtes trop fragiles. Je le mettrai dans son siège auto avec sa ceinture plus tard... »

⇒ **Les vaccins c'est dangereux pour la santé.**

Les effets indésirables ou non voulus de la vaccination : les principaux = Désagréments **mineurs** :

- **Fièvre** peu élevée pendant quelques jours
- **Douleur** au point d'injection
- **Éruption cutanée**
- **1** événement indésirable **grave** reconnu : **Anaphylaxie** = rare ++ il est même difficile de donner une fréquence précise : 1/100 000, 1/1 000 000

Comparer avec un autre risque : **Avoir un accident de voiture** : 1/85 / **Être frappé par la foudre** : 1/60 000 / **Être écrasé dans un tremblement de terre** : 1/150 000

→ Risque bien plus faibles que les risques liés à la maladie

Rappeler aussi que les EI listés dans les notices correspondent aux déclarations faites mais ne **préjugent pas** du lien de **causalité**.

⇒ **Je n'ai pas confiance en les vaccins : ils contiennent de l'aluminium et d'autres produits chimiques toxiques**

Tous les vaccins ne contiennent pas d'aluminium

Ex de vaccin qui en contiennent : **vaccin anti-diphtérique**, **vaccin antitétanique** → pas d'observation de hausse de maladies neuro suite à la vaccination

Ex de vaccin qui n'en contiennent pas : **vaccin anti-grippal**

L'aluminium : **améliore l'efficacité** des vaccins et **diminue les effets indésirables**. Permet de réduire

- Les concentrations d'Ag
- Le nombre d'injections
- A aussi permis d'avoir une efficacité de certains vaccins chez les immunodéprimés et les nourrissons

L'aluminium n'est toxique qu'à **très forte dose**

Quantité d'aluminium par vaccin : **0,2-0,5 mg** (max = 0,85 mg)

Apport journalier d'aluminium par VO : **3-5 mg**

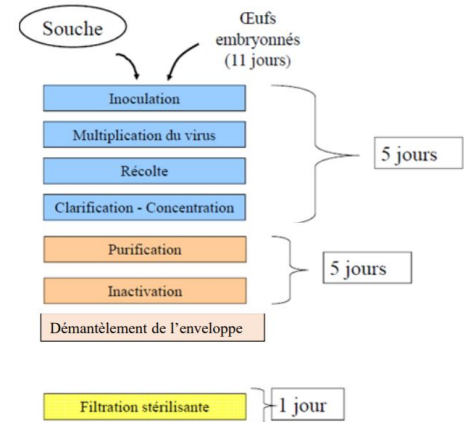
Les sources d'aluminium dans notre environnement

- **Aliments** : origine naturelle ou contamination par les ustensiles ou les emballages, mode de cuisson
- **Déodorants** (pierre d'alun, constituée exclusivement d'Al),
- **Eau**,
- **Exposition professionnelle, accidentelle**

Les autres « produits chimiques » : ex **vaccin anti-grippal**

Restes de la **production**, **traces** possibles de :

- protéines d'oeuf (**ovalbumine**) : vaccin cultivé dans des oeufs
- **neomycine** : ATB dans la culture pour éviter la contamination bactérienne
- **formaldéhyde** : pour inactiver le virus
- **détergent** (octoxynol-9 désoxycholate de sodium, bromure de cétyltriméthylammonium polysorbate 80) : permettent le démantèlement de l'enveloppe



La réglementation ordonne de le spécifier dans la **notice**.

⇒ J'ai lu sur internet que les vaccins peuvent provoquer la sclérose en plaques

Vaccin contre l'hépatite B / sclérose en plaques

= Polémique franco française (dans d'autres pays, d'autres vaccins sont incriminés : en Angleterre ROR et autisme)

Vaccination massive intervenue :

- à un âge où **apparaissent** les **1ers** symptômes de la SEP (adolescent/jeune adulte),
- à une époque où le **diagnostic** de la SEP a été nettement amélioré
- à une époque où SEP reconnue comme maladie longue durée
- = un vaccin disculpé

Attention aux statistiques « grand publique » :

Exemple de contre vérité :

- La grande majorité des enfants ayant reçu le vaccin contre la rougeole perdent leurs dents. La perte des dents est due à ce vaccin !!!
- 90% des enfants autistes ont reçu un ours (le vaccin) en peluche étant petit. Les ours (le vaccin) en peluche provoquent l'autisme !!!

⇒ l'année dernière j'ai fait le vaccin et 2 mois plus tard j'ai attrapé la grippe!! Ce n'est pas vraiment efficace la vaccination, je ne vais plus faire aucun vaccin!!!

- Efficacité des vaccins : ne pas hésiter à donner des chiffres sur la diminution des cas/de la mortalité



Un vaccin disculpé !

Lancet (Fév 2000)
Sadovnick AD et coll. Lancet 2000 : 549-550
« Vacciner contre l'hépatite B n'a pas d'impact sur la survenue d'une sclérose en plaques »

OMS (Oct1998)
« La suspension de la vaccination ne se justifie pas sur le plan scientifique »

Nature Medecine (Sept 1999)
« Dans aucune tranche d'âge, la vaccination n'augmente le risque de survenue d'affection démyélinisante »

VHPB (Oct 1998)
« Pas d'association causale entre la vaccination contre l'hépatite B et les maladies démyélinisantes du SNC, y compris la SEP »

La Presse Médicale (Avr 2000)
Soubeyrand B et coll. LPM 2000 : 775-780
« Pas de relation causale entre les PDSNC rapportées et une vaccination au préalable avec GenHevac B »

NEJM (Fév 2001)
Confavreux C et coll. NEJM 2001 : 319-326
« Pas de risques de poussées à la suite d'une vaccination chez les patients atteints de SEP »

NEJM (Fév 2001)
Ascherio A et coll. NEJM 2001 : 327-333
« Absence d'association entre vaccination HB et survenue de SEP »

Parler de **l'éradication de la variole** et de la **disparition de la polio** dans les pays industrialisés.
Immunité de groupe et couverture vaccinale importante +++ **Ex de la rougeole**

L'efficacité à 100% n'existe pas = c'est pourquoi on fait des rattrapages dans le calendrier vaccinal

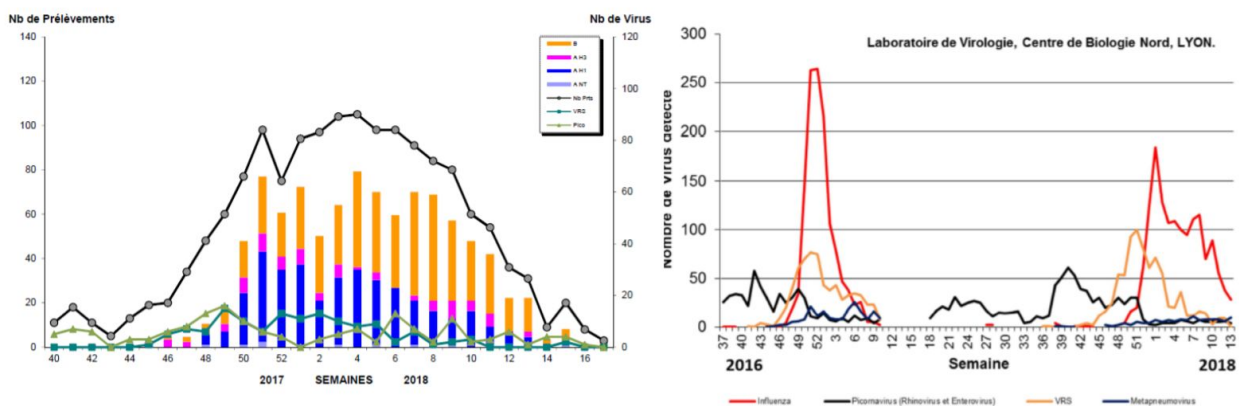
La plupart des vaccins sont efficaces à + 90%, d'autres moins (**grippe : 60-80% selon les années**)

Ces vaccins moins efficaces ne permettent pas la maladie de survenir, permettent au moins de **diminuer les symptômes et les complications**

→ faire passer le message : ex du matériel de sécurité (airbag, ceinture... diminuent les risques sans empêcher l'accident)

Concernant le vaccin contre la **grippe** :

- **Au moins 15j** pour obtenir une protection **optimale** qui durera toute la saison
- Vaccination dès qu'il est disponible : il n'est jamais trop tôt ! Au plus tôt **avant le début de l'épidémie**
- Infection par une **souche** grippale **non comprise** dans le vaccin possible : il est possible d'être malade. Le vaccin protège contre 3 ou 4 principales souches, pas contre toutes souches circulantes
- Infection par un **virus « respiratoire »** qui **n'est pas le virus de la grippe** : symptômes similaires, sévissent sous forme d'épidémie hivernales comme la grippe.



⇒ **Les vaccins sont un business lucratif pour les industries pharmaceutiques**

Oui, probablement, comme toute entreprise

Traiter est plus lucratif que d'éradiquer, et de vacciner.

A qui profite la polémique anti-vaccination ? Sur des sites antivax on propose des traitements non médicamenteux, de médecines parallèles à des prix faramineux...

Conclusion : Promouvoir la vaccination / Auprès des indécis (pas des fanatiques) /
Expliquer **simplement** / Lutter contre les **idées reçues**